PROVÕES - M1 (REUMATOLOGIA, ORTOPEDIA, CIRURGIA PLÁSTICA, FISIATRIA E GERIATRIA)

QUESTÃO 1. JCA, 47 anos, sexo feminino, procura o médico com queixas de dor difusa em todo o corpo, sono não reparador, labilidade emocional, fadiga intensa e déficit de memória e concentração. Negava outras queixas. Comorbidades: síndrome do intestino irritável e enxaqueca. Exame físico: sem sinais de artrite, com dor à palpação em toda a musculatura dos MMSS, MMII e rem toda a região da coluna dorsal e lombar. Exames complementares: Hemograma e TSH normais, provas de atividade inflamatória (VHS e PCR) normais e Fator reumatoide negativo. Considerando a principal hipótese diagnóstica, assinale o tratamento medicamentoso mais adequado:

A. Prednisona 20 mg / dia.
B. Hidroxicloroquina 400 mg/dia.
C. Metotrexato 15 mg/semana.
D. Pregabalina 75 mg / dia.

QUESTÃO 2. VSB, 67 anos, sexo feminino, procura o médico na unidade básica de saúde, assintomática, para mostrar seu exame de densitometria óssea, que descrevia os seguintes achados: Coluna lombar (L1-L4) TS = -2,1; fêmur total TS = -2,3; Colo do fêmur =-1,9. Assinale o diagnóstico correto da paciente:

A. Osteoporose em coluna e fêmur total, osteopenia em colo do fêmur.
B. Osteoporose em todas as regiões.
C. Osteopenia em todas as regiões.
D. Osteopenia em coluna e fêmur total, osteoporose em colo do fêmur.

QUESTÃO 3. NAS, 49 anos, sexo masculino, procura o pronto-socorro para tratamento de entorse de tornozelo ocorrida durante prática esportiva. Comorbidades: tratamento de úlcera péptica há cerca de dois anos. Considerando os antecedentes do paciente, assinale o AINE mais adequado para o seu tratamento:

A. Nimesulida.
B. Etoricoxibe.
C. Ibuprofeno.
D. Meloxican.

QUESTÃO 4. Em pacientes gestantes, com lúpus eritematoso sistêmico, em vigência de quadro confirmado de lúpus neonatal com bradicardia fetal importante, com anti-Ro no sangue materno positivo em altos títulos, é necessário o uso de um corticosteróide capaz de atravessar a barreira placentária em altas concentrações. Neste caso, deve-se dar preferência a:

A. Dexametasona.
B. Prednisolona.
C. Prednisona.
D. Pulsoterapia com metilprednisolona.

QUESTÃO 5. Na displasia do desenvolvimento do quadril, podemos dizer que:

A. É mais comum no sexo masculino
B. É mais comum em casos de gestação com apresentação cefálica
C. É mais comum em casos de gestação com apresentação córmica
D. É mais comum em casos de gestação com apresentação pélvica

QUESTÃO 6. Um adulto tem uma queimadura em casa enquanto cozinhava. Chega ao hospital com a lesão na mão e antebraço com as seguintes características: Indolor, de aspecto nacarado e sem bolhas. Esta queimadura é classificada quanto a profundidade em?

A. Queimadura de primeiro grau
B. Queimadura de segundo grau superficial
C. Queimadura de segundo grau profunda
D. Queimadura de terceiro grau

QUESTÃO 7. Uma mulher de 75 anos, portadora de hemiplegia Direita pós AVCH foi reabilitada por um equipe multiprofissional por 1 ano, tendo evoluído de uma condição de dependência total em todas as atividades para uma condição de independência para autocuidados e dependência parcial para marcha e transferências. Após a alta deste

Centro de Reabilitação, procurou outro serviço de reabilitação com objetivo de obter maior destreza para atividades bimanuais, pois decidiu dedicar aos trabalhos artesanais para obter seu sustento. Assinale a correta:

A. O programa de reabilitação não atingiu seu objetivo
B. Os autocuidados são o principal objetivo do programa de reabilitação
C. Como a paciente é hemiplégica, ela não vai conseguir destreza para atividades bimanuais, por isso necessita na verdade de uma abordagem psicológica para trabalhar o limite de seus ganhos funcionais.
D. A mudança de objetivos do paciente durante o programa de reabilitação é frequente, e a equipe deve estar atenta para isso, para não frustrar as expectativas do paciente.

QUESTÃO 8. As úlceras por pressão podem se desenvolver em pacientes acamados, com pouca mobilidade e/ou paraplégicos e tetraplégicos. Em todos eles, o fator mais importante na formação dessas úlceras é a:

A. Pressão direta
B. Anemia
C. Hipoproteinemia
D. Insensibilidade na área envolvida.

QUESTÃO 9. Na fratura de diáfise de úmero a lesão neurológica mais comum é do nervo:

A. Ulnar
B. Radial
C. Mediano
D. Musculocutâneo

QUESTÃO 10. Em relação às infecções osteoarticulares, marque a correta:

A. podem ser divididas em aguda, crônica e crônica agudizada.
B. o germe mais comum é o Streptococcus do tipo B, mas a incidência de cada germe varia muito de acordo com a idade do indivíduo (Salmonela na anemia falciforme, Gram negativo no RN, pseudomonas nos usuários de drogas EV).
C. a mais comum é a osteomielite aguda hematogênica, que acomete mais crianças, e ocorre normalmente a implantação da bactéria na região metafisária do osso na região de circulação sinusoidal (fluxo lento).
D. a osteomielite crônica se caracteriza pela presença do sequestro ósseo (osso morto), e normalmente é tratada com antibioticoterapia endovenosa.

QUESTÃO 11. Paciente sexo feminino, 42 anos, sedentária, vem apresentando lombalgia há 3 meses. A dor piora a movimentação, não tem irradiação. Nega alterações esfincterianas, perda de peso, febre ou déficit de força. A conduta médica inicial deve ser:

A. Solicitar Ressonância de coluna lombar, por ter essa queixa de forma persistente e crônica
B. Encaminhar a reabilitação para melhora da flexibilidade muscular, fortalecimento muscular e orientações ergonômicas.
C. Prescrever anti-inflamatório associado a miorrelaxante por 6 semanas.
D. Provavelmente se trata de hérnia discal, pela característica da dor.

QUESTÃO 12. São características de uma estabilidade absoluta:

A. Redução anatômica, consolidação secundária, usada em fraturas diafisárias, expõe o foco de fratura.
B. Não expõe o foco de fratura, consolidação primária, usada em fraturas articulares, calo ósseo exuberante.
C. Redução anatômica, consolidação primária, usada em fraturas articulares e expõe foco de fratura.
D. Não expõe o foco de fratura, consolidação secundária, usada em fraturas diafisárias, calo ósseo exuberante.

QUESTÃO 13. Os sintomas de um paciente em tratamento paliativo devem ser avaliados periodicamente e registrados de forma acessível para todos os integrantes da equipe.

A Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton (ESAS) é possível de ser utilizada para avaliar vários sintomas, sendo acessível para toda a equipe. Nela cada sintoma e avaliado

A. Em uma escala de 6 pontos, sendo 0 a ausência de sintomas e 5 pontos para a maior intensidade.
B. Em uma escala de 10 pontos, sendo 1 ponto para a menor intensidade e 10 para a maior.
C. Através de uma classificação qualitativa de sintoma ausente, leve, moderado, intenso e muito intenso.
D. Através de 5 representações de faces, sendo a sorridente para a ausência de sintomas e a chorando para a maior intensidade.

QUESTÃO 14. A esposa relata que o marido de 82 anos, advogado aposentado, vem apresentando, há dois anos, distúrbio de atenção e alucinações visuais bem detalhadas, episódios de esquecimento, especialmente para informações recentes, chegando a se perder em trajeto usual. Simultaneamente, ela notou que apresentava dificuldades para deambular com lentidão de marcha e quedas frequentes. Ao exame físico, observa-se bradicinesia, tremores de extremidades e rigidez muscular.
AGA:
Timed Get Up and Go Test (TGUG) - 27 segundos
Barthel - 75 pontos
Escala de Depressão Geriátrica - 28 pontos
Pfeffer - 24 pontos
Mini Exame do Estado Mental - 8 pontos

Qual é o diagnóstico mais provável?

A. Demência por corpúsculos de Lewy
B. Demência na doença de Parkinson
C. Demência frontotemporal.
D. Demência vascular

QUESTÃO 15. Mulher, de 72 anos, procura atendimento médico em pronto socorro com queixa de dor intensa há 2 semanas, em tórax anterior direito, além de dispneia. Refere que recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão há 6 meses e está em seguimento pelos cuidados paliativos. Está fazendo uso de paracetamol sem controle da dor. Nega febre. Ao exame físico e radiológico foi descartado derrame pleural ou atelectasia, verificando-se grande massa tumoral em pulmão direito. A paciente está em regular estado geral, com frequência respiratória de 28 i.p.m., saturação de O2 de 95%, dor atual de intensidade 8 em 10. Qual seria a melhor opção para controle de sintomas neste momento?

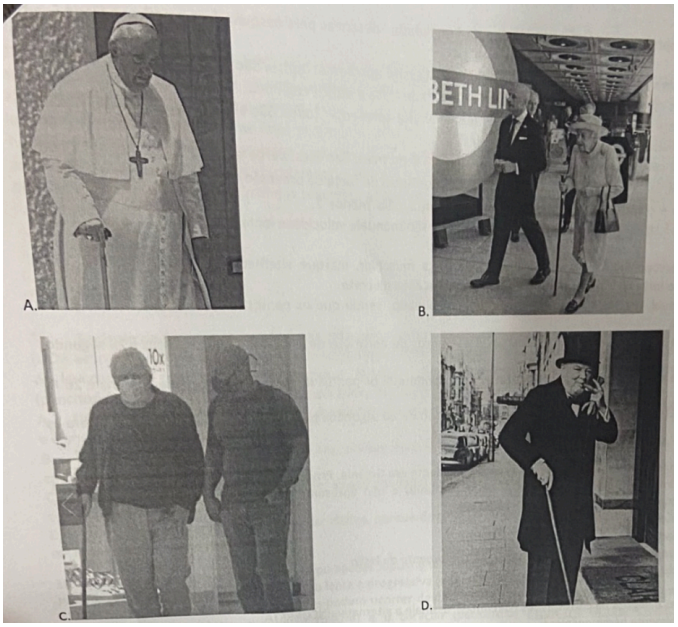
A. Tramadol
B. AINE
C. Morfina
D. Dipirona

QUESTÃO 16. Um homem de 92 anos de idade, funcionalmente independente e com cognição preservada, foi admitido numa unidade de terapia intensiva em decorrência de queda do estado geral e piora do padrão respiratório, tendo sido firmado o diagnóstico de broncopneumonia. Instituído o tratamento com antimicrobiano, cursou com significativa melhora clínica. Entretanto, no terceiro dia de internação, apresentou mudança súbita de seu estado de consciência, com flutuação entre a vigília e pronunciado rebaixamento. Além disso, verificou-se desatenção persistente. Qual é provável diagnóstico?

A. Acidente vascular encefálico.
B. Síndrome demencial.
C. Coma por sepsis.
D. Delirium

QUESTÃO 17. Pessoas famosas também podem necessitar de usar dispositivos auxiliares de marcha (DAM). Entretanto, eles também podem usa-los de forma inadequada, aumentando o risco de lesões e até mesmo de quedas. Nas imagens abaixo, quatro figuras públicas estão usando bengalas: Sua Santidade o Papa Francisco (a), Sua Majestade a Rainha Elizabeth II (b), o ator Marco Nanini (c) e o premier inglês Sir

Winston Churchill (d). Marque a alternativa em que o famoso está usando corretamente a bengala.



QUESTÃO 18. Mulher, de 82 anos de idade, diabética, hipertensa, portadora de osteoartrite de joelhos, retinopatia diabética com baixa visão e polineuropatia. Estava em avaliação devido a perda 6% do peso corporal nos últimos 6 meses com perda da força e consequente dificuldade de subir escadas e carregar uma sacola de 5 Kg. Foi admitida no pronto-socorro após queda no quintal de casa, apresentando escala de coma de Glasgow 15 e sinais vitais estáveis. Ela foi encontrada desacordada, com ferimento corto-contuso na face, e retomou a consciência dentro da ambulância. Recentemente, havia fraturado o punho também em razão de uma queda. Fazia uso de omeprazol, metformina, hidroclorotiazida, enalapril, alprazolam e diclofenaco, este último em função da osteoartrite. Durante o atendimento, foi constatada uma fratura intertrocantérica do quadril esquerdo. Marque a alternativa que contenha os principais riscos para as quedas dessa paciente:

A. Baixa visão, polineuropatia, uso de omeprazol, osteoporose, osteoartrite e hipertensão.
B. Osteoporose, hipertensão, baixa visão, uso de dois anti-hipertensivos e de metformina.
C. Baixa visão, polineuropatia, perda de peso e possível sarcopenia, polifarmácia e uso de alprazolam.
D. Andar no quintal, osteoartrite, polineuropatia, uso de diclofenaco, hidroclorotiazida e de alprazolam.

QUESTÃO 19. Um paciente de 77 anos de idade compareceu à consulta com sua filha, que relatou que seu pai apresentou episódios de esquecimento e desorientação temporal. Referiu, também, que ele não conseguia mais realizar atividades como controlar as finanças, dirigir e sair de casa sozinho. Relatou que o quadro iniciou há cerca de 18 meses e piorou progressivamente. O paciente não apresentava dificuldades motoras e tinha a visão e a audição adequadas. Mantinha-se capaz das atividades básicas da vida diária, como ir ao banheiro e alimentar-se sem ajuda. Ele era militar aposentado, com ensino médio, fazia uso de losartana 50 mg. A filha trouxe um exame recente de tomografia de crânio com laudo dentro da normalidade. Qual é o próximo passo?

A. Solicitar exames laboratoriais, eletroencefalograma e ressonância magnética do crânio.
B. Solicitar exame do líquor para dosagem de beta-amilóide e de proteína Tau e PET-CT neurológico.
C. Aplicar testes e escalas para avaliação cognitiva e funcional e solicitar exames laboratoriais.
D. Solicitar avaliação neuropsicológica e PET-CT com marcardor de beta-amiloide.

QUESTÃO 20. Paciente do sexo masculino, 72 anos de idade, independente, faz controle adequado de suas doenças crônicas (depressão, hipertensão, dislipidemia, doença arterial coronariana e hipertrofia prostática benigna) com acompanhamento médico frequente. Tem acompanhamento cardiológico, urológico e psiquiátrico. Faz uso diário de losartana, atenolol, hidroclorotiazida, AAS, sinvastatina, doxazosina, fluoxetina,

amitriptilina e clonazepam. Sobre os medicamentos pode-se dizer que:

A. Não se trata de polifarmácia, pois todos são prescritos por médicos para as suas doenças crônicas.
B. Trata-se de polifarmácia e o paciente faz uso de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos.
C. A prescrição não é inapropriada, pois o paciente tem doenças que justificam o uso de todos os medicamentos.
D. Trata-se de polifarmácia, mas os medicamentos são todos apropriados para condições do paciente.

QUESTÃO 21. Assinale a alternativa que apresenta critérios do Fenótipo da Fragilidade descritos pela pesquisadora americana Linda Fried colaboradores (2001).

A. São 5 sinais e sintomas e para ser considerado frágil o paciente necessita apresentar todos. São eles: perda maior que 10% da musculatura; velocidade lenta da marcha; exaustão subjetiva, baixa atividade física e déficit cognitivo.
B. São 3 sinais e sintomas e para ser considerado frágil o paciente necessita apresentar todos. São eles: sarcopenia evidenciada por bioimpedância; baixa atividade física e sensação de exaustão subjetiva.
C. São 5 sinais e sintomas e é considerado frágil aquele que apresenta 3 ou mais. São eles: perda de peso maior que 4,5 Kg em 1 ano; velocidade lenta da marcha; inatividade física; exaustão subjetiva e redução da força de preensão manual.
D. São 3 sinais e sintomas e é considerado frágil aquele que apresenta pelo menos 2. São eles: perda peso maior que 5 kg em 1 ano; redução da força de preensão manual velocidade lenta da marcha.

QUESTÃO 22. Para o diagnóstico de sarcopenia é necessário avaliação da força muscular, marque alternativa que contenha uma forma recomendada para a medida de força na prática clínica e os respectivos pontos de corte.

A. Força de preensão manual, medida através de dinamômetro validado, sendo que os pontos de cortes são de 16 Kg para mulheres e 27 kg para homens.
B. Levantar-se e sentar-se 5 vezes consecutivas, sendo que os pontos de corte são de 15 segundos para homens e 20 segundos para mulheres.
C. Força muscular medida por dinamometria isocinética lombar, sendo que os pontos de corte são 30 Kg para homens e 20 Kg para mulheres.
D. Timed Get Up and Go (TGUG), sendo que os pontos de corte são de 20 segundos para os homens e de 30 segundos para as mulheres.

QUESTÃO 23. Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, cor branca e residente em Goiânia. Procurou médico por apresentar nódulo na coxa direita. Ao exame por imagem o nódulo media 10,0 cm é profundo e não apresenta envolvimento neurovascular. Diante desses achados é correto afirmar:

A. O diagnóstico mais provável é lipossarcoma
B. A lesão deve ser biopsiada
C. Recomenda-se acompanhar o paciente para verificar se há crescimento da lesão
D. É necessária a realização de imuno-histoquímica

QUESTÃO 24. Em relação aos tumores malignos de partes moles (sarcomas), assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. As metástases são geralmente hematogênicas
B. A ressonância magnética não é precisa na definição do tipo histológico
C. São mais frequentes em idosos
D. Localização em retroperitônio é associada a melhor prognóstico

QUESTÃO 25. Paciente do sexo feminino, cor branca e 25 anos de idade. Procurou médico por apresentar aumento de volume na região do joelho direito e dor local intermitente. Ao exame físico apresentava limitação dos movimentos. A radiografia evidenciou lesão tibial epifisária, derrame articular, fratura patológica, rarefação óssea, fina trabeculação e limites nítidos. Na macroscopia da peça cirúrgica evidenciou-se lesão volumosa, densa, avermelhada e com lacunas hemorrágicas. Na microscopia a neoplasia é constituída por tecido com, rica vascularização e grande número de células gigantes multinucleadas. O diagnóstico **menos provável** é:

A. tumor de células gigantes
B. cisto ósseo aneurismático
C. tumor marrom do hiperparatiroidismo
D. sarcoma de Ewing

QUESTÃO 26. Um homem de 60 anos com histórico de gota crônica é iniciado em tratamento com alopurinol para reduzir os níveis de ácido úrico. Após duas semanas de tratamento, o paciente retorna ao consultório médico com queixas de erupção cutânea pruriginosa, acompanhada de febre e mal-estar geral. A erupção cutânea é maculopapular, envolvendo o tronco e as extremidades. O médico suspeita de uma reação adversa ao alopurinol. Qual das seguintes opções é a reação adversa mais provável associada ao uso do alopurinol neste paciente?

A. Síndrome de Stevens-Johnson
B. Neutropenia
C. Hiperuricemia
D. Trombocitopenia

QUESTÃO 27. Durante estímulos de corpos estranhos ou lesões, citocinas pró-inflamatórias intensificam a produção de prostaglandinas e COX-2. Etanercepte e Adalimumab são utilizados no tratamento da Artrite Reumatoide, por serem antagonistas de uma das principais citocinas pró-inflamatórias envolvidas na ativação dessas enzimas. A explicação acima, trata-se de qual citocina?

A. IL-2
B. IL-6
C. IL-1
D. TNF-alfa

QUESTÃO 28. Uma mulher de 45 anos chega ao consultório médico com queixas de dor, rigidez e inchaço nas articulações, que vem se agravando ao longo dos últimos seis meses. A paciente relata que a rigidez matinal dura mais de uma hora e que as articulações afetadas incluem punhos, mãos e joelhos. Além disso, ela apresenta fadiga persistente e perda de peso não intencional. Exames laboratoriais mostram presença de fator reumatoide (FR) e anticorpos anti peptídeos citrulinados (anti-CCP) positivos. A velocidade de hemossedimentação (VHS) e a proteína C reativa (PCR) estão elevadas. Diante do quadro clínico e dos exames, o diagnóstico artrite reumatoide é estabelecido. O tratamento deve ser iniciado imediatamente para controlar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida da paciente. Qual das seguintes opções é a terapia farmacológica de escolha para o tratamento inicial da artrite reumatoide nesta paciente?

A. Infliximabe
B. Corticosteroides sistêmicos
C. Leflunomida
D. Metotrexato

QUESTÃO 29. Paciente de 66 anos, etilista de longa data, apresenta palidez cutânea e astenia. O hemograma apresenta anemia macrocítica (VCM acima dos valores de referência), Com Anisocitose (RDW elevado), com dacriócitos e Corpúsculos de Howell Jolly, acompanhado de leucopenia (com neutropenia relativa e absoluta, desvio a direita de Schilling e linfocitose relativa) e plaquetopenia (pancitopenia). Diante deste quadro, escolha a alternativa mais correta.

A. Devo dosar a vitamina B12, que deve dar abaixo dos valores re referência, pois é acausa mais comum de anemia no idoso etilista e com estas características no hemograma

B. Devo dosar a ferritina, que deve dar alta, porque deve se tratar de um anemia da doença crônica, a mais frequente no idoso e com estas características no hemograma
C. Devo dosar o ácido fólico, que deve dar abaixo dos valores de referência, pois é a causa mais comum de anemia no idoso etilista e com estas características no hemograma
D. Devo dosar a v Ferritina, que deve dar abaixa, porque deve se tratar de um anemia ferropriva a mais frequente no idoso e com estas características no hemograma

QUESTÃO 30. O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES ou apenas lúpus) é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva (em meses) ou mais rapidamente (em semanas) e variam com fases de atividade e de remissão. As manifestações podem ocorrer devido à inflamação na pele, articulações (juntas), rins, nervos, cérebro e membranas que recobrem o pulmão (pleura) e o coração (pericárdio) (https://www.reumatologia.org.br/doencas/principais-doencas/lupus-eritematoso-sistemico-les)

Em 2012, foram publicados os novos critérios de classificação do LES, denominado critérios do SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics). Os11 critérios da classificação anterior (ACR de 1997) foram substituídos por 17 critérios, sendo que é preciso ter 4 ou mais critérios, sendo que destes quatro, pelo menos 1 tem que ser Clínico/Laboratorial e pelo menos 1 tem que ser Imunológico, para se receber o diagnóstico de LES. São quatro critérios em Dezessete (levando a 57.120 formas clínicas de Lupus). Diante disto, responda:
Quais são os exames abaixos que fazem parte destes critérios Imunológicos para diagnóstico de Lupus? (Escolha a melhor resposta)

A. FAN (positivo em mais de 98% dos casos), Anti-DNA dupla hélice (Anti-DNAds), Anti- Sm, Anticorpos Antifosfolipídio, Hipocomplementemia e Coombs direto positivo.
B. Hemograma, contagem de reticulócitos, fosfatase alcalina, bilirrubinas total e frações, desidrogenase lática (LDH), uréia, creatinina e eletrólitos (cálcio, fósforo, sódio, potássio e cloro).
C. Hemograma, podendo apresentar Anemia hemolítica, Leucopenia ou linfopenia e Plaquetopenia) e na Urina, Proteinúria e Cilindros hemáticos no EAS-Urina Tipo I.
D. Hemograma, velocidade de hemossedimentação (VHS), proteína C reativa, complementos (CH50, C3 e C4), albumina, proteinúria de 24 horas, VDRL e avaliação de autoanticorpos (FAN, anti-DNA nativo, anti-Sm, anticardiolipina IgG e IgM, anticoagulante lúpico, anti-La/SSB, anti-Ro/SSA e anti-RNP).

QUESTÃO 31. Correlacione adequadamente as colunas, cada anticorpo com a doença em que ele mais frequentemente está positivo:
1.Anti-histonas
2.c-ANCA
3. Anti-RNP
4. Anti-DNA nativo
5.Anti-SSA/RO

() Doença Mista do Tecido Conjuntivo
() Nefrite Lúpica
() LES induzido por drogas
() Granulomatose com Poliangeite-ex de Wegener
() Síndrome de Sjögren
A sequência correta está em:

A. 1,2,3,4,5
B. 1,5,4,2,3
C. 3,4,1,2,5
D. 5,1,2,4,3

QUESTÃO 32. Estreitamento difuso do espaço articular, erosões marginais, osteopenia e edema de tecidos moles periarticulares são achados de imagem sugestivos de:

A. Osteoartrite
B. Pioartrite
C. Artrite Reumatóide
D. Gota

QUESTÃO 33. Estreitamento localizado do espaço articular, esclerose subcondral, osteófitos e cistos subcorticias são achados de imagem sugestivos de:

A. Osteoartrite
B. Pioartrite
C. Artrite Reumatóide
D. Gota

QUESTÃO 34. Erosão marginal com borda saliente, preservação relativa do espaço articular, ausência de osteopenia, massa de tecido mole assimétrica são achados de imagem sugestivos de:

A. Osteoartrite
B. Pioartrite
C. Gota
D. Artrite Reumatóide

QUESTÃO 35. Quedas são frequentes entre os idosos. Sobre as adaptações que devem ser realizadas para preveni-las, marque a opção correta:

A. Uso de barras de apoio no vaso sanitário para que facilitem o ato de sentar e levantar.
B. Preferência pelo uso de sandálias e chinelos por serem mais fáceis de colocar e tirar e se adaptam melhor aos pés.
C. Subir em pequenos bancos (tamboretes) para pegar coisas em locais mais altos, evitando-se assim o esforço de esticar os braços.
D. Diminuir um pouco a iluminação dos cômodos mais usados na casa para evitar o ofuscamento.

QUESTÃO 36. Homem de 85 anos em uso de 6 medicamentos para tratamento de glaucoma, hipertensão arterial e depressão é atendido no pronto-socorro com história de que há 72 horas apresentava inversão de padrão do sono, desorientação e fraqueza. Há 24 horas está muito sonolento, não querendo alimentar-se. Foi levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Ao exame clínico, apresentava-se sonolento, desorientado, com FR de 28 irpm, FC de 88 bpm, PA de 110/70 mmHg, temperatura de 36,9o, SatO2 de 90% em ar ambiente, RCR, sem sopros, pulmões com estertores finos na base direita, abdome e membros sem alterações, pupilas isocóricas e fotorreagentes, tônus e força muscular normais, reflexos presentes e simétricos.
Escala de Glasgow:

	Avaliação	Pontuação
. Abertura ocular	Espontânea	4 pontos
	Por Estimulo Verbal	3 pontos
	Por Estimulo A Dor	2 pontos
	Sem Resposta	1 ponto
. Resposta verbal	Orientado	5 pontos
	Confuso (Mas ainda responde)	4 pontos
	Resposta Inapropriada	3 pontos
	Sons Incompreensíveis	2 pontos
	Sem Resposta	1 ponto
. Resposta motora	Obedece Ordens	6 pontos
	Localiza Dor	5 pontos
	Reage a dor mas não localiza	4 pontos
	Flexão anormal – Decorticação	3 pontos
	Extensão anormal - Decerebração	2 pontos
	Sem Resposta	1 ponto

Pontuação: 12
Qual é o diagnóstico mais provável?

A. Delirium
B. Depressão
C. Demência
D. Acidente vascular cerebral

QUESTÃO 37. Mulher de 68 anos, sem capacidade funcional, que não usava medicamentos regularmente, recebeu diagnóstico de hipertensão, sendo prescrita Hidroclorotiazida 25 mg pela manhã. Desde então, a paciente passou a ir mais vezes ao banheiro, algumas delas precedidas por perda urinária de pequena monta. Incomodada com essas perdas, ela procura outro serviço médico. Com o relato de incontinência urinária, é feita a prescrição de anticolinérgico para contrações não inibidas do músculo detrusor (Oxibutinina) na dose de 5 mg/dia. Poucos dias depois, a paciente apresenta insônia com períodos de confusão mental e agitação.

A filha, preocupada, leva a mãe em um pronto-socorro, onde é submetida a tomografia de crânio e radiografia do tórax, além de realizar hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, eletrólitos, sendo que todos os resultados são normais. O médico do pronto-socorro prescreve clonazepam para a insônia e agitação. A paciente piora, fica muito agitada a noite e pela manhã fica muito sonolenta. A filha então a leva de volta a o primeiro médico, que, entendendo o ocorrido, suspende todas as medicações, com reversão do quadro em 72 horas. Com base no caso apresentado, assinale a alternativa que indica o fenômeno pelo qual a paciente passou:

A. Polifarmácia
B. Prescrição em cascata
C. Superdosagem
D. Interações medicamentosas

QUESTÃO 38. Homem de 88 anos com demência avançada, se encontra acamado a mais de 2 anos, tendo tido 4
internações por pneumonia no último ano, foi internado hoje devido a outro quadro de pneumonia, tendo
uma queda grave do estado geral. Qual seria a conduta mais adequada para o paciente em questão?

A. Entubar paciente e dar droga vasoativa
B. Iniciar antibiótico, mandar paciente para UTI e depois avisar a família do ocorrido
C. Conversar com a família sobre o prognóstico reservado do paciente, esclarecendo que há uma doença incurável e oferecer cuidados paliativos oferecendo conforto ao paciente.
D. Conversar com a família para que eles definam as condutas (inclusive as invasivas) e orientar a equipe a seguir as vontades da família

QUESTÃO 39. Sobre a gastrostomia em pacientes com demência avançada.

A. A gastrostomia é sempre um procedimento indicado
B. Deve ser feita para evitar quadros de pneumonia devido a aspiração.
C. É indicada pois previne úlceras por pressão
D. Não deve ser indicada, pois não previne pneumonia, não melhora a nutrição e não previne úlceras de pressão

QUESTÃO 40. Uma filha chega com a mãe analfabeta em seu consultório, referindo que a mãe anda meio esquecida. A mãe refere que anda mesmo desatenta, e que não quer mais sair de casa, pois anda muito desanimada. A mãe apresentou pontuação normal em todos os testes com exceção no teste de escala para depressão o qual apresentou 7 pontos. Sobre o caso exposto podemos afirmar:

A. Paciente tem demência
B. A paciente tem a possibilidade de ter depressão
C. A paciente tem alzheimer pois ela apresentou baixa pontuação no MEEM (Ela deu a pontuação do MEEM, era 22)
D. A paciente está apenas com um quadro de envelhecimento normal

QUESTÃO 41. Assinale a alternativa correta que descreve o uso de medicações inapropriadas em pacientes idosos.

A. Betabloqueador em idosos com insuficiência cardíaca
B. Benzodiazepínicos em idoso com síndrome demencial
C. Antipsicóticos em baixas doses em idosos com delirium
D. Diuréticos tiazídicos para hipertensão arterial em idosos funcionais

QUESTÃO 42. Sobre a síndrome de fragilidade, é correto afirmar que:

A. O número de doenças crônicas que define se o idoso é portador de fragilidade
B. A incapacidade funcional é a principal causa de fragilidade, pois todos idosos frágeis são incapazes
C. A polifarmácia é um fator de risco independente da a síndrome de fragilidade

D. Dentre os critérios do fenótipo de fragilidade de Fried a presença do déficit cognitivo é o mais importante

QUESTÃO 43. Sexo feminino 82 anos queixa-se de fraqueza, dificuldade de subir escadas e carregar um saco de arroz. Refere também que tem tido dificuldades para levantar-se de uma cadeira e apresentou 2 quedas sem maiores consequências nos últimos 6 meses. No exame clínico, foi solicitada a sentar-se e levantar-se de uma cadeira 5 vezes seguidas. Gastou 38 segundos para fazer isso. Com base nos dados, qual é o diagnóstico que pode ser feito?

A. Sarcopenia definida
B. Síndrome de fragilidade
C. Provável sarcopenia
D. Provável fragilidade

QUESTÃO 44. Ainda sobre o caso anterior, qual será o próximo passo a ser realizado para o diagnóstico?

A. Medir força de preensão plantar
B. Medir velocidade de marcha
C. Solicitar dosagens de vitaminas
D. Quantificar a massa muscular

QUESTÃO 45. Sobre a cicatrização por segunda intenção, assinale a alternativa verdadeira:

A. Ela se verifica quando ocorre aproximação direta das bordas da ferida
B. Ela favorece o processo de remodelagem cicatricial
C. Normalmente ocorre nas lesões em que havia a presença prévia de infecção local, que após ser debelada, apresenta condições de fechamento
D. Ela ocorre quando a cicatrização acontece por processo biológico natural, sem síntese cirúrgica

QUESTÃO 46. Na Displasia de Desenvolvimento do Quadril;

A. O teste de Barlow é a manobra que detecta a luxação do quadril. Esta manobra é executada realizando a flexão e adução do quadril.
B. O teste de Galleazzi é sempre anormal mesmo na presença dessa patologia nos quadris bilateralmente
C. Independente da idade da criança, não deve ser realizado tratamento cirúrgico.
D. O calção gessado é sempre usado nas luxações teratológicas do quadril.

QUESTÃO 47. Paciente feminina de 25 anos de idade, chega ao pronto socorro com queimadura de 2o grau por causa de uma combustão de álcool com 35% da superfície corporal queimada. Qual a sequência lógica no atendimento inicial dessa paciente?

A. Acesso venoso - reposição com ringer lactato - curativo - sonda nasogástrica - analgesia intramuscular - profilaxia para tétano
B. Analgesia endovenosa - avaliar vias aéreas - acesso venoso - reposição com soro glicosado - curativo - sonda nasogástrica
C. Avaliar vias aéreas - acesso venoso - reposição com soro ringer lactato - avaliar lesões associadas - analgesia endovenosa - sonda vesical
D. Oxigênio a 100% - analgesia intramuscular - acesso venoso - antibiótico - profilaxia para tétano - curativo

QUESTÃO 48. Em relação ao osteossarcoma, marque a alternativa correta:

A. É o tumor ósseo benigno mais comum
B. Acomete mais frequentemente a diáfise de ossos tubulares curtos
C. Acomete mais frequentemente a metáfise de ossos longos e o RX é com bordas mal definidas
D. No RX simples, os bordos são bem definidos

QUESTÃO 49. Paciente com escoliose idiopática do adolescente com Cobb entre T5 e T11 de 91 graus. Sobre a história natural dessa deformidade, marque a alternativa correta:

A. Paciente com maior risco de desnutrição pelo menor volume abdominal
B. Pela deformidade tridimensional há uma deformidade do tórax com maior risco de síndrome restritiva pulmonar
C. Como a curva é de pequena magnitude o paciente apresenta vida normal e não requer tratamento
D. O ângulo de Cobb nada influencia a gravidade do caso e sim a localização da curva e idade do paciente

QUESTÃO 50. Qual o nervo mais utilizado para a enxertia nervosa?

A. Fibular
B. Sural
C. Safeno
D. Auricular posterior

QUESTÃO 51. Tumor músculo-esquelético osteolítico mais frequente na diáfise em crianças, com semelhança a osteomielite, por apresentar reação periosteal em casca de cebola:

A. Osteossarcoma
B. Condrossarcoma
C. Sarcoma de Ewing
D. Osteoblastoma

QUESTÃO 52. Paciente de 18 anos de idade, vítima de acidente automobilístico. Atendido no PS, onde foi feito em diagnóstico de fratura da diáfise do úmero, simples, fechada e com desvio angular em antecurvado. O vértice da mesma é:

A. Anterior
B. Medial
C. Lateral
D. Posterior

QUESTÃO 53. Paciente sexo masculino 18 anos, vítima queda de 5 metros, está desacordado e com sangramento abundante em face:

A. Prioridade neste caso é avaliar a fratura de face, devido ao sangramento e risco de choque hipovolêmico
B. Como ele está desacordado, não se deve preocupar com estabilidade da coluna, pois rebaixamento nível de consciência é mais grave
C. Devemos suspeitar de trauma em coluna cervical quando existe trauma de face, TCE, intoxicação alcoólica ou em pacientes comatosos
D. Se este paciente apresentar Babinsky e Hoffman positivos é provável que tenha trauma raquimedular lombar

QUESTÃO 54. Paciente sexo masculino, 42 anos, sedentária, vem apresentando lombalgia há 3 meses. A dor piora a movimentação, não tem irradiação, nega alterações esfincterianas, perda de peso, febre ou déficit de força. A conduta deve ser:

A. Solicitar Ressonância da coluna lombar por ter essa queixa de forma persistente e crônica
B. Encaminhar a reabilitação para reeducação neuromuscular e orientações ergonômicas de vida
C. Prescrever AINE e miorrelaxante por 6 semanas
D. Provavelmente se trata de hérnia discal pela característica da dor

QUESTÃO 55. Homem, 36 anos, atleta profissional, diagnosticado com síndrome de impacto do ombro esquerdo. Paciente refere dor no referido ombro há 8 meses, após atividade de elevação do MMSS. Dor a rotação interna a se vestir e dor noturna no decúbito ipsilateral. Diagnósticos diferenciais:

A. Capsulite adesiva e tendinite calcária fase crônica
B. Subluxação glenoumeral e hérnia discal cervical
C. Radiculopatia cervical e neoplasma
D. Rotura completa do tendão supraespinhal e artrose acromioclavicular

QUESTÃO 56. Mulher, 84 anos, aguarda consulta com reumatologista para avaliação de dor constante no joelho esquerdo, de aparecimento há um mês, após queda da própria altura. Após a avaliação clínica, o médico solicita uma USG do joelho e encaminha a paciente para a consulta com a geriatria, com suspeita de “síndrome do idoso caidor”. Nesse caso, para a suspeita da referida síndrome, o médico reumatologista deve ter encontrado, durante a consulta, a seguinte característica:

A. Barthel = 90 pontos
B. SARC-F = 6 pontos
C. Antecedentes de duas quedas em um período de doze meses.
D. Antecedentes de uma queda com fratura grave em um período de dois anos.

QUESTÃO 57. A Osteoporose é uma desordem osteometabólica caracterizada por fragilidade óssea e predisposição a fraturas. Em pacientes com osteoporose sem fratura, a abordagem fisioterápica preventiva deve preferencialmente incluir:

A. Hidroterapia
B. Alongamentos
C. Cinesioterapia global com impacto
D. Cinesioterapia localizada sem impacto

QUESTÃO 58. A fibromialgia (FM) é uma síndrome dolorosa crônica, presente em aproximadamente 2,5% da população brasileira, predominando entre mulheres de 35 a 44 anos. Segundo as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia (2017) para o diagnóstico desta enfermidade, é verdadeiro:

A. A termografia é um método válido para diagnóstico da FM, exceto em pacientes portadores de hipertensão arterial.
B. A polissonografia pode ser utilizada como método diagnóstico para a FM apenas nos pacientes com insônia terminal.
C. A presença de dor difusa não é essencial para o diagnóstico em pacientes com suspeita de FM.
D. Os pontos dolorosos podem ser úteis no diagnóstico de fm quando avaliados em conjunto com outros distúrbios funcionais.

QUESTÃO 59. Uma mulher de 62 anos comparece ao seu consultório para avaliação da reumatologia , como exames apresenta uma densitometria óssea com t-score de 2.9. Considerando isso, o diagnóstico e :

A. Osteopenia
B. Osteoporose
C. Massa óssea inadequada para a idade
D. Normal

QUESTÃO 60. Uma das etapas importantes no exame da coluna vertebral consiste na manobra que avalia a sacroileíte, denominado teste de Patrick-Fabere, que consiste na seguinte manobra sobre uma das pernas

A. flexão, abdução, rotação externa
B. extensão, abdução, rotação interna
C. extensão, abdução, rotação interna
D. flexão, adução, rotação externa

QUESTÃO 61. S.J.U , 28 anos, vem à consulta queixando de xerostomia, xeroftalmia, poliartralgia, de joelhos, mãos e punhos. Como exames complementares trás um fator reumatoide positivo e anti ccp negativos, anti RO e anti La com títulos de 1:280. O diagnóstico correto é :

A. Artrite reumatoide
B. Síndrome de Sjogren
C. Artrite Psoriásica
D. Osteoartrite

QUESTÃO 62. Paciente de 49 anos, masculino, queixa-se de dor e edema no joelho direito há 3 dias. Relata episódios semelhantes em hálux esquerdo há 1 ano e em tornozelo direito há 5 meses. Nega febre, tosse, disúria e erupção cutânea. Exame Físico: artrite de joelho direito e joelho direito. Artrocentese evidenciando cristais em forma de agulha, com birrefringência fortemente negativa. Foi solicitado Raio-X de joelhos, porém o laudo não foi liberado. É correto afirmar:

A. Raio-x dos joelhos revela calcificação dos meniscos, confirmando diagnóstico de artrite reumatoide
B. Raio-x dos joelhos revela erosão em saca-bocado, confirmando diagnóstico de osteoartrite
C. Medicar, imediatamente, com colchicina e/ou diclofenaco
D. Medicar, imediatamente, com alopurinol ou benzobromarona

Caso clínico para as questões 63 e 64: 22 anos, estudante não falava o sexo,, relata dor e edema de todas IFPs bilateralmente e punhos há 4 semanas. Relata febre não aferida, inapetência e aftas orais. Queixa-se de disúria e urina espumosa. Nega dispneia e palpitação. Informa relação sexual sem proteção. Hemograma
normal, VHS= 80, FR= negativo, FAN= positivo- padrão nuclear homogêneo (1/640). Raio-x de mãos e punhos normais.

QUESTÃO 63. Quais são as possibilidades diagnósticas?
A. Osteoartrite, gota e artrite séptica
B. Artrite reumatoide, Artrite viral e osteoartrite
C. Artrite gonocócica, LES e Artrite viral
D. Artrite psoriática, Artrite gonocócica e Artrite reumatoide

QUESTÃO 64. Quais exames pedir?
A. Ácido úrico e proteinúria de 24 horas
B. Anti-CCP e RNM das mãos
C. Punção articular e sorologia viral (hepatites, HIV e Chick)
D. Anti-DNA e proteinúria de 24 horas

QUESTÃO 65. Em relação aos AINES, marque a alternativa correta:
A. Os principais efeitos dos AINES são anti inflamatório, anti hipertensivo e anti-depressivo;
B. Naproxeno, um derivado do ácido propiônico, tem potência 20x inferior a aspirina, daí sua ineficácia clínica;
C. Os AINES tradicionais inibem tanto a COX-1 como a COX-2, embora a sua potência relativa para cada isoforma seja diferente;
D. O Paracetamol, derivado do para-aminofenol, tem uma melhor atividade anti inflamatória que antitérmica e analgésica

QUESTÃO 66. Em relação aos glicocorticóides, julgue os itens abaixo.
I - As alterações da hidrocortisona e da cortisona deram início aos potentes glicocorticóides atuais com menor retenção de sódio
II - Análogos sintéticos da hidrocortisona possuem vantagens como: maior potência antiinflamatória, ação prolongada e menor retenção de sódio
III - Acrescentando um radical hidroxila ou metil ao carbono 16 a 19-flurpredinisolona, temos a triancinolona e a betametasona, com ação glicocorticoide cerca de 30x maior que a hidrocortisona e com atividade mineralocorticoide nula;
Responda a alternativa correta.
A. Somente I está correta
B. Somente II está correta
C. Somente I e II estão corretas
D. Todas as alternativas estão corretas

QUESTÃO 67. Em relação aos anticorpos nas Doenças Auto Imunes, correlacione a primeira coluna (letras),
com a segunda coluna, números:
A) Lúpus Eritematoso Sistêmico
B) Lúpus Induzido por Drogas
C) Esclerose Sistêmica
D) Polimiosite e Dermatomiosite
E) Síndrome de Sjögren
F) SAF
G) Granulomatose de Wegener

1) Anticentrômero, Anti Fibrilarina e Anti-Scl-70
2) Anti-Jo-1 e Anti-Mi-2
3) Anti-DNA nativo, Anti Proteína P ribossomal e Antinucleossomo
4) Anti-SS-A/Ro e anti-SS-B/La
5) Autoanticorpos Anti-histonas
6) Antiproteinase 3

7) Anticorpo Anti-Fosfolípide e Anti-Cardiolipina (IgG e IgM) e Anti-Coagulante Lúpico

A alternativa que apresenta a melhor correlação é:

A. A-3; B-5; C-1; D-4; E-6; F-7 e G-2
B. A-2; B-5; C-7; D-3; E-6; F-6 e G-4
C. A-6; B-7; C-1; D-2; E-4; F-7 e G-6
D. A-3, B-5; C-1; D-2; E-6; F-4 e G-7

QUESTÃO 68. Laboratório de anemia no idoso

I. O exame com melhor custo/benefício e maior poder de discriminação entre anemia ferropriva da anemia de doença crônica no idoso é a dosagem de ferro

II. O exame com melhor custo/benefício e maior poder de discriminação entre anemia ferropriva e da anemia de doença crônica no idoso é a ferritina

III. A contagem de reticulócitos é um exame muito útil para diferenciar a anemia ferropriva da megaloblástica, muito comum no idoso

IV. O sangue oculto nas fezes deve ser solicitado ao idoso se apresentar anemia microcítica e hipocrômica com anisocitose

Quais afirmativas são verdadeiras?

A. I e II
B. II e IV
C. III e IV
D. I e IV

QUESTÃO 69. Paciente feminino, 25 anos, tumor epífise da tíbia. Rx: limites nítidos, fino trabeculado ósseo. Macroscopia: grande volume, lesão densa, avermelhada com lacunas hemorrágicas. Microscopia: tecido osteóide, células gigantes multinucleadas, alta vascularização. Qual o diagnóstico menos provável?

A. Tumor de células gigantes
B. Cisto ósseo aneurismático
C. Tumor marrom de hiperparatireoidismo
D. Osteossarcoma osteoblástico

QUESTÃO 70. Em relação ao sarcoma:

A. No peritônio apresenta diagnóstico tardio,
B. É mais frequente em crianças do que em idosos e adultos
C. Linfonodo como sítio de metástase mais frequente
D. Cérebro como sítio de metástase mais frequente

QUESTÃO 71. Paciente feminino,60 anos, 5 nódulos de 5 cm na coxa, superficiais e sem invasão neurovascular ao USG. Diagnóstico mais provável:

A. Lipoma
B. Hemangioma
C. Rabdomiossarcoma
D. Osteoma

QUESTÃO 72. A osteoartrite é uma alteração extremamente prevalente que ocorre na estrutura articular. com relação a esse assunto, assinale a correta:

A. Rarefação Óssea periarticular é um achado de imagem fortemente sugestivo desse diagnóstico
B. Osteófitos são achado de imagem que favorece o diagnóstico
C. Sinovite e erosões marginais são achados muito sugestivos de osteoartrite
D. Anormalidades do alinhamento ósseo como geno varo não estão associados à osteoartrite

QUESTÃO 73. Assinale a opção correta acerca da osteomielite

A. abscesso de Brodie caracteriza o estágio agudo da doença
B. abscesso de Brodie está localizado na cortical
C. sequestro ósseo caracteriza estágio crônico da osteomielite
D. reação periosteal e um achado de imagem patognomônico desta condição

QUESTÃO 74. assinale a opção incorreta acerca da osteomielite

A. Os achados de imagem do tipo rarefação óssea mal definidas são precocemente identificados nos exames radiográficos (primeiras 24h)
B. As metáfises são comumente acometidas e as fises abertas sao barreiras mecânicas para a disseminação do processo infeccioso para as epífises
C. A osteomielite pode ser causada por algumas condições, entre elas amigdalite, furúnculos, e infecções respiratórias e do trato urinário que se disseminam por via hematogênica
D. Entre os agentes causadores mais frequentes estão: S. aureus, P. mirabilis, P. aeruginosa e E. coli

QUESTÃO 75. Quais são atividades instrumentais de vida diária?

A. Alimentar-se, ir ao banheiro, escolher a roupa e arrumar-se
B. Telefonar, gerir recursos financeiros, usar transporte público
C. Cuidar da higiene pessoal, manter-se continente e vestir-se
D. Tomar banho, andar e transferir (por exemplo, da cama para a cadeira de rodas)

QUESTÃO 76. Homem com aumento de edema de joelho foi prescrito AINE e começou a se queixar de epigastralgia. Para o edema de joelho foi passado um diurético que causou hipocalemia, sendo administrado K+, o que piorou epigastralgia. (tem uma sequência de medicamentos e efeitos adversos).Como chamamos esse efeito:

A. Efeito dominó
B. Prescrição em cascata
C. Interação medicamentosa
D. Ineficácia terapêutica

QUESTÃO 77. O que deve ser **EVITADO** na desprescrição:

A. Retirar medicamentos preventivos independente da expectativa de vida
B. Retirar medicamentos sintomáticos, mesmo que sintomas já tenham melhorado
C. Retirar vários medicamentos inapropriados ou de alto risco de uma só vez
D. Retirar medicamentos psicotrópicos reduzindo a dose lenta e gradualmente

QUESTÃO 78. Mulher, 78 anos, diabética, perdeu 6kg em 4 meses, apresenta fraqueza, fadiga, dificuldade em subir escadas. Ao teste de preensão palmar obteve resultado de 10kg. Circunferência de panturrilha: 31cm. No caso em questão a paciente apresenta:

A. Provável sarcopenia
B. Sarcopenia confirmada
C. Não apresenta sarcopenia
D. Dados insuficientes para diagnóstico

QUESTÃO 79. Queimadura indolor, aspecto polvilhado, vermelho vivo, nacarado, sem bolhas.
Classificação?

A. 1o grau
B. 2o grau sup.
C. 2o grau prof.
D. 3o grau

QUESTÃO 80. 8 anos, masculino, dor súbita no joelho esquerdo. após futebol, piorando há 5 dias, deambulação claudicante. Ao ex. físico: edema 2+ e aumento de temperatura.

A. Pedir RX
B. Pioartrite, mas pedir RX após 10 dias
C. Via de contaminação é drenagem de osteomielite aguda de metáfise intra-articular.

D. . Tratamento é cirúrgico, limpeza, eletiva.

QUESTÃO 81. Masc., 75, ca de próstata há 2 anos, finalizou tto com QT. Prostatectomia. Lombalgia contínua, sem fator de melhora ou piora, sem irradiação p/ MMII. Não melhorou com fisioterapia nem relaxante muscular. A dor piorou.

A. Imagem, ... dor compressiva.
B. Investigar metástase para coluna
C. RX de coluna (+S e +E)
D. Metástase para coluna é pouco provável.

QUESTÃO 82. Classificação de Herring para doença de Perthes, o tipo

A. a - 50% achatamento pilar lateral
B. b - 70%
C. b - 60%
D. c - >50% de achatamento do pilar lateral

QUESTÃO 83. Escoliose idiopática do adolescente

A. feminino, 11 - 18 anos
B. masculino, 11 - 18 anos
C. feminino, 12 - 25 anos
D. masculino, 12 - 25 anos

QUESTÃO 84. Sobre o diagnóstico de trauma de extremidades, é correto:

A. fratura é uma incongruência articular
B. luxação é uma lesão direta das partes moles ou osso com hematoma
C. entorse é uma solução de continuidade do osso
D. lesão miotendínea é uma impotência funcional por ruptura

QUESTÃO 85. Mulher de 72 anos com osteoporose. Após avaliação médica foi diagnosticado sarcopenia. Quais os critérios para este diagnóstico?

A. Diminuição da massa muscular e diminuição da força
B. Diminuição da força muscular e alto perfil físico
C. Massa muscular normal e diminuição das enzimas musculares
D. Fraqueza muscular e elevação das enzimas musculares

QUESTÃO 86. Homem de 80 anos com osteoartrite no joelho direito em uso de bengala. Quais são as orientações para este paciente?

A. Durante a marcha, a bengala deve ser posicionada no degrau no membro superior esquerdo
B. Para descer uma escada, a bengala deve ser posicionada no degrau, primeiramente. Então, deve-se apoiar o MIE e, finalmente, o MDF, o qual suportará o peso do corpo.
C. Para levantar de uma cadeira, a bengala deve ser posicionada na frente do corpo, primeiramente. Em seguida, deve-se apoiar sobre a mesma inclinando o corpo para frente e levantar.
D. Para deambular, a bengala deve avançar simultaneamente com o membro inferior esquerdo.

QUESTÃO 87. Homem de 27 anos refere dor e edema em joelho D há 4 semanas associado a inchaço bilateral dos dedos. Exame mostra artrite no JD, dactilite e exame genitourinário normal. Qual a principal hipótese diagnóstica?

A. Artrite reativa
B. Artrite reumatóide
C. Gota
D. Artrite séptica

QUESTÃO 88. Acerca dos AINEs:

I - O AINEs possuem como reação adversa gastrite e afecções do TGI.

II - São AINEs: dipirona, corticosterona, loratadina e paracetamol.

III - Esta classe de medicamentos inibe a atividade da COX. A COX 1 é constitutiva, e produz prostaglandinas da homeostasia. A COX 2 é ativada em processos inflamatórios.

IV - Todos os AINEs são formados por ácido forte e base forte e por isso geram muitos efeitos adversos.

V - Esta classe pode apresentar propriedades anti inflamatórias, analgésicas e antipiréticas.

A. I, II, III
B. I, III e V
C. I, II e IV
D. I, III e IV

QUESTÃO 89. Sobre os glicocorticóides e seu mecanismo de ação marque a alternativa **INCORRETA**:

A. Os glicocorticóides são derivados do colesterol e são capazes de atravessar livremente a membrana plasmática.
B. Aumenta a transcrição de proteínas inflamatórias IL 2, IL3, IL4, IL6, IL8, IL 12, interferon gama e TGF alfa.
C. Após entrar na célula, os glicocorticóides se ligarão no receptor de glicocorticóides e depois se encaminharão para o núcleo celular. No DNA, o glicocorticoide ligado ao receptor afetará a transcrição gênica.
D. Os glicocorticóides indiretamente promovem a inibição da enzima fosfolipase A2, essencial para produção do ácido araquidônico.

QUESTÃO 90. Qual o fármaco padrão para o tratamento de AR (artrite reumatóide)?

A. Sulfassalazina
B. Leflunomida
C. Difosfato de cloroquina
D. Metotrexato

QUESTÃO 91.Em relação ao sarcoma:

A. Tem metástase hematogênica
B. Biópsia só se > 5 cm
C. Mais frequente em menores de 10 anos
D. Apresenta células fusiformes

QUESTÃO 92. Quais os métodos de imagem mais usados em afecções osteoarticulares?

A. USG e TC
B. Raio-X e PET-CT
C. RNM e Raio-Rx
D. Raio-X e TC

QUESTÃO 93. Sobre a reabilitação nas patologias ortopédicas:

A. Atua no diagnóstico e tratamento das patologias ortopédicas, não sendo escopo de sua atuação a prevenção.
B. O objetivo final da reabilitação é devolver ao indivíduo o máximo de funcionalidade dentro do seu contexto.
C. No tratamento da Dor Crônica, o médico fisiatra utiliza apenas a prescrição de fisioterapia para melhora do paciente.
D. A reabilitação pós fratura só deve iniciar após cerca de 8-12 semanas, independente do local da fratura, gravidade, ou técnica utilizada na estabilização,tendo pouco benefício o início precoce.

QUESTÃO 94. Você é chamado para avaliar um paciente adulto no pronto socorro. No exame, o paciente apresenta uma grande queimadura no braço esquerdo e no tórax, envolvendo quase todo o membro superior esquerdo e metade do tronco anterior. Qual a sua estimativa para a extensão da queimadura?

A. 12%
B. 18%
C. 24%
D. 28%

QUESTÃO 95. Na displasia de desenvolvimento do quadril:

A. O teste de Barlow é uma manobra que detecta a luxação do quadril com a sua flexão e adução.
B. O teste de Galleazzi é sempre anormal, mesmo na presença dessa patologia nos quadris bilateralmente.
C. O Suspensório de Pavlik deve ser usado mesmo em luxações teratológicas do quadril.
D. A redução cruenta associada à osteotomia de fêmur derrotativa e com encurtamento além de osteotomia de Salter, combinadas são indicadas em crianças de 12 meses de idade.

QUESTÃO 96. Um paciente com 6m de Trauma raquimedular apresenta-se com Babinsky, clônus de membros inferiores e reflexo de Hoffmann positivo. Qual a altura provável da lesão do paciente?

A. C4C5
B. T8T9
C. T12L1
D. L4L5

QUESTÃO 97. Paciente 18 anos, sexo feminino, foi vítima de acidente motociclístico, queixando-se de dor intensa em membro superior D, na região antebraço. No momento do exame físico pela equipe pré-hospitalar foi visto deformidade em antebraço. Paciente foi encaminhada ao Pronto Socorro de Ortopedia, realizado radiografia do antebraço e visualizado fratura de rádio e ulna na região diáfisária com desvio. Foi indicado cirurgia, porém paciente terá que aguardar a vaga ser liberada, e por isso foi imobilizada. Qual o tipo de imobilização que deve ser usada:

A. Inguino-podálica
B. Antebraquio-palmar
C. Axilo-palmar
D. Tóraco-braquial

QUESTÃO 98. No exame físico de paralisia obstétrica alta encontramos:

A. Reflexo de Moro assimétrico
B. Reflexo de preensão ausente
C. Mão em garra
D. Membro em rotação externa e supinação do antebraço

QUESTÃO 99. Os seguintes sintomas estão presentes ao suspeitar de uma fratura:

I - dor local
II - Edema ou deformidade
III - Hematoma
IV - Crepitação ao movimentar ou incapacidade funcional do membro
V - Muita sede
VI - Temperatura alta

Dos itens acima mencionados, os que são realmente identificados como presença de possível fratura:

A. I, IV
B. I, IV, V, VI
C. II, III, V, VI
D. I, II, III, IV

QUESTÃO 100. Em relação às fraturas expostas, marque a alternativa correta:

A. A classificação de Gustillo leva em consideração, principalmente, o tamanho do ferimento (até 1, de 1 a 10 e maior de 10 cm).
B. Paciente trabalhador rural, apresentou queda do cavalo no curral com fratura da perna com ferimento de aproximadamente 4 cm ao nível da fratura. O seu diagnóstico é: fratura exposta da perna grau II de Gustillo.
C. A complicação mais temida na fratura exposta é a infecção e por isso é muito importante a limpeza e desbridamento desses ferimentos.
D. O tratamento da fratura exposta pode ser conservador, principalmente nos casos com mais de 6 horas de exposição.

QUESTÃO 101 (ʕ ͡° ͜ʖ ͡°). Com relação a hora de ouro do ATLS, é correto afirmar que:

A. A melhora do tempo de resposta do resgate não influencia na sobrevida;
B. As mortes que ocorrem após a primeira semana do trauma decorrem principalmente do estado de choque;
C. A mortalidade aumenta em pacientes graves e internados por longos períodos devido a infecções;
D. Nenhuma das anteriores;

QUESTÃO 102. Você está descrevendo os riscos e benefícios da expansão tecidual para os pais de uma criança que apresenta uma área de alopecia no couro cabeludo. Qual das seguintes alternativas constitui a principal vantagem da expansão tecidual para esta criança?

A. O menor número de procedimentos com anestesia geral
B. O menor número de consultas clínicas hospitalares
C. O defeito pode fechar diretamente utilizando um retalho de pele com cabelo
D. A reconstrução pode ser terminada rapidamente

QUESTÃO 103. O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune multissistêmica crônica, com acometendo principalmente a pele, articulações, serosas, glomérulos e o SNC. A doença é resultado da ação de autoanticorpos. Em 2012, foram publicados os novos critérios de classificação do LES, denominado SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics). Os 11 critérios de classificação anterior foram substituídos por 17 critérios, sendo que é preciso ter 4 ou mais critérios, sendo pelo menos 1 imunológico, para se receber o diagnóstico de LES. Dentre os imunológicos, temos o exame denominado FAN. Nas reuniões de Consenso Nacional de Laudos de Células HEP2, foram criados estes algoritmos.

Correlacione as colunas (A e B) e escolha a alternativa correta:

A) Padrões nucleares em células HEP2

I - Nuclear homogêneo periférico, placa metafásica cromossômica negativa, tipo membrana
nuclear

II - Nuclear homogêneo, placa metafásica cromossômica positiva

III - Nuclear pontilhado, placa metafásica cromossômica positiva, centromérico

IV - Nuclear pontilhado, placa metafásica cromossômica positiva, pontilhado fino denso

V - Nuclear pontilhado, placa metafásica cromossômica negativa, grosso

VI - Nuclear pontilhado, placa metafásica cromossômica negativa

B) Relevâncias clínicas por autoanticorpos mais importantes:

1. **Anticorpo anti-proteína p75 kDa, Af LEDGF/p75 (lens epithelium-derived growth factor).** Não está associado a doença autoimune. Pode ser encontrado na Cistite Intersticial, Tumor de Mama, Processos Inflamatórios Inespecíficos. Pode ser **Anticorpo anti-DNA nativo** encontrado em indivíduos saudáveis, dermatite atópica, psoríase e asma.

2. **Anticorpo anti-DNA nativo**: lúpus eritematoso sistêmico (LES). **Anticorpo anti-histona**: LES induzido por drogas (hidralazina, procainamida, isoniazida e clorpromazina); LES idiopático. Anticorpo anti (DNA/histona, nucleossomo): Artrite Reumatoide (AR), Artrite Idiopática Juvenil, importante associação com a forma oligoarticular, Síndrome de Felty, Cirrose Biliar Primária.

3. **Anticorpo anti-SSA/Ro**: Ag - 4 pequenos RNAs associados a 2 proteínas de 60 e 52 Kd. A de 60 Kd - Lúpus SS. A de 52 Kd SS, ES, Miosite, LES/OMTC, AR, CBP, HAI, HVB, HVC. Ocorre na maioria dos pacientes com Síndrome de Sjögren (88 a 95%), Artrite Reumatoide (24 a 60%), Lúpus associado a fotossensibilidade em jovem, Lúpus Neonatal (90%), bloqueio cardíaco congênito.

Anticorpo anti-SSB/La. Lúpus neonatal, LES, SS, Ag - proteína 48 KD, parece ter função com fator

tem transcrição da RNA polimerase III. Frequentemente associado a SSA/Ro, SS primária (71 a 87%), Lúpus Neonatal, incluindo BBC (30 a 40%), Lúpus (9 a 35%). SS está associada a púrpura, hipergamaglobulinemia, disfunção de glândula salivar, edema de parótida, altos níveis de fator reumatóide, linfopenia e leucopenia. Anticorpo anti-Mi-2: dermatomiosite, embora raramente ocorra na polimiosite do adulto.

4. **Anticorpo anti-Lâmina**. Componente da membrana interna, pontos de ancoragem de

cromossomos de células interfase, pode ser encontrado nas hepatites auto-imunes, raramente associado a doenças reumáticas (algumas de LES e esclerodermia linear, vasculite cerebral ou cutânea)

5. **Anticorpo anti-centrômero**: Esclerose Sistêmica forma CREST (curso benigno e prolongado), Esclerodermia (82%), Cirrose Biliar Primária (8%)

6. **Anticorpo anti-Sm**. 99% de especificidade para Lúpus. Relação com doença ativa independente do título, re mais frequente com acometimento do SNC, doença renal, fibrose pulmonar e pericardite. **Anticorpo anti-RNP**: N (altos títulos), também ocorre no LES (30 a 40% doença menos severa), Esclerose Sistêmica (ES) e AR.

A sequência de associação correta é:

A. I -1; II - 5; III - 6; IV - 4; V - 3; VI - 2
B. I - 4; II - 2; III - 1; IV - 6; V-5 VI - 3
C. I - 1; II-6; III-5; IV - 2; V - 4; VI - 3
D. I - 4; II - 1; III - 5; IV - 2; V - 3; VI - 6
E. I - 4; II - 2; III - 5; IV - 1; V - 6 ; VI - 3

QUESTÃO 104. Relacione adequadamente as colunas, cada anticorpo com a doença em que ele mais frequentemente está positivo:

1. Anti-histonas
2. c-ANCA
3. Anti-RNP
4. Anti-DNA nativo
5. Anti-SSA/RO

( ) Doença Mista do Tecido Conjuntivo
( ) Nefrite Lúpica
( ) LES induzido por drogas
( ) Granulomatose com Poliangeite-ex de Wegener
( ) Síndrome de Sjögren

A sequência correta está em

A. 1,2,3,4,5
B. 1,5,4,2,3
C. 3,4,1,2,5
D. 5,1,2,4,3

QUESTÃO 105. Considerando o laboratório na análise das causas mais frequentes de anemias no idoso, analise as afirmações abaixo e depois escolha a sequência de afirmações corretas (verdadeiras).

I- O exame com melhor relação custo/benefício e maior poder de descriminação entre a Anemia Ferropriva, e a Anemia da doença crônica, ambas frequentes, é a dosagem de Ferro.

II - O exame com melhor relação custo/benefício e maior poder de descriminação entre a Anemia Ferropriva, e a Anemia da doença crônica, ambas frequentes, é a dosagem de Ferritina.

III - A Contagem de Reticulócitos é muito útil na diferenciação da Anemia Ferropriva da Anemia Megaloblástica, também importante causa de anemia no idoso.

IV - A pesquisa de sangue oculto nas fezes deve ser solicitada quando estivermos diante de uma anemia microcítica e hipocrômica, com anisocitose.

A alternativa com as afirmações corretas (verdadeiras) é:

A. II e IV
B. I, III e IV
C. II, III e IV

D. I e IV

QUESTÃO 106. Uma paciente de 88 anos foi admitida no serviço de urgência com fraqueza como queixa principal. Apresentava dispneia, sintomas gastrointestinais como náuseas e vômitos, dor abdominal, dispepsia, prurido e feridas na boca há 3 dias. Os sintomas foram progressivos. Na avaliação dos medicamentos consumidos foi determinado que ela está em uso contínuo de metotrexato (MTX) há cerca de 5 meses. Na busca da causa do uso de MTX e checagem das prescrições, foi revelado que a paciente recebeu por engano MTX ao invés de digoxina. Ela havia usado MTX 1,25 mg por 5 meses consecutivos, e 2,5 mg nco dias por semana no último mês. Considerando a sua hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que indica a melhor opção terapêutica a ser instituída:

A. Retirada do MTX e a administração de ácido folínico (leucovorina)
B. A retirada do MTX e a administração de ácido fólico
C. A retirada do MTX e a administração de vitamina E
D. Continuação com MTX e a administração de ácido folínico (leucovorina)

QUESTÃO 107. Um paciente com insuficiência renal crônica em tratamento conservador, foi internado na Unidade Coronariana com angina instável. Apresentou, durante sua internação, quadro agudo de artrite na articulação metatarsofalangeana e tornozelo. Relatou que já havia sofrido quadro semelhante previamente. Considerando a sua hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que melhor indica o diagnóstico de artrite e opção terapêutica a ser instituída.

A. Artrite reumatóide e Colchicina.
B. Gota e Alopurinol.
C. Gota e Anti-inflamatório não hormonal.
D. Gota e Corticosteróides.

QUESTÃO 108. Sobre a artrite reumatoide, julgue as alternativas e responda:

I. A artrite reumatoide é uma doença autoimune em que o sistema imunológico a sinóvia e causa o acúmulo de líquido nas articulações, perda debilitante de cartilagem, fraqueza óssea e deformidade articular. É uma condição crônica e progressiva, podendo haver longos períodos de remissão (sem sintomas).
II. Paciente com artrite reumatóide estabelecida e com baixa atividade da doença nunca fez uso de um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), deve iniciar a monoterapia com metotrexato.
III. Paciente com artrite reumatoide estabelecida e com baixa atividade da doença nunca fez uso de um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), deve iniciar a monoterapia com um inibidor do fator de necrose tumoral (TNF) como monoterapia.
IV. Paciente com artrite reumatoide estabelecida em caso de falha da monoterapia inicial com um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), por exemplo metotrexato, é indicada uma terapia com a combinação dupla ou tripla de DMARD convencional (Metotrexato, leflunomida, sulfassalazina, cloroquina e hidroxicloroquina).

A. Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C. Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
D. Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 109. A respeito dos fármacos antirreumáticos modificadores da doença, julgue as alternativas e responda:

I. O metotrexato é um fármaco de primeira escolha, que tem atividade citotóxica e imunossupressora.

II. A tempo de 1⁄2 vida da leflunomida é reduzida pela interação medicamentosa com colestiramina A.

III. A ciclosporina inibe a atividade dos linfocitos T efetores CD8+.

IV. O tofacitinibe e o baricitibe são anticorpos monoclonais que inibem a via de sinalização JAK-STAT.

A. Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C. Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
D. Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 110. As bengalas são dispositivos auxiliares da marcha, (DAM) e, também, consideradas como órteses de membros inferiores, utilizadas com várias finalidades, como para aumentar o equilíbrio durante a deambulação e reduzir a descarga de peso de um dos membros inferiores durante a fase de apoio da marcha. Assinale a alternativa que descreve forma correta de utilização de uma bengala para uma paciente com osteoartrite de joelho direito.

A. A bengala deve ser utilizada do lado direito e movimentar-se juntamente com o membro inferior contralateral.
B. A bengala deve ser utilizada do lado esquerdo e movimentar-se juntamente com o membro inferior homolateral.
C. A bengala deve ser utilizada do lado direito e movimentar-se juntamente com o membro inferior homolateral.
D. A bengala deve ser utilizada do lado esquerdo e movimentar-se juntamente com o membro inferior contralateral.

QUESTÃO 111. Sobre o Delirium ou estado confusional agudo em pacientes idosos, marque a alternativa correta:

A. Um dos instrumentos utilizados para o seu diagnóstico é o questionário CAM (Confusion Assesment Method).
B. É uma situação cada dia mais rara em idosos tendo em vista a elevada prevalência de doenças crônicas nesta população.
C. Caracteriza-se pela apresentação insidiosa e progressiva de déficits de memória, cálculo e linguagem.
D. A droga de escolha para o seu tratamento, independente se hiper ou hipoativo, é a administração de haloperidol por via endovenosa.

QUESTÃO 112. Uma senhora de 88 anos residente em instituição de longa permanência para idosos (ILPI) e portadora de doença de Alzheimer em fase grave foi transferida para o hospital às 14 horas para tratamento de pneumonia aspirativa. No hospital, foi necessária sedação com haloperidol para inicio da antibioticoterapia venosa com cefatriaxona e clindamicina. No dia seguinte, por volta das 21 horas, a enfermeira do plantão, ao trocar a fralda da paciente, observou eritema persistente na região sacral sem perda de continuidade da pele. Que tipo lesão de pele essa paciente apresenta?

A. Dermatite de contato pelo uso de fralda.
B. Lesão por pressão estágio I
C. Candidíase moderada pelo uso de antibióticos.
D. Alergia aos antibióticos

QUESTÃO 113. Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage (GDS) é um bom instrumento para o rastreamento de sintomas depressivos em idosos porque:

A. permite a detecção da sintomas depressivos associados às demências.
B. permite a diferenciação entre sintomas depressivos e a reação ao luto.
C. não inclui perguntas sobre os sintomas somáticos da depressão.
D. permite detectar aqueles que apresentam maior risco de suicídio.

ATENÇÃO*: As questões 114 e 115 referem-se ao caso clínico:*

A Senhora MASV, de 78 anos, é portadora de depressão, hipertensão arterial, osteoartrite de joelhos e diabetes com polineuropatia. Ela faz uso de três comprimidos ao dia de acordo com seguinte esquema terapêutico: -1 (um) comprimido pela manhã de formulação comercial que contém Olmesartana (bloqueador de receptor de angiotensina) 20mg + Hidroclorotiazida (diurético tiazídico) 12,5 mg + Anlodipino (bloqueador dos canais de cálcio) 5 mg para tratamento da hipertensão arterial. -1 (um) comprimido à noite de formulação comercial que contém Metformina (biguanida) 1000 mg + Sitagliptina (Inibidor de DPP-4) 100mg para tratamento da diabetes.

-1 (um) comprimido à noite de Amitriptilina (antidepressivo tricíclico) 75 mg para a depressão e para dor.

QUESTÃO 114. Sobre o esquema terapêutico, pode-se afirmar que a Sra. MASV:

A. tem polifarmácia e faz uso de uma medicação considerada inapropriada para idosos.
B. não tem polifarmácia e nem faz uso de medicação considerada inapropriada para idosos.
C. não tem polifarmácia, pois usa 3 comprimidos ao dia, mas faz uso de medicação inapropriada para idosos.
D. tem polifarmácia, mas não faz uso de medicação considerada inapropriada para idosos.

QUESTÃO 115. Ainda sobre o caso clínico da Sra. MSAV, com relação às suas doenças, pode-se afirmar que:

A. Ela não tem multimorbidade, mas têm uma complicação de doença crônica.
B. Ela tem multimorbidade complexa e apresenta uma complicação de doença crônica.
C. Ela tem apenas multimorbidade, sem nenhuma complicação de doença crônica.
D. Ela tem uma doença índice, várias comorbidades e uma complicação de doença crônica.

ATENÇÃO: *as questões 116, 117, 118 e 119 referem-se ao caso clínico:*

O senhor JPC, de 77 anos, engenheiro aposentado, é portador de hipertensão arterial e diabetes. Faz uso de Losartana, Glicazida e Metformina. Familiares relatam que há 6 meses vem apresentando quedas frequentes, lentidão para deambular, postura encurvada e rígida, tremores nas mãos, recusa alimentar, tosse ao ingerir líquidos e perda de peso. Além disso, sua memória está ruim, alterando períodos de muita lucidez e períodos de confusão nos quais relata que tem uma família com três crianças vivendo na área de serviço do apartamento. Nada o demove disso, descreve a aparência das crianças e chega a levar suco e doces para elas. Ele apresenta os seguintes resultados na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) e de exames:

TGUG Teste - 25 segundos

Barthel - 80 pontos (dificuldades para se vestir, incontinência ocasional e necessidade de supervisão para subir escadas)

Pfeffer - 13 pontos (dificuldades com manuseio do dinheiro, com os medicamentos, fazer compras, preparar comida, encontrar o caminho de volta para a casa e ficar só em casa por muito tempo)

MEEM - 23 pontos

Fluência verbal semântica - 9 nomes de animais

Teste do desenho do relógio - 1 ponto (escore de Shulman)

Escala de Depressão Geriátrica - 3 pontos

APGAR da família - 10 pontos

Mini Avaliação Nutricional - 11 pontos (risco de desnutrição)

Força de preensão manual - 21 Kg

DXA - Massa muscular esquelética apendicular dividida pela altura ao quadrado: 6,3 Kg/m2

Hemograma, função renal, hepática e tiroidiana, vitamina B12, glicemia, lipidograma e eletrólitos - Normais

VDRL e anti-HIV - Negativos
Ressonância magnética do crânio - Atrofia cerebral difusa compatível com a idade. Lobos temporais mediais e hipocampos preservados. Discreta microangiopatia.

QUESTÃO 116. De acordo com a história clínica, a avaliação cognitiva e funcional da AGA e exames pode-se afirmar que o Sr. JPC tem

A. provável demência vascular.
B. possível demência da doença de Parkinson.
C. provável demência com corpos de Lewy.
D. possível demência frontotemporal variante comportamental.

QUESTÃO 117. Sobre a função muscular do Sr. JPC é correto afirmar que ele:

A. não tem sarcopenia, pois as quedas, a lentidão e as dificuldades de mobilidade são explicadas pelo quadro neurocognitivo.
B. tem provável sarcopenia, mas isso já indica o início de medidas terapêuticas e de reabilitação.
C. tem sarcopenia, pois a força muscular está diminuída e o paciente apresentou quedas repetidas.
D. tem sarcopenia grave confirmada pelas alterações da força, massa e desempenho musculares.

QUESTÃO 118. Com os dados da história e da AGA, aplique a escala clínica de fragilidade para o Sr. JPC.

A. Em terminalidade – 9
B. Moderadamente frágil – 6
C. Levemente frágil – 5
D. Não frágil, mas regular – 3

QUESTÃO 119. A AGA é útil não só para o diagnóstico de deficiências e incapacidades, mas pode contribuir para o diagnóstico etiológico, ou seja, das doenças, como também é importante para definição do plano terapêutico e dos profissionais da equipe multidisciplinar necessários. Em um cenário do SUS, com dificuldades de acesso a equipes multidisciplinares, e baseando-se nos dados da AGA, para quais profissionais você encaminharia, inicialmente, o senhor JPC visando a manutenção por mais tempo de sua capacidade funcional.

A. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista.
B. Neuropsicólogo, fisioterapeuta e massagista.
C. Nutricionista, enfermeiro e educador físico.
D. Fisioterapeuta, educador físico e reeducador postural.

QUESTÃO 120. Assinale a sequência correta:
Escolha V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas em relação a artrite reumatoide.
( ) A rigidez matinal e os nódulos de Heberden são critérios de diagnóstico
( ) O padrão de envolvimento articular mais frequente é a poliartrite de pequenas articulações
( ) A glicosamina e a condroitina são as drogas de escolha para prevenir as erosões
( )O fator reumatoide contribui para o diagnóstico e em altos títulos indica pior prognóstico.

A. V, V, F, F
B. F, V, F, V
C. F, V, F, F
D. V, F, V, F

QUESTÃO 121. Em relação a espondilite anquilosante é correto afirmar:
I - A presença do HLA B27 aumenta o risco para espondilite anquilosante.
II - Os osteófitos e a redução do espaço vertebral na coluna lombar são achados radiográficos característicos.
III - A uveíte anterior é uma das manifestações extra articulares
IV - Os pacientes apresentam lombalgia que melhora com movimento associada a rigidez matinal

A. I, II e III

B. II, III e IV
C. I, II e IV
D. I, III e IV

QUESTÃO 122. Sobre a gota assinale a alternativa correta

A. O uso de ácido acetilsalicílico em altas dose em pessoas com hiperuricemia pode aumentar o risco de artrite aguda
B. Classicamente se manifesta como monoartrite aguda, que se instala rapidamente em poucas horas, com dor intensa e sinais flogísticos na articulação acometida
C. É importante fazer a medida do ácido úrico sérico logo no início da crise, para iniciar o hipouricemiante imediatamente.
D. Apesar de poder manifestar-se como crises repetidas de artrite, não provoca alterações permanentes nas articulações.

QUESTÃO 123. Uma mulher de 18 anos procura assistência médica com queixa de eritema malar, fotossensibilidade, úlceras incolores no palato duro, anorexia e artrite nos joelhos há 1 mês. De acordo com a principal hipótese diagnóstica, qual o achado laboratorial encontrado?

A. Leucocitose com desvio à esquerda
B. Diminuição de C3 e C4
C. Presença de anti SCL 70
D. Fator reumatoide positivo.

QUESTÃO 124. Os corticosteróides são medicamentos de ação anti-inflamatória e imunossupressora. São utilizados para suprimir os mecanismos de resposta imune, procedimento necessário para realizar o tratamento das doenças reumáticas imunomediadas. Sobre tais drogas, é correto afirmar:

A. Deve-se evitar a prescrição de prednisona em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa.
B. Pacientes em uso prolongado de altas doses de corticosteróides devem ser monitorizados quanto ao risco de hipoglicemia e hipotensão.
C. A prescrição de carbonato de cálcio e da vitamina D é indicada na prevenção de osteoporose cortico-induzida
D. A ação mineralocorticoide e a potência da prednisolona, prednisona, metilprednisolona edexametasona são idênticas.

QUESTÃO 125. Paciente de 24 anos comparece para consulta na UBS com queixas de "azia e queimação no estômago". Durante a anamnese você descobriu que essa paciente utilizava nimesulida, três vezes por semana, há quatro meses, em função de dor lombar mecânico postural. Podemos justificar esta sintomatologia dada a ação dos AINES inibindo a:

A. COX-1.
B. COX-2.
C. Fosfodiesterase.
D. Dihidrorato redutase.

QUESTÃO 126. J.M.S., 56 anos, sexo feminino, católica, parda, casada, atendente de telemarketing, procedente e residente em Goiânia, apresenta como queixa principal: "Dor intensa no corpo todo e fadiga há 4 meses". Ela afirma que vinha bem quando, há 4meses, iniciou quadro de dor em região lombar, MMSS e MMII, bilateral, de intensidade moderada (5 em uma escala de 0-10), insidiosa, caracterizando essa dor como difusa nos membros acometidos. Refere que, há 3 meses, evoluiu com dor generalizada em todo corpo, de forma constante e de mesma intensidade, associada a fadiga, principalmente após esforço físico, cefaleia, depressão e obstipação intestinal. No exame físico não havia artrite, observando-se dor a palpação da musculatura de todo o corpo. Exames laboratorias: TSH, VHS e PCR normais, com o fator reumatóide negativo. Considerando a principal hipótese diagnóstica, a conduta mais adequada é prescrever.

A. Prednisona.
B. Etoricoxibe.
C. Metotrexato.

D. Pregabalina.

QUESTÃO 127. A osteoporose é a doença metabólica mais frequente na população geral, afetando sobretudo mulheres pós- menopausa e homens idosos. Assinale os medicamentos cujo uso crônico se associa a um risco aumentado desta condição:

A. Hidroclorotiazida, heparina e carbamazepina.
B. Deflazacorte, heparina e carbamazepina.
C. Hidroclorotiazida, heparina e carbamazepina.
D. Deflazacorte, heparina e carisoprodol.

QUESTÃO 128. A osteoartrite é uma doença articular crônica, caracterizada por insuficiência cartilaginosa secundária a fatores mecânicos, genéticos, hormonais, ósseos e metabólicos. Sobre a fisiopatologia desta doença, é correto afirmar:

A. Os condrócitos são a maior fonte de enzimas degradadoras, sintetizando e ativando proteases, as quais atuam no catabolismo da cartilagem.
B. O fator de crescimento fibroblástico e o fator de crescimento insulínico desempenham importante papel na síntese de proteases.
C. Uma vez ativados, os condrócitos produzem óxido nítrico, o qual exerce vários efeitos anabólicos, aumentando a síntese de proteoglicanos.
D. A diminuição do ativador de plasminogênio e o aumento do nível do inibidor da atividade de plasminogênio (PAI-1) são os responsáveis pela maior produção de plasmina, a qual ativa a colagenase.

QUESTÃO 129. Mulher de 60 anos, profissão de bordadeira, antecedente de hipotireoidismo e diabetes mellitus tipo 2, em uso regular de Puran T4 125 mcg/dia e Metformina 500 mg, 2 vezes/dia, menopausada há três anos, refere dor tipo queimação, dormência, sensação de edema e congestão das mãos e perda da habilidade manual em ambas as mãos, de início há dois anos e piora considerável nos últimos seis meses. Ao exame físico, apresenta teste de Tinel positivo, bilateralmente, e atrofia tenar, principalmente à direita; ausência de sinais de artrite em punhos e articulações das mãos. Considerando-se a principal hipótese diagnóstica para o caso, a sintomatologia bilateral pode ser explicada pelos seguintes fatores:

A. Idade da paciente e profissão laboral.
B. Antecedente de hipotireoidismo e diabetes mellitus tipo 2.
C. Profissão laboral e gênero feminino.
D. Idade da paciente e antecedente de menopausa.

QUESTÃO 130. Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, cor branca e residente em Goiânia. Procurou médico por apresentar cinco nódulos na coxa direita. Ao exame por imagem os nódulos medem em média 5,0 cm cada um, são superficiais e não apresentam envolvimento neurovascular. O diagnóstico mais provável é:

A. Lipoma
B. Hemangioma
C. Rabdomiossarcoma embrionário
D. Sarcoma pleomórficos alto grau
E. Osteoma

QUESTÃO 131. Em relação aos tumores malignos de partes moles (sarcomas) podemos afirmar:

A. As metástases são geralmente para linfonodos
B. A ressonância magnética é bastante precisa no diagnóstico etiológico
C. São mais frequentes em crianças do que em idosos
D. Localização em retroperitônio é associada a pior prognóstico

QUESTÃO 132. São consideradas indicações para biópsia de um tumor de partes moles:

A. Crescimento rápido, com dor e rubor locais
B. Tamanho maior que 5 cm e evidência de crescimento progressivo
C. Surgimento e após trauma em paciente com história familiar de sarcoma

D. Lesão em proximidades de uma grande articulação

QUESTÃO 133. São características do estudo radiográfico, **EXCETO**:

A. Método multiplanar;
B. Utiliza radiação ionizante;
C. Deve ser realizado preferencialmente em pelo menos duas incidências;
D. Acessível.

QUESTÃO 134. Quais os métodos de imagem mais utilizados atualmente no estudo das afecções osteoarticulares?

A. Radiografia, Bursografia, Cintilografia Óssea e Ressonância Magnética;
B. Ultrassonografia, Tomografia computadorizada, Ressonância Magnética e Discografia;
C. Tomografia computadorizada, Mielografia, Radiografia e Ressonância Magnética;
D. Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética.

QUESTÃO 135. Estreitamento localizado do espaço articular, esclerose subcondral, osteófitos marginais e cistos subcondrais são achados de imagem comumente vistos em:

A. Osteoartrite;
B. Artrite Psoriásica:
C. Artrite Reumatóide;
D. Gota.

QUESTÃO 136. Considerando o laboratório na análise das causas mais frequentes de anemias no idoso, analise as afirmações abaixo e depois escolha a sequência de afirmações corretas (verdadeiras).

I - O exame com melhor relação custo/beneficio e maior poder de descriminação entre a Anemia Ferropriva, e a Anemia da doença crônica, ambas frequentes, é a dosagem de Ferro.

II - O exame com melhor relação custo/beneficio e maior poder de descriminação entre a Anemia Ferropriva, e a Anemia da doença crônica, ambas frequentes, é a dosagem de Ferritina.

III - A Contagem de Reticulócitos é muito útil na diferenciação da Anemia Ferropriva da Anemia Megaloblástica, também importante causa de anemia no idoso.

IV - A pesquisa de sangue oculto nas fezes deve ser solicitada quando estivermos diante de uma anemia microcitica e hipcrômica, com anisocitose, no idoso.

A alternativa com as afirmações corretas (verdadeiras) é:

A. I e IV
B. II e IV
C. I, III e IV
D. II, III e IV

QUESTÃO 137. Correlacione as colunas, associando os métodos laboratoriais abaixo às questões correspondentes (Prova de Título de Especialista em Reumatologia 2005 68 Rev Bras Reumatol, v. 46, n. 1, p. 61-68, jan/fev, 2006, com adaptações)

a) Imunofluorescência direta
b) Imunofluorescência indireta
c) ELISA
d) Western blot
e) Imunodifusão radial

( ) Soro do paciente contém anticorpos contra antígenos do núcleo de células em esfregaço de lâmina. Reação é lida no microscópio de

fluorescência, após a adição de anti-anticorpo marcado com fluoresceína.
( ) Soro do paciente é submetido a dosagem de C3 (ou pesquisa de anti-Ro, anti-La, anti Scl 70, por exemplo). O soro é colocado em placa de gel que contém anticorpos anti-C3 (ou anti-Ro, anti- La, anti Scl 70, por exemplo). Halo concêntrico se forma.
( ) Antígenos do DNA são separados do soro do paciente após corrente elétrica. A adição de anticorpos gera bandas específicas que podem ser radiografadas ou reveladas com corante.
( ) Espécime de biópsia de pele ou renal é submetido à pesquisa de IgG na junção dermo- epidérmica ou nos glomérulos e membrana. Uma anti-IgG marcada com fluoresceína é adicionada ao tecido.
( ) Soro do paciente é testado para anticorpos antiHbsAg. O soro é colocado em placas sólidas contendo HbsAg. Anti-anticorpos marcados com peroxidase são adicionados. A reação é lida em fotômetro após adição de cromogêneo.
A sequência correta é :

A. a-d-e-b-c
B. a-e-d-b-c
C. b-e-d-a-c
D. b-e-c-a-d

QUESTÃO 138. Relacione adequadamente as colunas, cada anticorpo com a doença em que ele mais frequentemente está positivo:
1. Anti-histonas
2. c-ANCA
3. Anti-RNP
4. Anti-DNA nativo
5. Anti-SSA/RO

( ) Doença Mista do Tecido Conjuntivo
( ) Nefrite Lúpica
( ) LES induzido por drogas
( ) Granulomatose com Poliangeíte-ex de Wegener
( ) Síndrome de Sjögren
A sequência correta está em

A. 1,2,3,4,5
B. 1,5,4,2,3
C. 3,4,1,2,5
D. 5,1,2,4,3

QUESTÃO 139. Estreitamento difuso do espaço articular, erosões marginais, cistos subcondrais, osteopenia e edema de tecidos moles periarticulares são achados de imagem característicos de:

A. Osteoartrite
B. Pioartrite;
C. Artropatia Inflamatória;
D. Gota.

QUESTÃO 140. São características do estudo radiográfico, **EXCETO**:

A. Método multiplanar;
B. Utiliza radiação ionizante;
C. Deve ser realizado preferencialmente em pelo menos duas incidências;
D. Acessível.

QUESTÃO 141. Quais os métodos de imagem mais utilizados atualmente no estudo das afecções osteoarticulares?

A. Radiografia, Bursografia, Cintilografia Óssea e Ressonância Magnética;
B. Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e Discografia;
C. Tomografia Computadorizada, Mielografia, Radiografia e Ressonância Magnética;
D. Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética.

QUESTÃO 142. Uma paciente de 50 anos há 8 meses vem evoluindo com dor e edema nas articulações das mãos e pés. Refere intensa rigidez matinal de mais de 1 hora, mas nega fenômeno de Raynaud, lesões cutâneas ou aftas orais bem como outras comorbidades exceto pelo tabagismo pesado. Exame físico dos sistemas sem alterações. Exame articular apresenta dor e edema nas interfalangeanas proximais das mãos, metacapofalangeanas bilaterais, punhos, joelhos e tornozelos. A radiografia das mãos mostra erosão óssea justa articular e o fator reumatoide em títulos altos. Em relação ao caso é correto afirmar:

A. A droga de escolha é a hidroxicloroquina
B. Deve ser iniciado o sulfato de glicosamina
C. Pode iniciar corticóide na dose antiinflamatória
D. A pregabalina deve ser iniciada após a crise

QUESTÃO 143. Sobre a gota, assinale a alternativa correta:

A. Classicamente se manifesta como monoartrite aguda, que se instala lentamente com poucos sinais flogísticos.
B. O nível sérico de ácido úrico pode ser normal durante a crise aguda de gota.
C. Se manifesta com crises recorrentes, porém não causa dano permanente nas articulações.
D. O alopurinol é a medicação indicada para tratar a crise aguda de gota.

QUESTÃO 144. Em relação ao lúpus eritematoso sistêmico, analise as seguintes assertivas.

I - A administração de imunossupressor, como a ciclofosfamida, está indicada no envolvimento sistêmico grave como a nefrite lúpica.

II - Pacientes com a presença de anticorpos antifosfolípides devem receber anticoagulação

III - No lúpus observa-se um aumento das proteínas do complemento, indicando atividade de doença.

IV - A presença do anti DNA dupla hélice é um marcador de atividade de doença bem como um marcador de nefrite.

São corretas:

A. I e II
B. I, II e IV
C. II e III
D. I e IV

QUESTÃO 145. Qual doença abaixo não cursa com artrite erosiva?

A. Síndrome de Sjögren
B. Artrite reumatoide
C. Artrite gotosa
D. Artrite psoriásica.

QUESTÃO 146. De acordo com as recomendações 2019 do Colégio Americano de Reumatologia para o tratamento da osteoartrite de mãos, joelhos e quadril, são fortemente recomendadas as seguintes, **EXCETO**:

A. Ortese para a 1a carpometacarpofalângica, nos casos de osteoartrite de mãos.
B. Uso de metotrexato via oral, nos casos de osteoartrite dos joelhos
C. Tai chi, nos casos de osteoartrite do quadril.
D. Uso de AINE tópico, nos casos de osteoartrite dos joelhos.

QUESTÃO 147. Homem de 67 anos, profissão de advogado, refere dor no ombro direito, que irradia para o braço, de intensidade variável e que piora durante a noite, quando se deita deste lado. Refere que o quadro iniciou há seis meses. Há um mês, apresentando piora da dor e limitação ativa dos movimentos do ombro e crepitação aos movimentos. Considerando a possibilidade de síndrome do manguito rotador para este paciente, qual dos testes realizados para avaliação da integridade dos tendões do manguito é exclusivo para avaliação do supraespinal?

A. Yocum
B. Gerber
C. Patte
D. Jobe

QUESTÃO 148. RHFF, 41 anos, sexo feminino, advogada, procurou o ambulatório de Reumatologia, com dores difusas em todo o corpo, sono não reparador, ansiedade, com início dos sintomas há nove meses. Exame físico: sem sinais de artrite, dor a palpação muscular nos quatro membros, sem outras anormalidades. Exames complementares: VHS e PCR normais, fator reumatoide negativo e hemograma normal. Sobre o caso acima, é verdadeiro

A. Deve-se solicitar polissonografia, punção liquórica e eletroneuromiografia dos quatro membros.
B. A pregabalina é considerada segura e eficaz no alívio dos sintomas apresentados.
C. O diagnóstico mais provável é o lúpus eritematoso sistêmico.
D. Deve-se medicar com metotrexato e cloroquina.

QUESTÃO 149. O tratamento de primeira linha para osteoporose inclui como opção o uso de drogas anti- catabólicas, também conhecidas como anti-reabsortivas, destacando-se neste grupo os bisfosfonatos. Dentre os bisfosfonatos podemos citar:

A. Abaloparatida
B. Romosozumabe
C. Denosumabe
D. Ibandronato

QUESTÃO 150. VAC, 44 anos, sexo masculino, professor, procurou o pronto socorro ortopédico para tratamento de entorse do joelho esquerdo, durante prática esportiva. Destacando-se que o paciente apresentava histórico de úlcera péptica e gastrite, no tratamento medicamentoso, deve-se utilizar preferencialmente:

A. Nimesulida
B. Piroxican
C. Etoricoxibe.
D. Diclofenaco

QUESTÃO 151. A Osteoporose é uma desordem osteometabólica caracterizada por fragilidade óssea e predisposição a fraturas. Em pacientes com osteoporose sem fratura, a abordagem fisioterápica preventiva deve preferencialmente incluir:

A. Hidroterapia
B. Alongamentos
C. Cinesioterapia global com impacto
D. Cinesioterapia localizada sem impacto

QUESTÃO 152. A Uma paciente de 88 anos foi admitida no serviço de urgência com fraqueza como queixa principal. Apresentava dispneia, sintomas gastrointestinais como náuseas e vômitos, dor abdominal, dispepsia, prurido e feridas na boca há 3 dias. Os sintomas foram progressivos. Na avaliação dos medicamentos consumidos foi determinado que ela está em uso contínuo de metotrexato (MTX) há cerca de 5 meses. Na busca da causa do uso de MTX e checagem das prescrições, foi revelado que a paciente recebeu por engano MTX ao invés de digoxina. Ela havia usado MTX 1,25 mg por 5 meses consecutivos, e 2,5 mg cinco dias por semana no último mês. Considerando a sua hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que indica a melhor opção terapêutica a ser instituída:

A. A retirada do MTX e a administração de ácido folínico (leucovorina)
B. A retirada do MTX e a administração de ácido fólico
C. A retirada do MTX e a administração de vitamina E
D. Continuação com MTX e a administração de ácido folínico (leucovorina)

QUESTÃO 153. Um paciente com insuficiência renal crônica em tratamento conservador, foi internado na Unidade Coronariana com angina instável. Apresentou, durante sua internação, quadro agudo de artrite na articulação metatarsofalangeana e tornozelo. Relatou que já havia sofrido quadro semelhante previamente. Considerando a sua hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que melhor indica o diagnóstico de artrite e opção terapêutica a ser instituída.

A. Artrite Reumatoide e colchicina
B. Gota e alopurinol

C. Gota e antiinflamatório não hormonal

D. Gota e corticosteróides

QUESTÃO 154. Sobre a artrite reumatoide, julgue as alternativas e responda:

I. A artrite reumatoide é uma doença autoimune em que o sistema imunológico a sinóvia e causa o acúmulo de líquido nas articulações, perda debilitante de cartilagem, fraqueza óssea e deformidade articular. É uma condição crônica e progressiva, podendo haver longos períodos de remissão (sem sintomas).

II. Paciente com artrite reumatóide estabelecida e com baixa atividade da doença nunca fez uso de um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), deve iniciar a monoterapia com metotrexato.

III. Paciente com artrite reumatoide estabelecida e com baixa atividade da doença nunca fez uso de um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), deve iniciar a monoterapia com um inibidor do fator de necrose tumoral (TNF) como monoterapia.

IV. Paciente com artrite reumatoide estabelecida em caso de falha da monoterapia inicial com um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), por exemplo metotrexato, é indicada uma terapia com a combinação dupla ou tripla de DMARD convencional (Metotrexato, leflunomida, sulfassalazina, cloroquina e hidroxicloroquina).

A. Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C. Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
D. Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 155. A respeito dos fármacos antirreumáticos modificadores da doença, julgue as alternativas e responda:

I. O metotrexato é um fármaco de primeira escolha, que tem atividade citotóxica e imunossupressora.

II. A tempo de 1⁄2 vida da leflunomida é reduzida pela interação medicamentosa com colestiramina A.

III. A ciclosporina inibe a atividade dos linfocitos T efetores CD8+.

IV. O tofacitinibe e o baricitibe são anticorpos monoclonais que inibem a via de sinalização JAK-STAT.

A. Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C. Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
D. Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 156. Qual das seguintes neoplasias é mais frequente na faixa etária pediátrica?

A. Tumor de células gigantes
B. Osteossarcoma
C. Condroblastoma
D. Condrossarcoma

QUESTÃO 157. Em relação aos tumores malignos de partes moles (sarcomas), assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. As metástases são geralmente linfáticas
B. A ressonância magnética não é precisa na definição do tipo histológico
C. São mais frequentes em idosos.
D. Localização em retroperitônio é associada a pior prognóstico

QUESTÃO 158. Paciente do sexo feminino, cor branca e 25 anos de idade. Procurou médico por apresentar aumento de volume na região do joelho direito e dor local intermitente. Ao exame físico apresentava limitação dos movimentos. A radiografia evidenciou lesão

tibial epifisária, derrame articular, fratura patológica, rarefação óssea, fina trabeculação e limites nítidos. Na macroscopia da peça cirúrgica evidenciou-se lesão volumosa, densa, avermelhada e com lacunas hemorrágicas. Na microscopia a neoplasia é constituída por tecido com, rica vascularização e grande número de células gigantes multinucleadas. O diagnóstico menos provável é:

A. Sarcoma fibromixóide de baixo grau
B. Mieloma múltiplo
C. Rabdomiossarcoma
D. Sarcoma de Ewing

QUESTÃO 159. Criança é diagnosticada com displasia do desenvolvimento do quadril. Podemos dizer que o quadril instável é aquele que:

A. Está reduzido e luxa quando fazemos manobra de abdução
B. É aquele que tem a cabeça femural com 50% de cobertura pelo acetábulo
C. Está reduzido e luxa quando realizamos manobra de adução
D. Apresenta incongruência entre a epífise femural e o acetábulo

QUESTÃO 160. Você é cirurgião plástico e está explicando as vantagens do uso de uma auto-enxerto para seus residentes. Qual das seguintes afirmativas está correta?

A. Boa tolerância e incorporação
B. Evita um sítio doador
C. Sem limite de quantidade de tecido
D. Redução da morbidade inicial

QUESTÃO 161. Nas fraturas de úmero proximal a tuberosidade maior está desviada para:

A. Inferior e anterior
B. Inferior e posterior
C. Superior e anterior
D. Superior e posterior

QUESTÃO 162. Paciente, 45 anos, sexo feminino apresenta fratura de úmero fechada com desvio, deve-se:

A. Colocar gelo no local e não imobilizar, uma vez que a fratura está desviada
B. Reduzir a fratura bem lentamente e imobilizar o local atingindo a articulação acima e abaixo da lesão
C. Colocar gelo sobre a área desviada e fazer curativo compressivo, antes de imobilizar apenas o local da fratura
D. Imobilizar o local, atingindo a articulação acima e abaixo da lesão, sem reduzir a fratura

QUESTÃO 163. Uma mulher de 75 anos, portadora de hemiplegia Direita pós AVCH foi reabilitada por um equipe multiprofissional por 1 ano, tendo evoluído de uma condição de dependência total em todas as atividades para uma condição de independência para autocuidados e dependência e transferências. Após a alta deste Centro de Reabilitação, procurou parcial para marcha outro serviço de reabilitação com objetivo de obter maior destreza para atividades bimanuais, pois decidiu dedicar-se aos trabalhos artesanais para obter seu sustento. Assinale a alternativa correta:

A. O programa de reabilitação não atingiu seu objetivo
B. Os autocuidados são o principal objetivo do programa de reabilitação
C. Como a paciente é hemiplégica, ela não vai conseguir destreza para atividades bimanuais, por isso necessita na verdade é de uma abordagem psicológica para trabalhar o limite de seus ganhos funcionais.
D. A mudança de objetivos do paciente durante o programa de reabilitação é frequente, conforme os ganhos funcionais, e a equipe deve estar atenta para isso.

QUESTÃO 164. Qual o 1 sinal clínico que deve chamar a atenção do médico para a possibilidade de lesão vascular em fraturas do ombro?

A. Parestesias
B. Pulso radial ausente
C. Palidez da mão

D. Diminuição da temperatura do membro

QUESTÃO 165. Sobre lombalgia marque a correta.

A. É uma queixa comum no consultório, com diagnóstico etiológico sendo esclarecido na maioria dos casos, sendo as compressões por hérnia e estenoses de cana lombar as maior causas
B. A maioria são lombalgias agudas.
C. Uma hérnia discal centro-lateral L4L5 provavelmente comprimirá a raiz de L5.
D. O tratamento inicial de um paciente com hérnia discal L4L5 com compressão nervosa importante à RM é o tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 166. Paciente sexo feminino, 42 anos, sedentária, vem apresentando lombalgia há 3 meses. A dor piora a movimentação, não tem irradiação. Nega alterações esfincterianas, perda de peso, febre ou déficit de força. A conduta médica inicial deve ser:

A. Solicitar Ressonância de coluna lombar, por ter essa queixa de forma persistente e crônica.
B. Encaminhar a reabilitação para melhora da mobilidade, flexibilidade e fortalecimento muscular, e orientações posturais.
C. Prescrever anti-inflamatório associado a miorrelaxante por 6 semanas.
D. Provavelmente se trata de hérnia discal, pela característica da dor.

QUESTÃO 167. Os estágios de desenvolvimento das úlceras por pressão descritos por EDBERG são:

A. Hiperemia, isquemia, necrose e ulceração.
B. Necrose, isquemia, ulceração e hiperemia.
C. Isquemia, hiperemia, necrose e ulceração.
D. Ulceração, necrose, hiperemia e isquemia.

QUESTÃO 168. A escoliose idiopática do adolescente acomete principalmente?

A. Meninas entre 11 e 18 anos de idade
B. Meninos entre 11 e 18 anos de idade
C. Meninas entre 12 e 25 anos de idade
D. Meninos entre 12 e 25 anos de idade

QUESTÃO 169. Um médico residente de geriatria estava acompanhando um paciente idoso e diagnosticou um tumor intestinal. O preceptor orientou que ele fizesse uso do protocolo SPIKES. Qual dos seguintes itens **NÃO** é contemplado pelo protocolo citado?

A. Ambiente adequado e postura profissional.
B. Acolhimento, escuta ativa e comunicação clara.
C. Percepção do desejo do paciente pela informação
D. Dar a informação de forma completa sobre o final da vida

AS QUESTÕES 170, 171, 172 e 173 REFEREM-SE AO CASO CLÍNICO ABAIXO: Senhor X, de 82 anos, hipertenso, diabético e portador de hipotireoidismo e neuropatia diabética. Fazia uso de Losartana, Anlodipino, Metformina, Pregabalina, Duloxetina e Levotiroxina. Pratica exercícios físicos regulares. Peso habitual: 60 Kg. Estatura: 1,64 m, IMC: 23 Kg/m2, Circunferência de Panturrilha (CP): 33 cm. Nos últimos 6 meses, apesar do bom controle glicêmico e da função tiroidiana estar normal, diminuiu a ingestão de alimentos e perdeu 8 Kg. Há 30 dias, apresentou duas quedas da própria altura e, após as quedas, os níveis glicêmicos elevaram-se, sendo necessária a introdução de insulina. Há uma semana, foi ao consultório do geriatra, sendo constatados: peso de 52 Kg, IMC de 20 Kg/m2, CP de 30 cm, velocidade da marcha de 0,6 m/s e força de preensão palmar de 23 Kg. Levou o laudo de uma densitometria corporal total (DXA) mostrando massa muscular esquelética apendicular (braços e pernas) de 17 Kg.

QUESTÃO 170. Dentre as alterações apresentadas pelo Senhor X citadas abaixo,

qual faz parte dos critérios do fenótipo de fragilidade de Fried (2001) para o diagnóstico de fragilidade?

A. Diminuição da CP para menos de 31 cm.
B. Queda da própria altura.
C. Redução da força de preensão palmar.
D. Diminuição do IMC para menos de 23 Kg/m2

QUESTÃO 171. De acordo com os dados clínicos apresentados pode-se dizer que, levando-se em conta o fato do Senhor X ser idoso, ele é portador de:

A. Comorbidade, polifarmácia e obesidade
B. Multimorbidade, polifarmácia e baixo peso
C. Complicações de doença crônica, mas não tem polifarmácia.
D. Multimorbidade complexa, polifarmácia e peso normal.

QUESTÃO 172. Os dados clínicos permitem afirmar que o Senhor X:

A. tem sarcopenia grave.
B. em sarcopenia apenas
C. tem sarcopenia provável
D. não tem sarcopenia

QUESTÃO 173. Após otimização da prescrição medicamentosa, com retirada da Metformina e do Anlodipino e ajuste da dose da Insulina, Senhor X foi encaminhado a um fisioterapeuta para melhora da atividade física e iniciou um programa de intervenção nutricional. Apesar da hipertensão e da diabetes, a função renal estava preservada. Quanto de proteína ele deve ingerir por dia?

A. 52 g ao dia antes do café-da-manhã.
B. 78 g ao dia divididas nas três principais refeições
C. 156 g ao dia divididas nas três principais refeições.
D. 90 g ao dia em uma dose de suplemento após a atividade fisica.

QUESTÃO 174. A desprescrição de medicamentos está indicada principalmente quando ele faz uso regular de para um paciente de mais de 80 anos

A. medicamentos potencialmente inapropriados para idosos.
B. dois medicamentos para uma mesma doença crônica.
C. doses recomendadas para adultos jovens.

AS QUESTÕES 175 E 176 REFEREM-SE AO CASO CLÍNICO ABAIXO:

O Senhor Y de 63 anos, administrador, é trazido em consulta pela esposa que informa história de que há 2 anos o paciente começou a envolver-se em brigas e discussões, "não media mais as palavras", "não suportava ser corrigido". Nessa época foi demitido. Afirmava que era "mais brilhante que todos da empresa e isso despertou inveja". Tentou novo emprego, mas não conseguiu adaptar-se às novas tarefas. Logo, abandonou o emprego ("era um profissional muito bom para aquilo"). Há 6 meses está com perda de autocuidado e aumento exagerado do consumo de álcool. Frequentemente sai do banheiro e não fecha a calça, mesmo em locais públicos. Já expulsou visitas de casa sem motivo e de maneira grosseira. Mais recentemente, anda muito desinteressado, sem vontade e não se preocupa com ninguém, nem mesmo quando os seus dois netinhos pequenos adoecem. Durante a consulta a única queixa que apresenta é de dificuldade de dormir, mas levanta-se diversas vezes e caminha pelo consultório, vai até a janela e repete a mesma frase: "Vai chover logo". A pontuação do MEEM foi de 29 pontos, a do Pfeffer de 16 pontos e da Escala de Depressão Geriátrica foi de 1 ponto. Foi solicitada uma avaliação neuropsicológica que mostrou prejuízo na atenção, linguagem, planejamento, organização, resolução de problemas e abstração. Os outros domínios cognitivos estão preservados.

QUESTÃO 175. Assinale a alternativa que apresenta qual é o diagnóstico mais provável para o caso do Senhor Y.

A. Provável demência mista (Alzheimer associada à vascular)
B. Provável demência frontotemporal variante de linguagem.
C. Possível demência por doença de Alzheimer pré-senil.
D. Possível demência frontotemporal variante comportamental.

QUESTÃO 176. Você é o médico que está avaliando o Senhor Y. Fez a sua hipótese diagnóstica e solicitou exames laboratoriais e de imagem cerebral. Os exames laboratoriais não mostraram alterações que pudessem justificar o quadro e a Ressonância Magnética do Crânio não mostrou atrofia cerebral e o paciente tinha leve microangiopatia (Fazekas 1). Dentre os exames abaixo, qual você solicitaria a seguir por ser mais útil para a confirmação da hipótese diagnóstica?

A. Biomarcadores liquóricos (Proteínas TAU e Beta-amiloide)
B. SPECT (cintilografia de perfusão) cerebral
C. Eletroencefalograma.
D. Polissonografia.

QUESTÃO 177. A Síndrome da Imobilidade é muito conhecida pelos Geriatras e sua detecção impacta diretamente sobre o prognóstico e orientações aos familiares para cuidados com os pacientes Sobre ela, assinale a alternativa que contenha um critério diagnóstico maior e um menor, respectivamente.

A. Déficit cognitivo grave e múltiplas contraturas.
B. Disfagia grave e dupla incontinência.
C. Múltiplas contraturas e afasia.
D. Lesão por pressão e disfagia.

QUESTÃO 178. 43. A carga e a complexidade de sintomas ao fim de vida de diversas doenças crônicas são altas, assim, o ideal é que a avaliação dessas queixas sejam sistemáticas e regulares. Analise as afirmativas abaixo que se referem à escala de avaliação de sintomas de Edmonton (ESAS) e marque a alternativa verdadeira:

A. Trata-se de escala de graduação que classifica a intensidade do sintoma de forma qualitativa apenas (leve, moderado e intenso
B. Avalia sempre vinte sintomas básicos, dentre os quais constam prurido, agitação psicomotora e alterações do aspecto da pele
C. Existe a possibilidade de acrescentar outros sintomas para serem avaliados além dos sintomas básicos sempre presentes na escala.

QUESTÃO 179. Paciente de 82 anos, masculino, portador de diabetes, hipertensão, osteoartrite de joelhos e doença de Parkinson com disfagia. É admitido no hospital com pneumonia aspirativa e evolui com sepsis e insuficiência renal aguda. Pode-se dizer que o paciente é portador de multimorbidade, porque apresenta

A. condição que acontece como complicação de uma doença crônica (pneumonia aspirativa na doença de Parkinson).
B. simultaneamente duas ou mais doenças crônicas (diabetes, hipertensão, osteoartrite de joelhos e doença de Parkinson).
C. doença aguda (pneumonia) na vigência de doenças crônicas (diabetes, hipertensão, osteoartrite de joelhos e doença de Parkinson).
D. complicações graves (sepsis e insuficiência renal aguda) de uma doença aguda (pneumonia aspirativa).

QUESTÃO 180. Até o ano de 2050, o grupo populacional que apresentará o maior crescimento percentual no Brasil é o de

A. 80 e mais anos
B. 15 a 59 anos.
C. 60 e mais anos
D. zero a 14 anos

QUESTÃO 181. A Síndrome Geriátrica difere de uma síndrome clínica tradicional porque

A. compromete a capacidade para executar as atividades básicas da vida diária.
B. acomete exclusivamente a população com mais de 60 anos de idade.
C. está associada a diminuição da sobrevida além dos oitenta anos de idade.
D. é causada por múltiplos fatores que ocorrem concomitantemente.

QUESTÃO 182. Em um homem de 65 anos com demencia leve, qual é a diagnostico etiológico mais provável se alucinações visuais tambem estiverem presentes desde a inicio da sintomatologia?

A. Demência vascular
B. Demência frontotemporal
C. Demência por corpos de Lewy
D. Doença de Alzheimer

QUESTÃO 183. Qual dos seguintes sinais ou sintomas NÃO é comum no delirium?

A. Confusão mental
B. Início gradual
C. Desorientação
D. Dificuldade em manter a atenção

QUESTÃO 184. Qual dos seguintes sinais e sintomas NÃO é encontrado tanto no delirium como na demência em fase leve a moderada?

A. Alterações da linguagem
B. Alterações da consciência
C. Alterações da cognição
D. Delírios e alucinações

QUESTÃO 185. De acordo com os critérios diagnósticos, para que o individuo seja considerado portador de demência é necessário que ele apresente alterações da cognição com comprometimento

A. da sua capacidade para executar as atividades da vida diária.
B. da sua capacidade de dirigir veículos automotores.
C. da sua capacidade de praticar atividades físicas.
D. da sua capacidade de manter as continências urinária e fecal.

QUESTÃO 186. O paciente de 82 anos descrito na questão 1 faz uso de: 1 comprimido ao dia de Losartana associada a Hidroclorotiazida para a hipertensão, 4 comprimidos ao dia de Levodopa associada a Carbidopa para a doença de Parkinson. 2 comprimidos ao dia de Metformina para o diabetes. 1 comprimido Diacereína para a osteoartrite. Formoterol associado a Budesonida por via inalatória para o DPOC.
Sobre a prescrição desse paciente pode-se dizer que

A. não é polifarmácia, pois utiliza apenas 4 apresentações de medicamentos e a quinta apresentação é utilizada por via inalatória.
B. é polifarmácia pois o que conta para a sua definição é o número de comprimidos e este paciente faz uso de 8 comprimidos ao dia.
C. é polifarmácia, pois utiliza mais de 5 princípios ativos diferentes, mesmo que associados em única apresentação e por via inalatória.
D. não é polifarmácia, já que não usa mais de 5 princípios ativos para tratar uma única doença, pois cada uma de suas doenças é tratada por no máximo 2.

QUESTÃO 187. Dos medicamentos abaixo qual é considerado inapropriado para uma paciente de 92 anos, com història de hipertensão e dislipidemia, portadora de demência vascular há 12 anos, com crises convulsivas, acamada, que não fala mais de 6 palavras ao dia, emagrecida, ingerindo apenas de alimentos pastosos e liquidos espessados, com dupla incontinência e úlcera por pressão estágio II na região sacral?

A. Estatinas.
B. Antiemeticos
C. Analgésicos
D. Antiepilépticos.

QUESTÃO 188. Mulher de 75 anos; portadora de hipertensão, diabete e osteoporose; sofreu queda da própria altura em sua casa, após tropeçar no tapete. A densitometria mostrou

osteoporose e a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) mostrou:
Get Up and Go cronometrado (TGUG ou teste do "levantar e andar"): 24 segundos
Mini Exame do Estado Mental: 28/30 pontos (sem déficit cognitivo)
Índice de Barthel: 95/100 pontos (independente para as Atividades Básicas da Vida Diária ABVD)
Questionário de Pfeffer: 12/33 pontos (incapacidade leve para as Atividades Instrumentais da Vida Diária - AIVD)
Mini Avaliação Nutricional: 25/30 pontos (nutrida)
Escala de Depressão Geriátrica: 14/15 pontos (presença de sintomas depressivos) a maior preditor de futuras quedas para essa idosa é

A. o fato de ter osteoporose.
B. a presença de sintomas depressivos.
C. a incapacidade para as AIVD.-
D. o desempenho no TGUG

QUESTÃO 189. A gota é um distúrbio metabólico que se manifesta por níveis elevados de ácido úrico sérico, crises recorrentes de artrite aguda e formações crônicas de cristais de monurato de sódio. Pode ser classificada como primária ou secundária (quando se relaciona a outras condições que concorrem para o acúmulo de ácido úrico sérico). O principal mecanismo da hiperuricemia em pacientes com gota primária é:

A. Dieta rica em purinas
B. Aumento da taxa de renovação celular
C. Diminuição da excreção renal de ácido úrico
D. Deficiência total da enzima hipoxantinaguanina fosforribosiltransferase (HGPRT- ase)

QUESTÃO 190. Sobre as fraturas transtrocanterianas, marque a correta:

A. São fraturas com altos índices de pseudoartrose por acometerem região de osso osteoporótico
B. Podem ser tratadas com fixação dos fragmentos e nos pacientes com boa capacidade de deambular dá-se preferência para as artroplastias totais de quadril
C. São classificadas por Tronzo, sendo as fraturas tipo I e II mais estáveis
D. O tratamento deve sempre ser realizado de urgência pelo alto risco de necrose da cabeça do fêmur

QUESTÃO 191. Paciente, 40 anos, sofreu queda da própria altura com trauma de cotovelo direito. Encaminhada do PS há 14h, atendida imediatamente pelo traumatologista. Exame físico: pele íntegra, edema e deformidade ao nível do cotovelo, neurovascular normal. Radiografia mostra luxação póstero-lateral do cotovelo. A conduta correta é:

A. Redução fechada imediata na sala de gesso, imediatamente após diagnóstico
B. Encaminhamento para centro cirúrgico para redução aberta e reparação ligamentar, necessária de rotina
C. Redução incruenta sob anestesia
D. Colocação de tala gessada, internar o paciente e programar redução no centro cirúrgico na manhã do dia seguinte, em condições ideais

QUESTÃO 192. Mulher, 32 anos, apresenta-se com queixa de fraqueza muscular proximal, de início há vinte dias e piora progressiva, acompanhada de heliotropo nas regiões palpebrais e sinal de Gottron nas MCFs e IFPS.
Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é:

A. LES
B. Vasculite urticária
C. Reação de hipersensibilidade
D. Dermatomiosite

QUESTÃO 193. Criança obesa, 10 anos, claudicando, com dor no quadril e marcha com rotação externa do membro acometido. Das doenças abaixo, qual a mais provável?

A. Doença de Legg-Calvé-Perthes
B. Artrite reumatóide juvenil
C. Epifisiólise proximal do fêmur
D. Sinovite transitória do quadril

QUESTÃO 194. Na paralisia cerebral do tipo hemiparesia espástica tipo III, o paciente apresenta:

A. Deformidade somente do pé
B. Deformidade do pé e joelho
C. Deformidade do pé, joelho e quadril
D. Deformidade do joelho e quadril

QUESTÃO 195. As fraturas com maior facilidade para consolidação são aquelas que apresentam:

A. Traço cominutivo
B. Traço espiral
C. Desvio em valgo
D. Desvio em varo

QUESTÃO 196. O LES é diagnosticado com base em critérios clínicos e laboratoriais. Sobre os auto-anticorpos associados à enfermidade, é verdadeiro:

A. O anti-Sm é também observado na artrite reumatóide
B. O anti-RNP é também observado na síndrome de Sjögren
C. O Anti-Ro e Anti-La são também observados na esclerodermia
D. Anti-coagulante lúpico, quando positivo, pode indicar síndrome do anticorpo antifosfolípide secundária

QUESTÃO 197. O fator reumatóide é um auto-anticorpo produzido contra a fração Fc da IgG e pode ser encontrado na seguinte condição clínica:

I- Síndrome de Sjögren
II - Hepatite C
III - Artrite Reumatóide

Estão corretas as assertivas:

A. I e II.
B. II e III
C. Somente III.
D. I, II e III

QUESTÃO 198. Em relação à epidemiologia do trauma raquimedular, podemos afirmar que:

A. A principal causa são os ferimentos por arma de fogo, consequentes à grande violência urbana que enfrentamos atualmente.
B. É muito mais comum o acometimento da região lombar, mais exposta a traumas no trânsito ou trauma diretos.
C. A principal causa são os acidentes de trânsito, responsáveis por mais de 50% dos casos.
D. É muito mais comum o acometimento da região torácica, mais exposta a traumas, sejam por arma de fogo ou acidente de trânsito.

QUESTÃO 199. A densitometria óssea é um exame considerado padrão ouro no diagnóstico da osteoporose. Tal procedimento deve ser realizado na seguinte circunstância:

A. Homens a partir dos 40 anos, independente de fatores de risco
B. Mulheres a partir dos 40 anos, independente de fatores de risco
C. Mulheres no primeiro ano após a menopausa
D. Mulheres com mais de 65 anos

QUESTÃO 200. Qual a afirmação correta?

A. A fratura desviada consolida 2x mais rápido que a fratura não desviada
B. A consolidação radiológica da fratura precede a consolidação clínica
C. Toda fratura desviada é cirúrgica
D. Toda fratura intra-articular necessita redução anatômica

QUESTÃO 201. A osteoporose é uma desordem caracterizada por diminuição da massa óssea e maior risco de fraturas. Das medicações abaixo, assinale aquela associada à um maior risco para tal enfermidade:

A. Hidroclorotiazida
B. Heparina
C. Loratadina
D. Carvedilol

QUESTÃO 202. Paciente, 18 anos, vítima de acidente automobilístico. Atendido no PS. Foi feito o diagnóstico de fratura de diáfise de úmero, simples, fechada e com desvio segmentar em varo. [...]

A. Anterior
B. Medial

C. Lateral
D. Posterior

QUESTÃO 203. A sacroileíte é achado característico das espondiloartrites, cujo protótipo é a espondilite anquilosante. Tal achado pode ser detectado ao exame físico através da manobra de:

A. Tinel
B. Patrick-Fabere
C. Phalen
D. Thompson

QUESTÃO 204. A velocidade de hemossedimentação (VHS) avalia a resposta inflamatória de fase aguda através da medida de

A. Haptoglobina
B. Amilóide A
C. Fibrinogênio
D. Albumina

QUESTÃO 205. O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença reumática de etiologia desconhecida e natureza autoimune. Acerca do envolvimento renal na enfermidade, assinale a assertiva verdadeira:

A. Geralmente pacientes com nefrite lúpica em atividade apresentam anticoagulante lúpico positivo
B. È raro o envolvimento renal no LES
C. A glomerulonefrite proliferativa difusa (classe IV) é a classe histológica mais frequentemente observada
D. A biópsia renal é contra-indicada em pacientes com proteinúria maciça pelo risco de sangramento

QUESTÃO 206. As espondiloartrites são doenças que compartilham características clínicas, laboratoriais e genéticas. Sobre tais enfermidades, é verdadeiro:

A. É comum o achado de entesopatia do calcâneo
B. Poliartrite crônica de pequenas articulações é a apresentação mais comum da espondilite anquilosante
C. A coriorretinite é a manifestação oftalmológica mais comum no grupo
D. A artrite psoriásica geralmente antecede o diagnóstico de psoríase cutânea

QUESTÃO 207. As espondiloartrites abrangem um grupo de doenças que apresentam peculiaridades epidemiológicas, clínicas, radiográficas e imunogenéticas. Sobre as características desse grupo é correto afirmar que:

A. Apresentam acometimento da coluna vertebral em especial do segmento cervical, com subluxação atlas-áxis
B. A agregação familiar é marcante, sendo o fator maior de risco a positividade para o Anti CCP
C. O acometimento ocular é importante, caracterizado como iridociclite, unilateral, recidivante
D. O envolvimento articular periférico caracteriza-se por comprometimento assimétrico de grandes articulações de membros superiores.

QUESTÃO 208. Na classificação de Herring para doença de Perthes, o tipo:

A. A é caracterizado por 50% de achatamento do pilar lateral
B. B é caracterizado por 70% de achatamento do pilar lateral
C. B é caracterizado por 60% de achatamento do pilar lateral
D. C é caracterizado por achatamento acima de 50% do pilar lateral

QUESTÃO 209. Os anti-inflamatórios são um grupo de fármacos que têm em comum o objetivo de controlar a inflamação e promover a analgesia. Podem ser classificados em anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e esteroidais (corticosteróides). Sobre essas medicações marque a alternativa correta:

A. A nimesulida e o meloxicam são considerados AINE não seletivos
B. Os AINES seletivos cox 2 não necessitam de monitorização de função renal.
C. Os corticosteróides quando usados a longo prazo, porém em doses baixas,

não requerem avaliação da massa óssea.

D. O uso crônico de corticosteróides por via inalatória ou tópica pode acarretar em eventos adversos semelhantes ao da terapia oral.

QUESTÃO 210. Marque a correta:

A. A classificação de Gustillo para fraturas expostas é baseada na avaliação do tamanho do ferimento (até 1, de 1 a 10 e maior de 10 cm)
B. Paciente caiu do cavalo no curral com fratura da perna com ferimento de cerca de 4 cm ao nível da fratura, sem pulso na topografia da a. tibial posterior. O seu diagnóstico é: fratura exposta da perna grau II de Gustillo
C. A complicação mais temida na fratura exposta é a infecção e por isso é muito importante a limpeza e o desbridamento desses ferimentos
D. O tratamento da fratura exposta pode ser conservador, principalmente nos casos com mais de 6h de exposição

QUESTÃO 211. Serafina, 30 anos, iniciou há 3 meses quadro de astenia, artralgia com edema articular associado em punhos, metacarpofalangeanas e joelhos. Concomitante apresentou erupção maculopapular na região malar e no dorso do nariz persistente, exacerbada com exposição solar e urina espumosa. Hemograma: Hb: 11,0 g/dl (VR: 12-16 g/dl), Leucócitos: 3000/mm3 (VR: 4000- 11000/mm3), Plaquetas: 80.000/mm3 (150.000- 400.000/mm3). Considerando sua principal hipótese diagnóstica, o padrão do FAN esperado é:

A. Nuclear pontilhado fino
B. Nuclear homogêneo
C. Nuclear pontilhado fino denso
D. Nuclear pontilhado centromérico

QUESTÃO 212. Mulher, 68 anos, IMC = 23. Procura assistência médica com história de dor em joelhos, de início há dois anos. Relata piora com as atividades laborais e melhora com o repouso. Ao exame físico, observa-se aumento de volume dos joelhos, crepitação bilateral e dor nos movimentos. Baseando-se na principal hipótese diagnóstica, a conduta neste caso deverá incluir a seguinte orientação:

A. Uso de bengala, para amortecer o peso sobre os joelhos.
B. Artroplastia bilateral, imediatamente.
C. Controle do peso, pois a obesidade apresentada pela paciente é um fator que pior sua doença articular.
D. Prescrição de prednisona, 20 mg/dia, VO, durante 30 dias, devido ao quadro inflamatório.

QUESTÃO 213. Na investigação diagnóstica de um paciente com suspeita de fratura dos ossos da perna [...] pedir radiografias nas seguintes incidências:

A. AP, perfil, oblíqua D, oblíqua E
B. AP, perfil e axial do tornozelo
C. AP e perfil
D. AP, perfil e axial da patela

QUESTÃO 214. A osteoporose é uma doença osteometabólica caracterizada por redução na densidade mineral óssea e aumento no risco de fraturas. Em seu tratamento, a atividade física deve ser encorajada. Assinale a atividade mais indicada para ganho de massa óssea e prevenção de fraturas:

A. Hidroginástica
B. Natação
C. Alongamento
D. Musculação

QUESTÃO 215. Quais as áreas mais sujeitas às úlceras de pressão?

A. Tuberosidade isquiática, trocanter, região sacra
B. Calcanhar, joelhos, trocanter
C. Trocanter, calcanhar, nuca
D. Cotovelo, região zigomática, ombro

QUESTÃO 216. Em relação às fraturas (?) de diáfise da tíbia é correto afirmar que:

A. A fratura é mais comum no sexo feminino
B. Não é indicado tratamento conservador por ser um osso que [...]
C. A fixação com placa e parafuso é uma das formas (?) de tratamento cirúrgico
D. Não há associação com lesões de estrutura do joelho (ligamentos [...]) anterior e posterior (?)

QUESTÃO 217. A paralisia cerebral é uma patologia:

A. Evolutiva, causando por lesão nos núcleos da base
B. Não evolutiva, causada por lesão no cérebro imaturo
C. Lentamente progressiva, causada por lesão piramidal
D. Caracterizada por déficit cognitivo em 85% dos casos

QUESTÃO 218. Sobre as fraturas do colo do fêmur, marque a <u>incorreta</u>:

A. Via de regra, nos pacientes mais jovens normalmente se preconiza a fixação da fratura e nos mais idosos se utiliza mais as artroplastias
B. Apresentam complicações como pseudoartrose e necrose avascular da cabeça que são menos comuns nas fraturas transtrocanterianas
C. São classificadas por Garden em quatro tipos, sendo as de grau I e II estáveis e as de grau III e IV instáveis
D. As estáveis são de tratamento conservador, com bons índices de consolidação

QUESTÃO 219. Joana, 35 anos, gestante, costureira, com sensação de formigamento e queimação em mãos, principalmente no período noturno. Procurou o reumatologista apresentando, ao exame físico, sinais de Tinel e Phalen positivos, bilateralmente. Considerando a distribuição do nervo acometido, esta paciente apresentou parestesia, especificamente, em:

A. Primeiro, segundo, terceiro e parte do quarto dedo
B. Segundo, terceiro e quarto dedos
C. Todos os dedos das mãos exceto polegar
D. Todos os dedos das mãos

QUESTÃO 220. A gota é um distúrbio metabólico que se manifesta por níveis elevados de ácido úrico sérico, crises recorrentes de artrite aguda e formações crônicas de cristais de monurato de sódio. Pode ser classificada como primária ou secundária (quando se relaciona a outras condições que concorrem para o acúmulo de ácido úrico sérico). O principal mecanismo da hiperuricemia em pacientes com gota primária é:

A. Dieta rica em purinas
B. Aumento da taxa de renovação celular
C. Diminuição da excreção renal de ácido úrico
D. Deficiência total da enzima hipoxantinaguanina fosforribosiltransferase (HGPRT- ase)

QUESTÃO 221. Joana, 35 anos, gestante, costureira, com sensação de formigamento e queimação em mãos, principalmente no período noturno. Procurou o reumatologista apresentando, ao exame físico, sinais de Tinel e Phalen positivos, bilateralmente. Considerando a distribuição do nervo acometido, esta paciente apresentou parestesia, especificamente, em:

A. Primeiro, segundo, terceiro e parte do quarto dedo
B. Segundo, terceiro e quarto dedos
C. Todos os dedos das mãos exceto polegar
D. Todos os dedos das mãos

QUESTÃO 222. Uma paciente de 58 anos apresenta-se no ambulatório com história de dor no joelho direito há há intensificado da dor. Aos exames no joelho direito, observa-se crepitação a movimentação anos com piora há 4 meses, associado a rigidez matinal de 25 minutos. Durante a deambulação, ativa e passiva. Qual o diagnóstico?

A. Artrite reumatoide
B. Doença por pirofosfato de cálcio

C. Osteoartrite
D. Condromalácia de patela

QUESTÃO 223. Uma paciente de 38 anos relata 2 anos de evolução de dor e aumento de volume das articulações 2as, 3as, e 4as metacarpofalangeanas, os punhos e as 3as e 4as interfalangeanas, de forma aditiva. Relata dificuldade para realizar as atividades no período matinal com rigidez de 2 horas. Nega xeroftalmia, xerostomia, úlceras orais, fotossensibilidade, manchas na pele e fenômeno de Raynaud. Ao exame observa-se artrite de articulações envolvidas, desvio ulnar bilateral. Qual dos achados abaixo não é esperado para o caso?

A. Radiografia com erosão subcondrais
B. Fator reumatoide positivo
C. Velocidade de hemossedimentação elevada
D. Acometimento da coluna lombar

QUESTÃO 224. ASS, 28 anos comparece ao consultório queixando-se de emagrecimento dores do corpo com piora progressiva nos últimos 2 meses. Nega sintomas neurológicos, respiratórios, urinários e gastrointestinais. Relata muita astenia, dor em joelhos, tornozelos e com edema nos tornozelos. Ao exame está em bom estado geral, com mucosa descoradas moderadamente e com úlceras orais. Traz radiografia de tornozelo normal, hemoglobina -9g/dl, hematocrito = 26%; 90.000 plaquetas, 2000 leucocitos; urina 1 (EAS) com proteínas 2+. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica e quais os exames para auxiliar na sua confirmação.

A. Artrite reumatoide, anti CCP e velocidade de hemossedimentação
B. Lúpus eritematoso sistêmico, anticorpo antinuclear e anti DNA
C. Síndrome de Sjogren, fator reumatóide e anti Ro
D. Hepatites virais, sorologias virais e pesquisa de crioglobulinemia

QUESTÃO 225. O equilíbrio entre agentes anabólicos e agentes catabólicos determina a homeostase, e um desequilíbrio entre estes agentes, com predomínio dos catabólicos, ocasiona a degradação cartilaginosa observada na osteoartrite. Com relação à resposta catabólica dos condrócitos, a seguinte alteração é descrita:

A. diminuição da síntese de proteoglicanos.
B. diminuição da síntese de metaloproteinases.
C. aumento da síntese de inibidor tecidual do plasminogênio.
D. aumento da síntese de colágenos tipo II e IX.

QUESTÃO 226. "A doença do manguito rotador pode se desenvolver apenas como tendinite ou evoluir para a ruptura. "Nesse contexto, torna-se indispensável realização de testes específicos que identifiquem a tendinite e de testes que avaliem a integridade dos tendões. Dentre os testes utilizados para avaliação da integridade dos tendões, incluem-se:

A. Neer e Hawkins.
B. Palm-up test e Yergason.
C. Jobe e Patte
D. Gerber e Yocum.

QUESTÃO 227. 6. VSB, sexo feminino, 32 anos, é encaminhada para ambulatório de reumatologia em uso antiinflamatórios, com dor intensa na mão direita. Relata que não gosta de atividades físicas e que fica muitas horas seguidas no uso de computador, tablet ou celular. O possível diagnóstico è a Tenossinovite Estenosante De Quervain, que abrange o primeiro compartimento dorsal (tendões do abdutor longo e do extensor curto do polegar). Assinale o teste adequado para a sua confirmação?

A. Thompson
B. Tinel
C. Finkelstein
D. Cosen

QUESTÃO 228. Os auto-anticorpos devem ser solicitados nos cenários em que se suspeita de uma doença inflamatória imunomediada. A

dosagem positiva dos anticorpos anti-DNA dupla hélice e anti- Sm tem maior especificidade para o diagnóstico de

A. lúpus eritematoso sistémico
B. doença de Behçet.
C. doença mista do colágeno.
D. dermatopolimiosite.

QUESTÃO 229. Durante a expansão cutânea realizada para reconstrução de uma sequela de queimadura, o que podemos observar na área tecidual operada?

A. Atrofia da derme
B. Hipertrofia da epiderme
C. Formação de cápsula fibrosa em volta do expansor
D. Todas estão corretas

QUESTÃO 230. Você está descrevendo os riscos e benefícios da expansão tecidual para os pais de uma criança que apresenta uma área de alopecia no couro cabeludo. Qual das seguintes alternativas constitui a principal vantagem da expansão tecidual para esta criança?

A. O menor número de procedimentos com anestesia geral
B. O menor número de consultas clínicas hospitalares
C. O defeito pode fechar diretamente utilizando um retalho de pele com cabelo
D. A reconstrução pode ser terminada rapidamente

QUESTÃO 231. Paciente 38 anos, masculino, tem acidente de carro e chega ao Pronto-socorro queixando-se de muita dor na coluna, e logo após exame clínico é feito a hipótese de fratura de coluna toracolombar, que é confirmado pelo R-x coluna torácica e lombar. É considerado critério de instabilidade na fratura explosão da coluna toracolombar

A. cifose maior do que 10 graus
B. acunhamento maior do que 20 graus
C. déficit neurológico
D. destruição da coluna média

QUESTÃO 232. Os primeiros cuidados no trauma de extremidades devem ser feitos pelo protocolo PRICE, onde è incorreto afirmar:

A. P significa proteção
B. R significa repouso:
C. I significa imobilização:
D. C significa compressão leve:

QUESTÃO 233. Paciente após acidente motociclístico, apresenta fratura exposta de membro superior Esquerdo, com sangramento abundante. Para se estancar uma hemorragia devemos realizar a seguinte sequência:

A. Compressão direta do ferimento, elevação do membro, compressão da artéria proximal, pinçamento dos cotos vasculares e torniquete;
B. Elevação do membro, compressão da artéria proximal, compressão direta do ferimento, torniquete e pinçamento dos cotos vasculares;
C. Compressão direta do ferimento, compressão da artéria proximal, torniquete e pinçamento dos cotos vasculares, elevação do membro;
D. Compressão direta do ferimento, elevação do membro, compressão da artéria proximal, torniquete e pinçamento dos cotos vasculares;

QUESTÃO 234. Uma paciente de 24 anos, brasileira, foi submetida à plástica mamária (mastopexia com prótese) há 90 dias e queixa-se da qualidade de sua cicatriz. A mesma refere que apresenta ardência local eventualmente. Ao exame físico da cicatriz: encontra-se com coloração avermelhada, de consistência pouco mais endurecida e levemente elevada, porém não ultrapassando os limites da própria cicatriz. Essa paciente apresenta:

A. uma cicatriz queloideana.
B. um tumor desmoide.
C. uma cicatriz hipertrófica.
D. um carcinoma basocelular.

GABARITO TÉCNICO COMENTADO

QUESTÕES (ALAN) M1(1) | 234 questões

Este gabarito foi elaborado sem utilizar os destaques de respostas presentes no documento recebido. A prova original foi mantida com sua numeração, enunciados, alternativas e imagens necessárias, removendo marcações e conteúdo editorial. Questões repetidas continuam presentes.

CRITÉRIOS: “X” = nenhuma alternativa demonstradamente correta; “/” = múltiplas respostas defensáveis; “?” = resposta provável, mas dependente de contexto, imagem ou enunciado truncado. Não se atribuiu certeza a formulações incompletas. Diretrizes posteriores à redação das provas são identificadas como atualização clínica, não como transcrição do gabarito de origem.

GABARITO RESUMIDO

001: D	002: C	003: B	004: A	005: D
006: D	007: D	008: A	009: B	010: C/D
011: B	012: C	013: ANULÁVEL	014: A	015: C
016: D	017: C?	018: C	019: C	020: B
021: C	022: A	023: B	024: D	025: D
026: ANULÁVEL	027: D	028: D	029: ANULÁVEL	030: A

031: C	032: C	033: A	034: C	035: A
036: A	037: B	038: C	039: D	040: B
041: B	042: C	043: C	044: D	045: D
046: A	047: C	048: C	049: B	050: B
051: C	052: A	053: C	054: B	055: A/D
056: C	057: C	058: D	059: D	060: A

061: B	062: C	063: C	064: D	065: C
066: C	067: ANULÁVEL	068: B	069: D	070: A
071: A?	072: B	073: C	074: A	075: B
076: B	077: A/B/C	078: A	079: D	080: A?
081: B	082: D	083: A	084: D	085: A
086: A?	087: A	088: B	089: B	090: D

091: A	092: C/D	093: B	094: B	095: A
096: A	097: C	098: A	099: D	100: C
101: C	102: C	103: E	104: C	105: A?
106: A	107: D	108: ANULÁVEL	109: B	110: D
111: A	112: B	113: C	114: A	115: B
116: C	117: D	118: B	119: A	120: B

121: D	122: B	123: B	124: C	125: A
126: D	127: B	128: A	129: B	130: A?
131: D	132: B	133: A	134: D	135: A
136: B?	137: C	138: C	139: C	140: A
141: D	142: C?	143: B	144: D	145: A
146: B	147: D	148: B	149: D	150: C

151: C	152: A	153: D	154: ANULÁVEL	155: B
156: B	157: A	158: ANULÁVEL	159: C	160: A
161: D	162: D	163: D	164: B	165: B/C
166: B	167: A	168: A	169: D	170: C
171: B?	172: A	173: B	174: A	175: D
176: B	177: C	178: C	179: B	180: A

181: D	182: C	183: B	184: B	185: A
186: C	187: A	188: D	189: C	190: C
191: C	192: D	193: C	194: B	195: B
196: D	197: D	198: C?	199: D	200: D
201: B	202: C?	203: B	204: C	205: C
206: A	207: C	208: D	209: D	210: C

211: B	212: A?	213: C	214: D	215: A
216: C?	217: B	218: D	219: A	220: C
221: A	222: C	223: D	224: B	225: A
226: C	227: C	228: A	229: D	230: C
231: C	232: C	233: ANULÁVEL	234: C	

COMENTÁRIOS INDIVIDUAIS

Cada alternativa foi comentada separadamente. Uma resposta assinalada com ressalva não representa diagnóstico definitivo ou prescrição individualizada.

QUESTÃO 1 — RESPOSTA: D

Fundamento: Quadro típico de fibromialgia: pregabalina pode aliviar dor, embora exercício e intervenções não farmacológicas sejam pilares do tratamento. [Fontes: R11]

A — Incorreta: Corticosteroide não trata sensibilização dolorosa da fibromialgia.

B — Incorreta: Antimalárico serve a doenças inflamatórias como LES e AR.

C — Incorreta: Imunossupressor de AR não é indicado sem sinovite.

D — Correta: Pode reduzir dor fibromiálgica, com exercício associado.

QUESTÃO 2 — RESPOSTA: C

Fundamento: Todos os T-scores estão entre -1,0 e -2,5: baixa massa óssea/osteopenia, sem critério densitométrico de osteoporose. [Fontes: R14]

A — Incorreta: Não há T-score menor ou igual a -2,5.

B — Incorreta: Nenhuma região preenche critério de osteoporose.

C — Correta: Todos os resultados indicam osteopenia.

D — Incorreta: O colo também está na faixa osteopênica.

QUESTÃO 3 — RESPOSTA: B

Fundamento: Etoricoxibe tem preferência relativa pela COX-2, menor toxicidade ulcerosa que AINE não seletivo; ainda há risco GI, renal e cardiovascular. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Menor seletividade e risco gastrointestinal.

B — Correta: COX-2 seletivo, preferível entre os listados com ressalvas.

C — Incorreta: Ibuprofeno inibe COX-1 e agrava risco ulceroso.

D — Incorreta: Meloxicam é preferencial COX-2, mas menos seletivo que etoricoxibe.

QUESTÃO 4 — RESPOSTA: A

Fundamento: Dexametasona atravessa a placenta em maior proporção. Seu uso no bloqueio fetal por anti-Ro é controverso e exige avaliação especializada. [Fontes: R15]

A — Correta: Cruza placenta e tem atividade glicocorticoide fetal.

B — Incorreta: Prednisolona é amplamente inativada pela placenta.

C — Incorreta: Prednisona tem transferência fetal menor.

D — Incorreta: Metilprednisolona tem transferência limitada pela placenta.

QUESTÃO 5 — RESPOSTA: D

Fundamento: Apresentação pélvica é fator de risco clássico da displasia do desenvolvimento do quadril. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Ocorre sobretudo no sexo feminino.

B — Incorreta: Cefálica não é apresentação de risco típico.

C — Incorreta: Transversa/córmica não é associação clássica.

D — Correta: Apresentação pélvica aumenta risco de DDQ.

QUESTÃO 6 — RESPOSTA: D

Fundamento: Queimadura profunda, seca/nacarada, sem bolhas e insensível caracteriza espessura total (terceiro grau), ressalvado exame clínico completo. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Primeiro grau é doloroso, eritematoso e superficial.

B — Incorreta: Segundo superficial é úmido, bolhoso e doloroso.

C — Incorreta: Segundo profundo pode ter dor reduzida, mas quadro sugere espessura total.

D — Correta: Ausência de dor e aspecto nacarado indicam terceiro grau.

QUESTÃO 7 — RESPOSTA: D

Fundamento: Metas de reabilitação devem acompanhar preferências, participação social, funcionalidade e objetivos pessoais, mesmo após alta prévia. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Houve ganhos importantes de autonomia.

B — Incorreta: Autocuidado não esgota metas de participação social.

C — Incorreta: Sequelas não impedem por definição toda atividade bimanual.

D — Correta: Objetivos devem se adaptar às novas metas da paciente.

QUESTÃO 8 — RESPOSTA: A

Fundamento: Pressão prolongada com prejuízo da perfusão tissular é o mecanismo central da lesão por pressão; cisalhamento também contribui. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Pressão/cisalhamento são fatores mecânicos causais.

B — Incorreta: Anemia é facilitador, não mecanismo principal.

C — Incorreta: Desnutrição pode aumentar risco, não causa mecânica principal.

D — Incorreta: Perda sensitiva contribui, mas não é necessária.

QUESTÃO 9 — RESPOSTA: B

Fundamento: O nervo radial é particularmente vulnerável em fraturas da diáfise do úmero, por seu trajeto no sulco radial. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Nervo ulnar lesiona-se tipicamente em cotovelo.

B — Correta: Nervo radial percorre sulco do úmero.

C — Incorreta: Mediano pode lesionar, mas não é o mais comum.

D — Incorreta: Musculocutâneo não é o mais frequentemente lesado.

QUESTÃO 10 — MÚLTIPLAS ALTERNATIVAS DEFENSÁVEIS: C/D

Fundamento: A osteomielite aguda hematogênica infantil frequentemente acomete metáfises de ossos longos; a crônica costuma ter sequestro ósseo. Há mais de uma afirmativa defensável. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Termos temporais são possíveis mas classificação não esclarece a pergunta.

B — Incorreta: Staphylococcus aureus é causa mais comum, não estreptococo B.

C — Defensável: Acometimento metafisário infantil por via hematogênica é típico.

D — Defensável: Sequestro ósseo é típico da fase crônica; EV não é sempre suficiente.

QUESTÃO 11 — RESPOSTA: B

Fundamento: Lombalgia mecânica sem sinais de alarme deve priorizar manutenção de atividades, exercícios e reabilitação, sem ressonância rotineira inicial. [Fontes: R13]

A — Incorreta: RM não é rotina na ausência de sinais de alarme.

B — Correta: Educação e reabilitação são primeira linha.

C — Incorreta: Seis semanas contínuas de AINE/miorrelaxante não são indicadas.

D — Incorreta: Lombalgia sem radiculopatia não implica hérnia.

QUESTÃO 12 — RESPOSTA: C

Fundamento: Estabilidade absoluta objetiva consolidação primária, redução anatômica e compressão interfragmentar, especialmente útil em fraturas articulares. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Consolidação secundária caracteriza estabilidade relativa.

B — Incorreta: Consolidação primária não produz calo exuberante e exposição não é requisito fixo.

C — Correta: Combinação clássica de redução anatômica/primária, sobretudo em fratura articular.

D — Incorreta: Consolidação secundária e calo indicam estabilidade relativa.

QUESTÃO 13 — SEM ALTERNATIVA INEQUIVOCAMENTE CORRETA

Fundamento: A ESAS avalia sintomas tipicamente de 0 (ausente) a 10 (pior intensidade); nenhuma alternativa reproduz corretamente esse intervalo. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Em análise: ESAS não usa apenas 0 a 5.

B — Em análise: ESAS tem 0 a 10, incluindo ausência zero.

C — Em análise: É uma escala numérica, não apenas qualificativa.

D — Em análise: Faces não representam o modelo usual da ESAS.

QUESTÃO 14 — RESPOSTA: A

Fundamento: Alucinações visuais detalhadas, parkinsonismo e declínio cognitivo contemporâneos são característicos da demência por corpos de Lewy. [Fontes: R7]

A — Correta: Alucinações visuais e parkinsonismo surgiram próximos ao déficit cognitivo.

B — Incorreta: Na demência do Parkinson, manifestações motoras antecedem demência por mais de um ano.

C — Incorreta: FTD não tem alucinações visuais/parkinsonismo como apresentação típica.

D — Incorreta: Vascular costuma ser escalonada/focal conforme lesões vasculares.

QUESTÃO 15 — RESPOSTA: C

Fundamento: Dor oncológica forte (8/10) sem controle com analgésico simples requer opioide forte, em geral morfina titulada; tratar dispneia concomitante. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Tramadol pode ser insuficiente na dor 8/10.

B — Incorreta: AINE isolado não controla dor oncológica intensa.

C — Correta: Morfina é opioide forte indicado com titulação.

D — Incorreta: Dipirona isolada é insuficiente para dor forte.

QUESTÃO 16 — RESPOSTA: D

Fundamento: Alteração aguda/flutuante de consciência e atenção após infecção/internação caracteriza delirium, não demência insidiosa. [Fontes: R7]

A — Incorreta: AVC não costuma produzir atenção flutuante global sem déficits focais.

B — Incorreta: Demência não surge abruptamente no terceiro dia.

C — Incorreta: Coma séptico não explica flutuação entre vigília e sonolência.

D — Correta: Delirium é agudo, flutuante e com desatenção.

QUESTÃO 17 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: C

Fundamento: A comparação é visual e deve considerar bengala na mão contralateral à perna acometida, avanço conjunto com o lado afetado e altura apropriada; a fotografia não identifica qual perna tem limitação. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Imagem a não demonstra inequivocamente uso contralateral correto.

B — Incorreta: Imagem b não permite concluir técnica adequada.

C — Defensável: Alternativa pretendida parece C pelas imagens, mas lado do déficit é desconhecido.

D — Incorreta: Imagem d não fundamenta melhor técnica do que critérios clínicos.

QUESTÃO 18 — RESPOSTA: C

Fundamento: Baixa visão, neuropatia, perda ponderal/sarcopenia, polifarmácia e benzodiazepínico elevam o risco de quedas. [Fontes: R6, R12]

A — Incorreta: Osteoporose aumenta gravidade das fraturas, não explica todo risco de queda.

B — Incorreta: Hipertensão/metformina não representam conjunto de riscos mais preditivo.

C — Correta: Inclui neuropatia, baixa visão, sarcopenia e sedativo.

D — Incorreta: Local da queda é circunstância, não reúne principais riscos.

QUESTÃO 19 — RESPOSTA: C

Fundamento: Após história sugestiva de transtorno neurocognitivo maior, a avaliação inicial inclui testes cognitivos e funcionais e exames para causas reversíveis. [Fontes: R7]

A — Incorreta: EEG/RM podem ser úteis em casos selecionados, não são obrigatórios inicialmente.

B — Incorreta: PET e biomarcadores do líquor não são exames de primeira linha.

C — Correta: Avaliação cognitivo-funcional e laboratorial é passo inicial.

D — Incorreta: PET amiloide não precede avaliação clínica básica.

QUESTÃO 20 — RESPOSTA: B

Fundamento: Há polifarmácia por vários princípios ativos e uso de amitriptilina/clonazepam, associados a efeitos anticolinérgicos, sedação e quedas. [Fontes: R6]

A — Incorreta: Receitas válidas não eliminam polifarmácia.

B — Correta: Combina múltiplos fármacos, incluindo medicamentos inadequados.

C — Incorreta: Doenças coexistentes não justificam automaticamente risco.

D — Incorreta: Amitriptilina e clonazepam demandam revisão.

QUESTÃO 21 — RESPOSTA: C

Fundamento: Fried descreveu cinco critérios: perda involuntária de peso, exaustão, baixa atividade, lentidão e fraqueza; três ou mais indicam fragilidade. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Não exigem cinco critérios e déficit cognitivo não integra fenótipo original.

B — Incorreta: Não são apenas três critérios.

C — Correta: Reproduz cinco componentes e limiar de três.

D — Incorreta: O fenótipo não se restringe a três itens.

QUESTÃO 22 — RESPOSTA: A

Fundamento: Dinamometria de preensão tem pontos de corte EWGSOP2 de 27 kg nos homens e 16 kg nas mulheres. [Fontes: R5]

A — Correta: Dinamometria com cortes de 27/16 kg corresponde ao EWGSOP2.

B — Incorreta: Corte do teste de cadeira é >15 segundos sem divisão 15/20 por sexo.

C — Incorreta: Dinamometria lombar não é método principal de rastreio.

D — Incorreta: TGUG avalia desempenho, não força isolada.

QUESTÃO 23 — RESPOSTA: B

Fundamento: Massa profunda de 10 cm deve ser investigada em serviço especializado e biopsiada com planejamento; aparência isolada não define histologia. [Fontes: R10]

A — Incorreta: Lipossarcoma não pode ser presumido apenas pelo tamanho.

B — Correta: Lesão profunda volumosa exige biópsia planejada.

C — Incorreta: Observação simples é inadequada com sinais de alarme.

D — Incorreta: Imuno-histoquímica pode ser requerida após amostragem, não antes.

QUESTÃO 24 — RESPOSTA: D

Fundamento: Tumores de partes moles retroperitoneais tendem a diagnóstico tardio e pior prognóstico pela dificuldade de ressecção completa. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Metástase hematogênica é usual, portanto afirmativa correta.

B — Incorreta: RM detalha extensão, não determina histologia isoladamente.

C — Incorreta: Sarcoma de partes moles é frequente em adultos/idosos.

D — Correta: Retroperitônio associa-se a pior, não melhor prognóstico.

QUESTÃO 25 — RESPOSTA: D

Fundamento: Neoplasia epifisária de células gigantes e hemorragias é menos compatível com sarcoma de Ewing, tipicamente diafisário/metadiafisário de pequenas células redondas. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Tumor de células gigantes combina com topografia e histologia.

B — Incorreta: Cisto aneurismático apresenta lacunas hemorrágicas.

C — Incorreta: Tumor marrom entra no diferencial de células gigantes.

D — Correta: Ewing costuma ser diafisário e de pequenas células.

QUESTÃO 26 — SEM ALTERNATIVA INEQUIVOCAMENTE CORRETA

Fundamento: Exantema febril após alopurinol sugere reação de hipersensibilidade possivelmente grave; sem bolhas ou erosões mucosas não se pode afirmar Stevens-Johnson. [Fontes: R2]

A — Em análise: SJS é hipótese grave, mas requer achados mucocutâneos não descritos.

B — Em análise: Neutropenia não explica exantema febril.

C — Em análise: Alopurinol reduz urato, não causa hiperuricemia terapêutica.

D — Em análise: Trombocitopenia não é a manifestação relatada.

QUESTÃO 27 — RESPOSTA: D

Fundamento: Etanercepte e adalimumabe neutralizam TNF-alfa, mediador pró-inflamatório importante na artrite reumatoide. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: IL-2 é sinalizador linfocitário, não alvo dos dois fármacos.

B — Incorreta: IL-6 tem bloqueadores diferentes, como tocilizumabe.

C — Incorreta: IL-1 é bloqueada por anakinra/canakinumabe.

D — Correta: Etanercepte e adalimumabe antagonizam TNF-alfa.

QUESTÃO 28 — RESPOSTA: D

Fundamento: Metotrexato é DMARD convencional âncora recomendado como início na AR de atividade moderada/alta, em associação a folato. [Fontes: R1]

A — Incorreta: Infliximabe não costuma ser primeira escolha isolada no início.

B — Incorreta: Corticoide não substitui terapia modificadora da doença.

C — Incorreta: Leflunomida é alternativa quando MTX não adequado.

D — Correta: Metotrexato é DMARD âncora inicial.

QUESTÃO 29 — SEM ALTERNATIVA INEQUIVOCAMENTE CORRETA

Fundamento: Macrocitose, neutrófilos hipersegmentados e pancitopenia sugerem anemia megaloblástica; B12 e folato devem ser dosados, sem predizer etiologia unicamente pelo hemograma. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Em análise: Deficiência de B12 é possível mas não distinguível de folato só pelo hemograma.

B — Em análise: Ferritina alta não explica megaloblastose e neutrófilos hipersegmentados.

C — Em análise: Folato é possível em etilismo, porém não confirmado.

D — Em análise: Ferritina baixa não corresponde ao padrão megaloblástico.

QUESTÃO 30 — RESPOSTA: A

Fundamento: Os critérios imunológicos SLICC 2012 incluem ANA/FAN, anti-dsDNA, anti-Sm, antifosfolípides, hipocomplementemia e Coombs positivo sem anemia hemolítica. [Fontes: R15]

A — Correta: Lista os critérios imunológicos do SLICC corretamente.

B — Incorreta: Exames inespecíficos não compõem conjunto de critérios imunológicos SLICC.

C — Incorreta: Achados hematológicos e renais são critérios clínicos, não conjunto imunológico.

D — Incorreta: Exames úteis à avaliação geral, mas não reproduzem especificamente o conjunto pedido.

QUESTÃO 31 — RESPOSTA: C

Fundamento: A correspondência é RNP=doença mista; anti-dsDNA=nefrite lúpica; anti-histonas=lúpus medicamentoso; c-ANCA/PR3=GPA; SSA= Sjögren. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Anti-histonas não correspondem à doença mista inicialmente listada.

B — Incorreta: Sequência não corresponde ao pareamento dos cinco anticorpos.

C — Correta: Ordem 3,4,1,2,5 é a associação correta.

D — Incorreta: Inverte várias relações autoanticorpo-doença.

QUESTÃO 32 — RESPOSTA: C

Fundamento: Erosões marginais, osteopenia justa-articular e estreitamento articular simétrico sugerem artrite reumatoide. [Fontes: R1]

A — Incorreta: Osteoartrite apresenta osteófitos e esclerose.

B — Incorreta: Artrite infecciosa é geralmente rapidamente destrutiva/monoarticular.

C — Correta: AR produz erosões marginais simétricas com osteopenia.

D — Incorreta: Gota causa erosões em saca-bocado sem osteopenia habitual.

QUESTÃO 33 — RESPOSTA: A

Fundamento: Osteófitos, esclerose subcondral, cistos e perda localizada do espaço articular sugerem osteoartrite. [Fontes: R3]

A — Correta: Padrão é típico de osteoartrite.

B — Incorreta: Artrite séptica não costuma gerar osteófitos crônicos.

C — Incorreta: AR costuma erosão marginal com osteopenia.

D — Incorreta: Gota erosiva apresenta bordas salientes/tofos.

QUESTÃO 34 — RESPOSTA: C

Fundamento: Erosões bem delimitadas em saca-bocado com bordas salientes, osteopenia ausente e tofos sugerem gota crônica. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Artrose caracteriza osteófitos e esclerose.

B — Incorreta: Pioartrite tem destruição aguda, não este padrão tofaceo.

C — Correta: Gota crônica produz erosões de bordas salientes.

D — Incorreta: AR associa osteopenia e erosões marginais simétricas.

QUESTÃO 35 — RESPOSTA: A

Fundamento: Barras de apoio ajudam transferências seguras; tapetes, bancos, chinelos e pouca luz aumentam risco de quedas. [Fontes: R12]

A — Correta: Barras de apoio reduzem risco de queda.

B — Incorreta: Chinelos soltos e sandálias abertas aumentam escorregões.

C — Incorreta: Bancos para alcançar altura são fator de risco.

D — Incorreta: Boa iluminação é protetora, não prejudicial.

QUESTÃO 36 — RESPOSTA: A

Fundamento: Instalação em 72 horas e alteração flutuante da atenção/consciência sugerem delirium, possivelmente precipitado por infecção respiratória/hipóxia. [Fontes: R7]

A — Correta: Delirium explica início recente e flutuações.

B — Incorreta: Depressão não explica alteração aguda de consciência.

C — Incorreta: Demência costuma ter progressão lenta.

D — Incorreta: Sem sinais focais, AVC é menos provável.

QUESTÃO 37 — RESPOSTA: B

Fundamento: A medicação adicional trata efeito adverso de outra, criando prescrição em cascata, seguida de toxicidade anticolinérgica e sedativa. [Fontes: R6]

A — Incorreta: Polifarmácia existe, mas o mecanismo específico é cascata.

B — Correta: Prescrição em cascata por tratar efeitos adversos sucessivos.

C — Incorreta: Não há dose excessiva documentada.

D — Incorreta: Interações podem ocorrer, mas fenômeno central é prescrição em cascata.

QUESTÃO 38 — RESPOSTA: C

Fundamento: Cuidados paliativos e discussão de objetivos de cuidado devem ser oferecidos, sem medidas invasivas automáticas; respeitar desejos do paciente. [Fontes: R7]

A — Incorreta: Intubação é decisão proporcional, não imposição automática.

B — Incorreta: UTI e antibiótico sem discussão são conduta não individualizada.

C — Correta: Alinhar objetivos e ofertar conforto e suporte paliativo.

D — Incorreta: Família auxilia decisão sem substituir vontades e interesses do paciente.

QUESTÃO 39 — RESPOSTA: D

Fundamento: Na demência avançada, gastrostomia não previne de maneira demonstrada pneumonia aspirativa nem melhora rotineiramente sobrevida ou lesões por pressão. [Fontes: R7]

A — Incorreta: Gastrostomia não é universal em demência avançada.

B — Incorreta: Não previne aspiração de saliva/secreções.

C — Incorreta: Não reduz comprovadamente lesões por pressão.

D — Correta: Não recomendar rotineiramente; avaliar exceção reversível.

QUESTÃO 40 — RESPOSTA: B

Fundamento: Apresentação depressiva e escala sugestiva requerem investigação de depressão; baixa escolaridade afeta interpretação isolada do MEEM. [Fontes: R7]

A — Incorreta: Quadro depressivo não equivale a demência.

B — Correta: Há sinais sugestivos de depressão e necessidade de confirmação.

C — Incorreta: MEEM 22 isolado não confirma Alzheimer, especialmente analfabetismo.

D — Incorreta: Anedonia/retraimento não devem ser normalizados como envelhecimento.

QUESTÃO 41 — RESPOSTA: B

Fundamento: Benzodiazepínicos costumam ser potencialmente inapropriados em idosos com demência por sedação, quedas e piora cognitiva. [Fontes: R6]

A — Incorreta: Betabloqueadores têm indicação na insuficiência cardíaca selecionada.

B — Correta: Benzodiazepínico aumenta risco em demência.

C — Incorreta: Antipsicóticos só se justificam em delirium grave e circunstâncias restritas.

D — Incorreta: Tiazídicos podem ser apropriados na hipertensão com monitorização.

QUESTÃO 42 — RESPOSTA: C

Fundamento: Polifarmácia se associa independentemente a fragilidade; fragilidade não equivale simplesmente à contagem de doenças ou à incapacidade. [Fontes: R12]

A — Incorreta: Fragilidade não é definida pela contagem de doenças.

B — Incorreta: Muitos frágeis ainda executam atividades independentes.

C — Correta: Associação entre múltiplos fármacos e fragilidade está documentada.

D — Incorreta: Déficit cognitivo não integra os cinco critérios de Fried.

QUESTÃO 43 — RESPOSTA: C

Fundamento: Teste de levantar da cadeira 5 vezes em 38 s (>15s) indica redução de força e provável sarcopenia. [Fontes: R5]

A — Incorreta: Baixa força sem massa muscular medida não confirma sarcopenia.

B — Incorreta: Não foram demonstrados três critérios de Fried.

C — Correta: Levantar 5 vezes em 38s indica provável sarcopenia.

D — Incorreta: Os dados bastam para classificação provável.

QUESTÃO 44 — RESPOSTA: D

Fundamento: Após baixa força muscular, confirmar sarcopenia exige avaliação quantitativa da massa muscular (DXA ou BIA). [Fontes: R5]

A — Incorreta: Preensão plantar não é teste padrão para confirmação.

B — Incorreta: Velocidade classifica gravidade depois de confirmar massa muscular.

C — Incorreta: Vitamina não confirma o diagnóstico estrutural.

D — Correta: DXA ou BIA quantificam músculo.

QUESTÃO 45 — RESPOSTA: D

Fundamento: Segunda intenção ocorre com ferida aberta, preenchida por granulação, contração e epitelização, sem aproximação cirúrgica das bordas. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Aproximação de bordas indica primeira intenção.

B — Incorreta: Remodelação é fase comum, não define segunda intenção.

C — Incorreta: Fechamento após infecção debelada descreve terceira intenção.

D — Correta: Cicatriza espontaneamente por granulação e epitelização.

QUESTÃO 46 — RESPOSTA: A

Fundamento: Barlow testa instabilidade/dislocabilidade: quadril fletido, aduzido e pressão posterior; Ortolani testa redução de quadril luxado. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Barlow é provocativo, mas requer pressão posterior, não só flexão/adução.

B — Incorreta: Galeazzi pode não detectar doença bilateral simétrica.

C — Incorreta: Crianças mais velhas podem necessitar cirurgia.

D — Incorreta: Calção gessado não é universal em DDQ teratológica.

QUESTÃO 47 — RESPOSTA: C

Fundamento: Queimadura extensa: priorizar via aérea/respiração, acesso venoso, reposição com cristaloide balanceado, analgesia EV e controle da diurese. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Não se inicia com curativo e analgesia intramuscular.

B — Incorreta: Não se prioriza analgésico antes de via aérea nem soro glicosado.

C — Correta: ABCDE, Ringer lactato, analgesia EV e diurese são adequados.

D — Incorreta: Antibiótico profilático sistêmico indiscriminado e analgesia IM não são rotineiros.

QUESTÃO 48 — RESPOSTA: C

Fundamento: Osteossarcoma costuma ser tumor maligno de metáfise de ossos longos, com lesão agressiva mal delimitada. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Osteossarcoma é maligno.

B — Incorreta: Metáfise de ossos longos é sítio clássico.

C — Correta: Topografia metafisária e limites agressivos são típicos.

D — Incorreta: Bordas bem definidas seriam menos sugestivas de agressividade.

QUESTÃO 49 — RESPOSTA: B

Fundamento: Curva torácica de 91 graus é grave e pode comprometer mecânica torácica e produzir restrição ventilatória. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Desnutrição por volume abdominal não é desfecho principal.

B — Correta: Grande curva torácica compromete dinâmica ventilatória.

C — Incorreta: Cobb 91º é grave, não curva pequena.

D — Incorreta: Magnitude da curva influencia prognóstico.

QUESTÃO 50 — RESPOSTA: B

Fundamento: Nervo sural é doador frequente para enxerto autólogo, devido ao trajeto superficial e déficit sensitivo relativamente aceitável. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Fibular é nervo motor e não doador mais frequente.

B — Correta: Nervo sural é clássico para enxerto autólogo.

C — Incorreta: Safeno pode ser usado em circunstâncias selecionadas.

D — Incorreta: Auricular posterior não é o padrão para enxerto extenso.

QUESTÃO 51 — RESPOSTA: C

Fundamento: Sarcoma de Ewing pode ser diafisário infantil/adolescente e apresentar reação periosteal em camadas de cebola. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Osteossarcoma costuma metafisário com espículas/Codman.

B — Incorreta: Condrossarcoma ocorre mais em adultos.

C — Correta: Ewing associa diáfise e reação em casca de cebola.

D — Incorreta: Osteoblastoma não costuma esse padrão agressivo.

QUESTÃO 52 — RESPOSTA: A

Fundamento: Antecurvatum é angulação com ápice anterior; varo/valgo indicam direção no plano coronal. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Antecurvado significa ápice anterior.

B — Incorreta: Medial corresponde a varo, não antecurvatum.

C — Incorreta: Lateral corresponde a valgo/varo conforme convenção.

D — Incorreta: Posterior seria recurvatum, não antecurvatum.

QUESTÃO 53 — RESPOSTA: C

Fundamento: Trauma facial com inconsciência exige proteção cervical, via aérea e avaliação ABCDE, com suspeita de lesão cervical associada. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: A prioridade inicial é via aérea, controle de sangramento e proteção cervical.

B — Incorreta: Rebaixamento exige, não dispensa, imobilização cervical.

C — Correta: Trauma facial/TCE/intoxicação justificam suspeita cervical.

D — Incorreta: Hoffmann e Babinski indicam via longa, não localizam lombar.

QUESTÃO 54 — RESPOSTA: B

Fundamento: Lombalgia mecânica sem sinais de alarme merece orientação, exercício e reabilitação antes de imagem avançada rotineira. [Fontes: R13]

A — Incorreta: RM não é automática com lombalgia sem alarme.

B — Correta: Reabilitação/educação são primeiras medidas.

C — Incorreta: AINES por seis semanas têm riscos e não são primeira linha obrigatória.

D — Incorreta: Sem radiculopatia é precipitado assumir hérnia.

QUESTÃO 55 — MÚLTIPLAS ALTERNATIVAS DEFENSÁVEIS: A/D

Fundamento: Capsulite adesiva, calcificação tendínea, rotura do manguito e artrose acromioclavicular podem simular síndrome do impacto; existem alternativas plausíveis múltiplas. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Defensável: Capsulite e tendinite calcária podem simular impacto.

B — Incorreta: Doença cervical pode causar dor referida; subluxação é contexto distinto.

C — Incorreta: Radiculopatia cervical e tumores entram no diferencial em casos selecionados.

D — Defensável: Rotura do manguito e artrose AC também são diferenciais verdadeiros.

QUESTÃO 56 — RESPOSTA: C

Fundamento: Duas ou mais quedas em 12 meses caracterizam quedas recorrentes e justificam investigação multifatorial de risco. [Fontes: R12]

A — Incorreta: Barthel 90 mede dependência, não recorrência de quedas.

B — Incorreta: SARC-F 6 sugere sarcopenia, não define caidor.

C — Correta: Duas quedas em 12 meses caracterizam recorrência.

D — Incorreta: Uma queda grave também importa, mas não define recorrência por si.

QUESTÃO 57 — RESPOSTA: C

Fundamento: Exercícios resistidos e de sustentação de peso/impacto seguro ajudam preservar massa óssea; adaptar à fragilidade e risco de fratura. [Fontes: R14]

A — Incorreta: Hidroterapia auxilia função mas não gera maior carga óssea.

B — Incorreta: Alongamento não oferece estímulo osteogênico principal.

C — Correta: Exercício resistido/impacto adaptado favorece osso.

D — Incorreta: Exercício localizado sem impacto pode ser insuficiente para prevenção.

QUESTÃO 58 — RESPOSTA: D

Fundamento: Pontos dolorosos podem auxiliar, mas diagnóstico atual de fibromialgia utiliza dor generalizada e gravidade de sintomas, sem exigir tender points. [Fontes: R11]

A — Incorreta: Termografia não é exame diagnóstico validado.

B — Incorreta: Polissonografia não é critério diagnóstico de fibromialgia.

C — Incorreta: Dor generalizada é requisito dos critérios atuais.

D — Correta: Pontos sensíveis podem apoiar quadro, não são obrigatórios.

QUESTÃO 59 — RESPOSTA: D

Fundamento: T-score escrito como +2,9 é normal; se a intenção era -2,9, então seria osteoporose. O sinal não pode ser presumido. [Fontes: R14]

A — Incorreta: Osteopenia exige T-score negativo de -1 a -2,5.

B — Incorreta: Osteoporose exige T-score menor ou igual a -2,5.

C — Incorreta: Categoria por idade usa Z-score quando indicada, e não T +2,9.

D — Correta: T-score positivo de +2,9 é normal.

QUESTÃO 60 — RESPOSTA: A

Fundamento: FABER significa Flexão, ABdução e Rotação Externa do quadril, manobra que pode provocar dor sacroilíaca. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: FABER envolve flexão/abdução/rotação externa.

B — Incorreta: Extensão e rotação interna não formam FABER.

C — Incorreta: Repetida extensão e rotação interna também incorreta.

D — Incorreta: Adução não integra a sigla FABER.

QUESTÃO 61 — RESPOSTA: B

Fundamento: Xerostomia, xeroftalmia e anti-Ro/La positivos sugerem síndrome de Sjögren, FR podendo ser positivo. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Fator reumatoide pode positivar em Sjögren sem AR.

B — Correta: Sicca e autoanticorpos SSA/SSB sustentam Sjögren.

C — Incorreta: Não há psoríase/dactilite sugerindo artrite psoriásica.

D — Incorreta: Osteoartrite não causa síndrome sicca autoimune.

QUESTÃO 62 — RESPOSTA: C

Fundamento: Cristais aciculares com birrefringência fortemente negativa confirmam gota; colchicina ou AINE tratam crise, conforme contraindicações. [Fontes: R2]

A — Incorreta: Condrocalcinose sugere CPPD, não confirma artrite reumatoide.

B — Incorreta: Erosões em saca-bocado indicam gota, não osteoartrite.

C — Correta: Colchicina/AINE aliviam crise gotosa.

D — Incorreta: Alopurinol/bebzobromarona não são analgésicos anti-inflamatórios da crise.

QUESTÃO 63 — RESPOSTA: C

Fundamento: Sinais autoimunes, FAN alto, disúria e sexo desprotegido justificam diferencial de lúpus, infecção gonocócica e artrite viral. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Osteoartrite é improvável em poliartrite inflamatória com sintomas sistêmicos.

B — Incorreta: Artrose é implausível mesmo se artrite viral/AR forem diferenciais.

C — Correta: A tríade de diferenciais contempla risco gonocócico, lúpus e viroses.

D — Incorreta: Psoriásica carece de sinais e ignora LES relevante.

QUESTÃO 64 — RESPOSTA: D

Fundamento: FAN alto, poliartrite, úlcera oral e urina espumosa exigem anti-dsDNA e quantificação de proteinúria; investigar IST conforme quadro. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Uricemia não é a avaliação inicial prioritária.

B — Incorreta: RM das mãos pouco acrescenta sem avaliar proteinúria/LES.

C — Incorreta: Punção e sorologias são válidas em cenário infeccioso, mas não cobrem LES renal.

D — Correta: Anti-dsDNA e proteinúria ajudam investigar LES e nefropatia.

QUESTÃO 65 — RESPOSTA: C

Fundamento: AINES tradicionais inibem COX-1 e COX-2, com seletividade relativa variável, reduzindo prostaglandinas. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: AINES não são anti-hipertensivos/antidepressivos.

B — Incorreta: Naproxeno é clinicamente eficaz.

C — Correta: AINES tradicionais inibem as duas COX em graus variados.

D — Incorreta: Paracetamol é sobretudo analgésico/antipirético, pouco anti-inflamatório.

QUESTÃO 66 — RESPOSTA: C

Fundamento: Análogos sintéticos podem aumentar atividade glicocorticoide e reduzir retenção de sódio; a afirmação de potência igual a 30 para triamcinolona e betametasona é falsa. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: I é correta como tendência farmacológica geral.

B — Incorreta: II descreve vantagens dos análogos sintéticos.

C — Correta: III erra potência da triamcinolona em comparação com hidrocortisona.

D — Incorreta: D inclui III falsa, portanto não se sustenta.

QUESTÃO 67 — SEM ALTERNATIVA INEQUIVOCAMENTE CORRETA

Fundamento: Associação correta seria A-3, B-5, C-1, D-2, E-4, F-7 e G-6; nenhuma sequência fornecida coincide. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Em análise: Associa anti-Ro a outra doença e PR3 incorretamente.

B — Em análise: Várias associações são incompatíveis com imunologia conhecida.

C — Em análise: Não corresponde à sequência A3/B5/C1/D2/E4/F7/G6.

D — Em análise: Troca anti-Ro/antifosfolípides e PR3 entre doenças.

QUESTÃO 68 — RESPOSTA: B

Fundamento: Ferritina é marcador mais útil que ferro sérico isolado; sangue oculto tem limitações e não substitui investigação digestiva da anemia ferropriva no idoso. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Ferro sérico isolado oscila com inflamação e horário.

B — Correta: Ferritina é melhor marcador; investigação GI requer mais que FOBT.

C — Incorreta: Reticulócitos não diferenciam etiologias carenciais sem outros exames.

D — Incorreta: Sangue oculto pode ser utilizado mas não substitui investigação de fonte GI.

QUESTÃO 69 — RESPOSTA: D

Fundamento: Padrão epifisário de células gigantes torna menos provável osteossarcoma osteoblástico; histologia é imprescindível. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Topografia epifisária/células gigantes sugerem TCG.

B — Incorreta: Lacunas hemorrágicas podem sugerir cisto aneurismático.

C — Incorreta: Hiperparatireoidismo produz lesões de células gigantes.

D — Correta: Osteossarcoma osteoblástico costuma ter matriz osteoide maligna específica.

QUESTÃO 70 — RESPOSTA: A

Fundamento: Sarcomas retroperitoneais costumam ser diagnosticados tardiamente; metástases são predominantemente hematogênicas, especialmente pulmões. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Sarcoma retroperitoneal costuma ser descoberto tardiamente.

B — Incorreta: Adultos/idosos são mais acometidos pelo conjunto dos sarcomas.

C — Incorreta: Metástase regional nodal não é a rota mais frequente.

D — Incorreta: Pulmão, não cérebro, é metástase habitual.

QUESTÃO 71 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: A

Fundamento: Nódulos superficiais múltiplos são compatíveis com lipomas, mas medidas de 5 cm exigem investigação se crescerem ou forem atípicos. [Fontes: R10]

A — Defensável: Lipomas múltiplos superficiais são possíveis, mas sem confirmação.

B — Incorreta: Hemangioma costuma características vasculares à imagem.

C — Incorreta: Rabdomiossarcoma é incomum nesta idade e apresentação.

D — Incorreta: Osteoma é tumor ósseo, não nódulo mole superficial.

QUESTÃO 72 — RESPOSTA: B

Fundamento: Osteófitos, redução não uniforme do espaço articular e esclerose são típicos da osteoartrite. [Fontes: R3]

A — Incorreta: Osteopenia periarticular aponta mais a artrite inflamatória.

B — Correta: Osteófitos são típicos de osteoartrite.

C — Incorreta: Erosões marginais típicas de artrite inflamatória.

D — Incorreta: Geno varo associa-se à artrose e alterações de carga.

QUESTÃO 73 — RESPOSTA: C

Fundamento: Sequestro é fragmento ósseo necrótico característico da osteomielite crônica. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Brodie costuma subagudo, não fase aguda clássica.

B — Incorreta: Abscesso de Brodie é com frequência metafisário intraósseo.

C — Correta: Sequestro indica necrose óssea da fase crônica.

D — Incorreta: Reação periosteal não é patognomônica.

QUESTÃO 74 — RESPOSTA: A

Fundamento: Radiografia simples pode permanecer normal nas primeiras 1-2 semanas; rarefação óssea não costuma surgir nas primeiras 24 h. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Mudanças ósseas na radiografia tardam dias a semanas.

B — Incorreta: Fise pode barrar disseminação metafisária em crianças maiores.

C — Incorreta: Focos bacterianos hematogênicos podem originar osteomielite.

D — Incorreta: S. aureus e alguns gram-negativos são agentes conhecidos.

QUESTÃO 75 — RESPOSTA: B

Fundamento: Telefonar, organizar finanças e usar transporte são atividades instrumentais (Lawton); autocuidado básico é outra categoria. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Autocuidados correspondem a ABVD.

B — Correta: Usar telefone, transporte e gerir dinheiro são AIVD.

C — Incorreta: Higiene, continência e vestir-se são ABVD.

D — Incorreta: Banho/transferência são ABVD.

QUESTÃO 76 — RESPOSTA: B

Fundamento: Tratamento sucessivo de efeitos adversos como novas doenças configura prescrição em cascata. [Fontes: R6]

A — Incorreta: Efeito dominó não é o termo técnico preferível.

B — Correta: Novo fármaco trata efeito adverso de outro: cascata.

C — Incorreta: Interação é outro fenômeno farmacológico.

D — Incorreta: Eficácia de tratamento não é a causa do ciclo.

QUESTÃO 77 — MÚLTIPLAS ALTERNATIVAS DEFENSÁVEIS: A/B/C

Fundamento: Desprescrição deve ser individualizada; retirar preventivos sem avaliar prognóstico, suspender vários fármacos simultaneamente e interromper terapia sintomática necessária podem ser inadequados. [Fontes: R6]

A — Defensável: Retirar preventivos deve considerar prognóstico e preferência.

B — Defensável: Sintomáticos só podem ser suspensos após avaliar necessidade e recidiva.

C — Defensável: Suspender vários de risco simultaneamente dificulta monitorar abstinência.

D — Incorreta: Redução gradual de psicotrópicos é em geral medida prudente.

QUESTÃO 78 — RESPOSTA: A

Fundamento: Preensão palmar de 10 kg em mulher idosa é força baixa: provável sarcopenia; circunferência da panturrilha isolada não confirma massa reduzida. [Fontes: R5]

A — Correta: Força reduzida demonstra provável sarcopenia.

B — Incorreta: Confirmar exige demonstrar massa muscular reduzida.

C — Incorreta: Há achado objetivo de baixa força, contrariando ausência.

D — Incorreta: Dados bastam para provável, ainda não para confirmada.

QUESTÃO 79 — RESPOSTA: D

Fundamento: Lesão indolor, seca/nacarada e sem bolhas sugere queimadura de espessura total (terceiro grau), ainda que coloração seja variável. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Primeiro grau é doloroso e superficial.

B — Incorreta: Segundo grau superficial geralmente é doloroso/bolhoso.

C — Incorreta: Segundo grau profundo pode ser pouco doloroso, mas aspecto seco sugere terceiro.

D — Correta: Indolor e nacarado sem bolhas sugerem terceiro grau.

QUESTÃO 80 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: A

Fundamento: Monoartrite quente em criança é artrite séptica até prova em contrário: radiografia pode integrar avaliação, mas punção e tratamento urgentes não podem esperar. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Defensável: Radiografia é exame adjunto; prioridade é descartar pioartrite.

B — Incorreta: Não se pode esperar 10 dias para avaliação de artrite séptica.

C — Incorreta: Via metafisária é possível conforme anatomia, mas não é certeza.

D — Incorreta: Drenagem de pioartrite, quando indicada, é urgente, não eletiva.

QUESTÃO 81 — RESPOSTA: B

Fundamento: Dor lombar progressiva e persistente em paciente com neoplasia prostática exige investigação de metástase vertebral, idealmente com RM quando indicada. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Trecho da opção incompleto; dor oncológica exige investigar metástase.

B — Correta: Investigação de metástases vertebrais é prioritária.

C — Incorreta: Radiografia pode ser insuficiente para lesões iniciais/compressão.

D — Incorreta: Metástase é possível com piora e câncer prostático.

QUESTÃO 82 — RESPOSTA: D

Fundamento: Herring C: mais de 50% de perda de altura do pilar lateral da epífise femoral na doença de Perthes. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Grupo A preserva altura pilar lateral.

B — Incorreta: Grupo B tem >50% da altura preservada, não colapso de 70%.

C — Incorreta: Grupo B não é definido por achatamento fixo de 60%.

D — Correta: Grupo C apresenta perda de mais de 50% da altura.

QUESTÃO 83 — RESPOSTA: A

Fundamento: Escoliose idiopática do adolescente predomina entre meninas na puberdade/adolescência. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Escoliose adolescente predomina em meninas na puberdade.

B — Incorreta: Meninos também são afetados, menos frequentemente.

C — Incorreta: Faixa até 25 anos extrapola adolescência típica.

D — Incorreta: Sexo e faixa etária não correspondem ao predomínio.

QUESTÃO 84 — RESPOSTA: D

Fundamento: Lesão miotendínea pode causar perda da função por ruptura; fratura, luxação e entorse foram definidas incorretamente nas outras opções. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Fratura é descontinuidade óssea, não incongruência.

B — Incorreta: Luxação é perda da congruência articular.

C — Incorreta: Entorse lesiona cápsula/ligamentos sem fratura necessária.

D — Correta: Ruptura miotendínea pode produzir impotência funcional.

QUESTÃO 85 — RESPOSTA: A

Fundamento: Sarcopenia confirmada requer força e massa muscular baixas; desempenho reduzido identifica forma grave. [Fontes: R5]

A — Correta: Combinação de força e massa baixa confirma sarcopenia.

B — Incorreta: Maior performance não define sarcopenia.

C — Incorreta: Enzimas musculares não definem diagnóstico.

D — Incorreta: Elevação enzimática sugere miopatia, não critério de sarcopenia.

QUESTÃO 86 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: A

Fundamento: Bengala deve ser usada contralateral ao joelho sintomático (mão esquerda para joelho direito) e mover-se junto à perna afetada. [Fontes: R12]

A — Defensável: Uso contralateral é correto, mas a redação sobre degrau é imprecisa.

B — Incorreta: Ao descer, perna afetada desce com bengala antes da íntegra.

C — Incorreta: Para levantar, apoiar braços da cadeira é mais seguro que puxar bengala.

D — Incorreta: Bengala deve acompanhar perna DIREITA sintomática.

QUESTÃO 87 — RESPOSTA: A

Fundamento: Oligoartrite assimétrica de joelho com dactilite em adulto jovem sugere artrite reativa; deve-se procurar infecção antecedente e excluir artrite séptica. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Dactilite/oligoartrite sugerem artrite reativa, ressalvado diferencial psoriásico.

B — Incorreta: AR geralmente simétrica de pequenas articulações.

C — Incorreta: Gota pode atingir joelho, mas dactilite persistente não é característica típica.

D — Incorreta: Pioartrite precisa exclusão se joelho quente, porém não explica bem dactilite bilateral.

QUESTÃO 88 — RESPOSTA: B

Fundamento: I, III e V são verdadeiros: AINEs produzem toxicidade GI, inibem COX e possuem efeitos anti-inflamatório, antipirético e analgésico. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: I é verdadeira: risco gastrointestinal.

B — Correta: II é falsa: corticoide e anti-histamínico não são AINEs.

C — Incorreta: III é verdadeira: COX e prostaglandinas.

D — Incorreta: IV é falsa: composição ácido/base não descreve toda classe; V é verdadeira.

QUESTÃO 89 — RESPOSTA: B

Fundamento: Glicocorticoides reprimem transcrição de mediadores pró-inflamatórios; não aumentam citocinas como IL-2/IL-6. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Hormônios esteroides atravessam membranas lipídicas.

B — Correta: Glicocorticoides diminuem, não aumentam, transcrição pró-inflamatória.

C — Incorreta: Receptor citoplasmático/nuclear altera expressão gênica.

D — Incorreta: Indução de anexina-1 inibe indiretamente PLA2.

QUESTÃO 90 — RESPOSTA: D

Fundamento: Metotrexato é medicamento âncora da artrite reumatoide, com monitorização e ácido fólico. [Fontes: R1]

A — Incorreta: Sulfassalazina é alternativa csDMARD.

B — Incorreta: Leflunomida é alternativa de primeira linha quando necessário.

C — Incorreta: Cloroquina não é fármaco âncora.

D — Correta: Metotrexato é opção central modificadora de doença.

QUESTÃO 91 — RESPOSTA: A

Fundamento: Sarcomas de partes moles usualmente metastatizam por via hematogênica, não exclusivamente por linfonodos. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Disseminação hematogênica predomina nos sarcomas.

B — Incorreta: Indicação de biópsia não depende exclusivamente de >5 cm.

C — Incorreta: Sarcomas são mais comuns em adultos que em crianças em geral.

D — Incorreta: Células fusiformes existem em alguns subtipos, não em todos.

QUESTÃO 92 — MÚLTIPLAS ALTERNATIVAS DEFENSÁVEIS: C/D

Fundamento: Radiografia e ressonância são métodos frequentemente usados; TC e US também são essenciais em indicações específicas, tornando a comparação não exclusiva. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: US/TC são úteis, mas omitem radiografia como base inicial.

B — Incorreta: PET-CT não é exame de rotina para todas afecções.

C — Defensável: Radiografia e RM são métodos comuns.

D — Defensável: Radiografia e TC também são usuais, sobretudo no estudo do osso.

QUESTÃO 93 — RESPOSTA: B

Fundamento: Reabilitação visa maximizar funcionalidade no contexto do paciente e abrange prevenção e tratamento multiprofissional. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Prevenção faz parte da reabilitação.

B — Correta: Busca autonomia e funcionalidade contextual.

C — Incorreta: Fisiatra pode usar medicamentos, terapias, órteses e intervenções.

D — Incorreta: Reabilitação precoce individualizada beneficia muitas fraturas.

QUESTÃO 94 — RESPOSTA: B

Fundamento: Regra dos nove no adulto: membro superior inteiro 9% e metade do tronco anterior 9%, total aproximado 18%. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: 12% não corresponde à regra dos nove descrita.

B — Correta: Braço 9% mais metade do tórax anterior 9% totalizam 18%.

C — Incorreta: 24% superestima a área descrita.

D — Incorreta: 28% superestima a superfície corporal envolvida.

QUESTÃO 95 — RESPOSTA: A

Fundamento: Barlow avalia deslocabilidade com flexão, adução e pressão posterior; detalhes do enunciado são abreviados e não substituem manobra completa. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Barlow descreve provocação de instabilidade com adução, mas requer pressão posterior.

B — Incorreta: Galeazzi pode ser simétrico em DDQ bilateral.

C — Incorreta: Pavlik tem limitações/contraindicações em luxações teratológicas.

D — Incorreta: Cirurgia combinada não é indicação universal aos 12 meses.

QUESTÃO 96 — RESPOSTA: A

Fundamento: Sinal de Hoffmann indica comprometimento de via piramidal em nível cervical, compatível com lesão C4-C5. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Hoffmann positivo aponta para comprometimento cervical.

B — Incorreta: Lesão T8-T9 não explica Hoffmann.

C — Incorreta: T12-L1 não explica alteração piramidal de membros superiores.

D — Incorreta: L4-L5 não gera sinal de Hoffmann.

QUESTÃO 97 — RESPOSTA: C

Fundamento: Fraturas desviadas do rádio e ulna requerem imobilização que bloqueie prono-supinação, como tala axilopalmar/braquiopalmar longa. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Inguinopodálica imobiliza membro inferior.

B — Incorreta: Antebraquiopalmar não estabiliza pronação-supinação da fratura diafisária.

C — Correta: Axilopalmar longa limita cotovelo e antebraço.

D — Incorreta: Toracobraquial é exagerada e pouco indicada.

QUESTÃO 98 — RESPOSTA: A

Fundamento: Paralisia obstétrica alta (Erb, C5-C6) produz Moro assimétrico com preensão palmar geralmente mantida. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Moro assimétrico é típico de lesão C5-C6.

B — Incorreta: Preensão palmar pode ser preservada na paralisia alta.

C — Incorreta: Mão em garra indica acometimento distal/baixo.

D — Incorreta: Rotação interna/pronação (posição do garçom) é típica, não externa/supinação.

QUESTÃO 99 — RESPOSTA: D

Fundamento: Dor, edema/deformidade, hematoma e crepitação/impotência funcional são sinais de fratura; sede e febre não são sinais típicos. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Somente dor/crepitação omite edema e hematoma.

B — Incorreta: Inclui sede/febre, não específicas.

C — Incorreta: Inclui sede e febre, que não definem fratura.

D — Correta: I a IV incluem manifestações clínicas clássicas.

QUESTÃO 100 — RESPOSTA: C

Fundamento: Fratura exposta tem alto risco de infecção e exige antibiótico precoce, limpeza cirúrgica/desbridamento e estabilização; Gustilo não depende apenas de centímetros. [Fontes: R8, R16]

A — Incorreta: Comprimento é apenas um dos critérios Gustilo.

B — Incorreta: Trauma rural pode elevar grau por contaminação, independentemente do tamanho.

C — Correta: Infecção é complicação importante e requer cuidado cirúrgico precoce.

D — Incorreta: Atraso de 6h não torna tratamento conservador padrão.

QUESTÃO 101 — RESPOSTA: C

Fundamento: Infecções e falência orgânica contribuem para mortes tardias após trauma grave; a chamada hora de ouro não é uma garantia rígida de prognóstico. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Rapidez de resposta pode melhorar desfechos, apesar de não haver janela rígida.

B — Incorreta: Choque não é causa principal de mortes exclusivamente após a primeira semana.

C — Correta: Infecções/falência orgânica são riscos tardios.

D — Incorreta: Há uma opção defensável, portanto 'nenhuma' não se justifica.

QUESTÃO 102 — RESPOSTA: C

Fundamento: Expansão de couro cabeludo permite fechar defeitos usando pele vizinha com cabelo de aspecto e textura semelhantes. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Expansão costuma exigir cirurgia adicional e preenchimentos.

B — Incorreta: Requer consultas seriadas, não menos.

C — Correta: Retalho local expandido preserva cabelos.

D — Incorreta: Expansão leva semanas/meses, não é rápida.

QUESTÃO 103 — RESPOSTA: E

Fundamento: Padrões HEp-2: membrana nuclear = anti-lâmina; homogêneo = DNA/nucleossomos; centromérico = anticentrômero; DFS70 = padrão pontilhado fino denso; pontilhado grosso = anti-Sm/RNP; pontilhado fino = anti-SSA. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Anti-lâmina não corresponde a número 1 (DFS70).

B — Incorreta: I não combina com número 4 nesta versão.

C — Incorreta: Pareamentos II e demais não reproduzem padrão conhecido.

D — Incorreta: Apresenta combinação de padrões diferente da sequência correta.

E — Correta: I4/II2/III5/IV1/V6/VI3 corresponde ao pareamento adequado.

QUESTÃO 104 — RESPOSTA: C

Fundamento: Sequência correta: anti-RNP (3), anti-DNA (4), anti-histonas (1), c-ANCA (2), anti-SSA (5). [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Começa com anti-histonas, incorreto para doença mista.

B — Incorreta: Distribui anticorpos inconsistentes com o diagnóstico.

C — Correta: Sequência 3-4-1-2-5 está correta.

D — Incorreta: Inicia anti-Ro como marcador de doença mista, incorreto.

QUESTÃO 105 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: A

Fundamento: Ferritina distingue melhor ferropriva da inflamação que ferro sérico; sangue oculto pode ser buscado, mas não substitui colonoscopia/endoscopia indicadas. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Defensável: Ferritina ajuda; IV pode ser parte de avaliação, mas FOBT isolado é insuficiente.

B — Incorreta: Ferro sérico isolado (I) não é melhor marcador.

C — Incorreta: Reticulócitos isolados (III) não distinguem B12 de ferropriva.

D — Incorreta: I (ferro sérico) não deve substituir ferritina.

QUESTÃO 106 — RESPOSTA: A

Fundamento: Toxicidade por metotrexato acidental exige suspender MTX e administrar resgate com ácido folínico (leucovorina), avaliando função renal e citopenias. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Suspensão e leucovorina são medidas específicas para toxicidade por MTX.

B — Incorreta: Ácido fólico profilático é insuficiente no resgate agudo.

C — Incorreta: Vitamina E não reverte antifolato.

D — Incorreta: Não se deve manter o agente tóxico.

QUESTÃO 107 — RESPOSTA: D

Fundamento: Quadro de gota aguda em paciente com doença renal e angina favorece corticosteroide em vez de AINE; alopurinol é tratamento redutor de urato a longo prazo. [Fontes: R2]

A — Incorreta: AR não se apresenta classicamente como podagra súbita.

B — Incorreta: Alopurinol previne crises, não trata inflamação aguda sozinho.

C — Incorreta: AINE pode piorar DRC, angina e sangramento.

D — Correta: Corticoide pode tratar crise gotosa com riscos avaliados.

QUESTÃO 108 — SEM ALTERNATIVA INEQUIVOCAMENTE CORRETA

Fundamento: Na AR de baixa atividade, guideline ACR favorece inicialmente hidroxicloroquina; TNF isolado não é primeira linha e combinação csDMARD não é automática após falha. [Fontes: R1]

A — Em análise: I está certa, II não é recomendação para todo paciente de baixa atividade.

B — Em análise: III está errada: TNF não é monoterapia inicial indicada.

C — Em análise: II é problemática e IV não é indicação automática, apesar de combinação possível.

D — Em análise: O item III está incorreto, logo não são todas verdadeiras.

QUESTÃO 109 — RESPOSTA: B

Fundamento: MTX é fármaco âncora, colestiramina acelera eliminação de leflunomida, ciclosporina inibe ativação T; inibidores JAK são pequenas moléculas, não anticorpos. [Fontes: R1]

A — Incorreta: I e II são verdadeiros.

B — Correta: I, II e III correspondem aos mecanismos gerais.

C — Incorreta: IV é falso: JAK são moléculas pequenas e orais.

D — Incorreta: Não são todas verdadeiras por erro em IV.

QUESTÃO 110 — RESPOSTA: D

Fundamento: Para joelho direito, bengala é usada à esquerda e avança com membro inferior direito. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Mão direita para joelho direito não reduz adequadamente carga.

B — Incorreta: Avançar bengala com lado esquerdo não acompanha membro afetado.

C — Incorreta: Bengala homolateral não é técnica usual.

D — Correta: Mão esquerda, avançando com perna direita é correto.

QUESTÃO 111 — RESPOSTA: A

Fundamento: CAM identifica delirium; início insidioso e haloperidol IV universal são incorretos. [Fontes: R7]

A — Correta: CAM é instrumento validado para rastrear delirium.

B — Incorreta: Delirium é frequente em idosos hospitalizados.

C — Incorreta: Início agudo e desatenção diferenciam de demência gradual.

D — Incorreta: Haloperidol IV não é tratamento universal nem isento de risco.

QUESTÃO 112 — RESPOSTA: B

Fundamento: Eritema persistente de pele íntegra em proeminência sacral sugere lesão por pressão estágio 1, desde que não seja dermatite associada à umidade. [Fontes: R7]

A — Incorreta: Dermatite por fralda tende a acompanhar umidade e topografia específica.

B — Correta: Eritema sacral intacto sobre proeminência óssea caracteriza estágio 1.

C — Incorreta: Candidíase tende a lesões satélites e pregas.

D — Incorreta: Alergia sistêmica a antibiótico não explica lesão isolada sacral.

QUESTÃO 113 — RESPOSTA: C

Fundamento: GDS evita itens somáticos marcantes que se confundem com doenças físicas do envelhecimento; é rastreio, não diagnóstico isolado. [Fontes: R7]

A — Incorreta: GDS pode ser usada em alguns idosos com déficit cognitivo, mas objetivo específico é rastreio de depressão.

B — Incorreta: Não distingue sozinha tristeza normal do luto.

C — Correta: Evita confundir sintomas somáticos do envelhecimento com depressão.

D — Incorreta: Não é instrumento especializado de estratificação de suicídio.

QUESTÃO 114 — RESPOSTA: A

Fundamento: Há múltiplos princípios ativos mesmo em poucas apresentações e amitriptilina é potencialmente inapropriada ao idoso. [Fontes: R6]

A — Correta: Polifarmácia e amitriptilina com risco anticolinérgico.

B — Incorreta: Número de ativos é maior que o de comprimidos.

C — Incorreta: Apresentações combinadas também entram na contagem.

D — Incorreta: Há amitriptilina potencialmente inapropriada.

QUESTÃO 115 — RESPOSTA: B

Fundamento: Hipertensão, diabetes, depressão e osteoartrite configuram multimorbidade; polineuropatia é complicação diabética. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Tem várias doenças crônicas simultâneas.

B — Correta: Multimorbidade complexa com neuropatia associada ao diabetes.

C — Incorreta: Complicação neuropática está descrita.

D — Incorreta: Não há doença única índice que explique todas as outras.

QUESTÃO 116 — RESPOSTA: C

Fundamento: Cognição flutuante, alucinações visuais estruturadas e parkinsonismo sugerem demência com corpos de Lewy. [Fontes: R7]

A — Incorreta: RM sem insultos múltiplos torna vascular menos provável.

B — Incorreta: Demência por Parkinson requer parkinsonismo consolidado antes de declínio cognitivo.

C — Correta: Flutuação cognitiva, alucinações e parkinsonismo sugerem Lewy.

D — Incorreta: FTD comportamental não costuma apresentar essas alucinações precoces.

QUESTÃO 117 — RESPOSTA: D

Fundamento: Força de 21 kg, massa apendicular/altura² de 6,3 kg/m² e TGUG 25 s mostram sarcopenia confirmada e desempenho baixo (forma grave, pelo EWGSOP2). [Fontes: R5]

A — Incorreta: Parkinsonismo pode coexistir com sarcopenia.

B — Incorreta: Massa medida também está baixa, excedendo 'provável'.

C — Incorreta: Força baixa sem massa e desempenho não basta para grave, mas aqui ambos constam.

D — Correta: Força, massa e desempenho estão alterados.

QUESTÃO 118 — RESPOSTA: B

Fundamento: Limitações relevantes em AIVD e algumas ABVD com necessidade de assistência são compatíveis com fragilidade clínica moderada (CFS 6), ressalvado julgamento global. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Mantém funcionalidade parcial, não terminalidade.

B — Correta: Requer ajuda em múltiplas tarefas, compatível com CFS 6.

C — Incorreta: CFS 5 seria necessidade de ajuda mais limitada nas AIVD.

D — Incorreta: Não é 'regular sem fragilidade' com tanta dependência.

QUESTÃO 119 — RESPOSTA: A

Fundamento: Fisioterapia para mobilidade/queda, fonoaudiologia para disfagia e nutrição para risco nutricional são prioridades funcionais. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Abrange mobilidade, deglutição e risco de desnutrição.

B — Incorreta: Massagem não prioriza problemas funcionais destacados.

C — Incorreta: Educador físico não substitui fono diante de disfagia.

D — Incorreta: Ausência de fono é grande limitação para deglutição.

QUESTÃO 120 — RESPOSTA: B

Fundamento: Rigidez e nódulos de Heberden não são ambos critérios da AR; pequenas articulações predominam; condroitina não evita erosões; FR alto prediz pior prognóstico. [Fontes: R1]

A — Incorreta: Heberden associa-se a osteoartrite, não AR.

B — Correta: F, V, F, V é sequência correta.

C — Incorreta: FR em alto título é associado a pior prognóstico (quarta verdadeira).

D — Incorreta: Primeira proposição é falsa, terceira também.

QUESTÃO 121 — RESPOSTA: D

Fundamento: HLA-B27, uveíte anterior e lombalgia inflamatória são compatíveis com espondilite; osteófitos degenerativos não são a alteração radiológica axial típica. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: II é falsa: osteófitos são degenerativos.

B — Incorreta: O item II invalida a alternativa.

C — Incorreta: O item II invalida a alternativa.

D — Correta: I, III e IV são verdadeiros, sem II.

QUESTÃO 122 — RESPOSTA: B

Fundamento: Gota geralmente se manifesta com monoartrite muito dolorosa, súbita e inflamatória; uricemia pode ser normal na crise. [Fontes: R2]

A — Incorreta: AAS em altas doses é uricosúrico, ao contrário de doses baixas.

B — Correta: Ataque clássico é súbito, monoarticular e intenso.

C — Incorreta: Uricemia da crise pode ser normal e não determina início imediato de urato-redutor.

D — Incorreta: Gota crônica pode levar erosões e incapacidade.

QUESTÃO 123 — RESPOSTA: B

Fundamento: LES ativo frequentemente consome complemento, com C3/C4 baixos; manifestações cutâneas e articulares reforçam a hipótese. [Fontes: R15]

A — Incorreta: LES frequentemente cursa leucopenia, não neutrofilia típica.

B — Correta: Consumo de complemento C3/C4 pode ocorrer em LES ativo.

C — Incorreta: Anti-Scl70 se associa a esclerose sistêmica.

D — Incorreta: FR pode estar positivo mas não define LES.

QUESTÃO 124 — RESPOSTA: C

Fundamento: Usuários de glicocorticoides crônicos devem otimizar cálcio e vitamina D e avaliar risco para terapêutica antirreabsortiva. [Fontes: R4]

A — Incorreta: Corticosteroides podem ser necessários em doenças inflamatórias intestinais.

B — Incorreta: Risco crônico inclui hiperglicemia/hipertensão, não hipo-

C — Correta: Cálcio/vitamina D e avaliação de risco ósseo são indicados.

D — Incorreta: Corticoides diferem em potência e ação mineralocorticoide.

QUESTÃO 125 — RESPOSTA: A

Fundamento: Lesões gástricas de AINEs relacionam-se à inibição de COX-1 e à redução de prostaglandinas citoprotetoras. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: COX-1 ajuda manter prostaglandinas protetoras da mucosa gástrica.

B — Incorreta: COX-2 contribui à inflamação, não é mecanismo único protetor.

C — Incorreta: Fosfodiesterase não é alvo dos AINEs usuais.

D — Incorreta: DHFR é alvo de metotrexato, não de AINEs.

QUESTÃO 126 — RESPOSTA: D

Fundamento: Dor difusa crônica, sono alterado e exames inflamatórios normais sugerem fibromialgia; pregabalina pode ser utilizada caso a caso. [Fontes: R11]

A — Incorreta: Prednisona não é tratamento de fibromialgia.

B — Incorreta: Etoricoxibe não trata sensibilização central crônica.

C — Incorreta: Metotrexato carece de indicação sem artrite inflamatória.

D — Correta: Pregabalina pode auxiliar sintomas, junto às medidas não farmacológicas.

QUESTÃO 127 — RESPOSTA: B

Fundamento: Corticosteroide sistêmico, heparina prolongada e alguns anticonvulsivantes, incluindo carbamazepina, favorecem perda óssea. [Fontes: R4]

A — Incorreta: Hidroclorotiazida pode reduzir calciúria e não é causa típica de perda óssea.

B — Correta: Corticoide, heparina prolongada e carbamazepina aumentam risco.

C — Incorreta: Repetição da alternativa A, com tiazídico não causal.

D — Incorreta: Carisoprodol não integra tríade clássica de osteoporose medicamentosa.

QUESTÃO 128 — RESPOSTA: A

Fundamento: Condrócitos ativados liberam enzimas catabólicas como metaloproteinases que degradam matriz da cartilagem. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Metaloproteinases de condrócitos promovem degradação cartilaginosa.

B — Incorreta: Fatores de crescimento tendem a estimular reparação/anabolismo.

C — Incorreta: Óxido nítrico favorece catabolismo e morte condrocitária.

D — Incorreta: Mais PAI-1 reduz plasmina, não explica aumento dela.

QUESTÃO 129 — RESPOSTA: B

Fundamento: Diabetes e hipotireoidismo são causas/riscos de neuropatia compressiva do mediano, explicando túnel do carpo bilateral. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Idade e profissão não explicam riscos endócrino-metabólicos descritos.

B — Correta: Hipotireoidismo/diabetes são fatores associados à compressão do mediano.

C — Incorreta: Profissão é contribuinte, mas ignora comorbidades maiores.

D — Incorreta: Menopausa/idade podem contribuir, mas quadro destaca diabetes e tireoide.

QUESTÃO 130 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: A

Fundamento: Lipoma é hipótese benigna plausível em nódulos superficiais múltiplos, mas dimensão de 5 cm pede avaliação especializada se indeterminado. [Fontes: R10]

A — Defensável: Hipótese benigna mais provável, mas tamanho impõe cautela diagnóstica.

B — Incorreta: Hemangioma exigiria sinais vasculares.

C — Incorreta: Rabdomiossarcoma embrionário é muito raro aos 60 anos.

D — Incorreta: Sarcoma pleomórfico existe nessa faixa, sem elementos específicos.

E — Incorreta: Osteoma é lesão óssea, não subcutânea.

QUESTÃO 131 — RESPOSTA: D

Fundamento: Sarcomas retroperitoneais estão associados a ressecção difícil, recorrência local e prognóstico menos favorável. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Sarcomas metastatizam predominantemente via sangue.

B — Incorreta: RM mostra extensão, não identifica subtipo sem biópsia.

C — Incorreta: Mais comuns em adultos/idosos.

D — Correta: Retroperitônio pode piorar prognóstico.

QUESTÃO 132 — RESPOSTA: B

Fundamento: Massa maior que 5 cm e/ou em crescimento é sinal de alerta, justificando imagem especializada e biópsia planejada. [Fontes: R10]

A — Incorreta: Dor/rubor são inespecíficos, crescimento rápido preocupa mas não estabelece única indicação.

B — Correta: Tamanho e progressão são sinais fortes de alerta.

C — Incorreta: Trauma prévio não exclui sarcoma, mas não determina indicação sozinho.

D — Incorreta: Localização junto à articulação não define malignidade.

QUESTÃO 133 — RESPOSTA: A

Fundamento: Radiografia convencional é projeção bidimensional, não método multiplanar como TC/RM. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Radiografia convencional é projetiva, não multiplanar.

B — Incorreta: Utiliza raios X ionizantes.

C — Incorreta: Duas incidências são recomendadas em muitas lesões.

D — Incorreta: É amplamente disponível e de baixo custo.

QUESTÃO 134 — RESPOSTA: D

Fundamento: Radiografia, ultrassonografia, TC e ressonância compõem o arsenal de imagem mais utilizado. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Bursografia não é método corrente de rotina.

B — Incorreta: Discografia raramente integra avaliação de rotina.

C — Incorreta: Mielografia é hoje reservada para indicações específicas.

D — Correta: RX/US/TC/RM são bases da investigação osteoarticular.

QUESTÃO 135 — RESPOSTA: A

Fundamento: Osteoartrite: osteófitos, esclerose, cistos e redução localizada do espaço articular. [Fontes: R3]

A — Correta: Sinais degenerativos favorecem osteoartrite.

B — Incorreta: Psoriásica tem erosão/proliferação óssea diferente.

C — Incorreta: AR tem erosão marginal e osteopenia periarticular.

D — Incorreta: Gota tem lesões em saca-bocado com bordas salientes.

QUESTÃO 136 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: B

Fundamento: Ferritina é melhor marcador de reservas que ferro sérico isolado; investigação de hemorragia gastrointestinal por ferropriva não se limita a sangue oculto. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Ferro sérico isolado tem baixa especificidade e variabilidade.

B — Defensável: Ferritina melhor discrimina reservas, mas IV carece ressalva endoscópica.

C — Incorreta: Reticulócitos isolados não distinguem diretamente essas etiologias.

D — Incorreta: IV pode ser útil historicamente, mas FOBT não é condição para estudo do sangramento.

QUESTÃO 137 — RESPOSTA: C

Fundamento: Métodos na ordem: imunofluorescência indireta, imunodifusão radial, Western blot, imunofluorescência direta e ELISA. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: I é IIF, não direta.

B — Incorreta: A primeira IIF, mas segunda deve ser imunodifusão radial.

C — Correta: Ordem IIF, difusão, Western, IF direta, ELISA é a correta.

D — Incorreta: A terceira técnica é Western, não ELISA.

QUESTÃO 138 — RESPOSTA: C

Fundamento: Na ordem das doenças: anti-RNP, anti-dsDNA, anti-histonas, c-ANCA e anti-Ro, isto é, 3-4-1-2-5. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Começa com histonas em doença mista, errado.

B — Incorreta: Inverte relações entre marcadores e doenças.

C — Correta: Corresponde a sequência 3-4-1-2-5.

D — Incorreta: Anti-Ro não é marcador mais típico da doença mista.

QUESTÃO 139 — RESPOSTA: C

Fundamento: Erosões marginais, estreitamento difuso e osteopenia periarticular sugerem artropatia inflamatória. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Osteoartrite não causa osteopenia e erosões marginais típicas.

B — Incorreta: Pioartrite costuma monoarticular e rapidamente destrutiva.

C — Correta: Padrão corresponde a artropatia inflamatória.

D — Incorreta: Gota frequentemente preserva espaço até fases tardias.

QUESTÃO 140 — RESPOSTA: A

Fundamento: Radiografia convencional não adquire cortes multiplanares; produz imagens projetivas. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Radiografia convencional é método projetivo.

B — Incorreta: Raios X são ionizantes.

C — Incorreta: Incidências ortogonais são frequentes.

D — Incorreta: Acessibilidade é característica correta.

QUESTÃO 141 — RESPOSTA: D

Fundamento: Radiografia, US, TC e RM são métodos correntes de imagem osteoarticular. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Bursografia não é exame de uso rotineiro.

B — Incorreta: Discografia é procedimento selecionado.

C — Incorreta: Mielografia não é avaliação corrente de primeira linha.

D — Correta: RX, US, TC e RM são métodos mais utilizados.

QUESTÃO 142 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: C

Fundamento: Corticoide em dose anti-inflamatória pode servir como ponte curta, mas AR erosiva exige iniciar DMARD (habitualmente metotrexato); a alternativa é incompleta. [Fontes: R1]

A — Incorreta: Hidroxicloroquina isolada pode ser insuficiente em AR erosiva.

B — Incorreta: Glicosamina não controla inflamação/erosão da AR.

C — Defensável: Corticoide pode ser ponte curta, mas iniciar DMARD é indispensável.

D — Incorreta: Pregabalina não modifica doença inflamatória.

QUESTÃO 143 — RESPOSTA: B

Fundamento: Uricemia pode diminuir ou estar normal durante ataque agudo de gota; dosagem isolada na crise não exclui doença. [Fontes: R2]

A — Incorreta: Ataques são rápidos e flogísticos, não lentos.

B — Correta: Uricemia pode estar normal durante crise.

C — Incorreta: Gota tofácea pode produzir dano permanente.

D — Incorreta: Alopurinol previne hiperuricemia, não é antinflamatório da crise.

QUESTÃO 144 — RESPOSTA: D

Fundamento: Lúpus grave pode requerer imunossupressão e anti-dsDNA correlaciona-se a atividade/nefrite; antifosfolípide positivo isolado não impõe anticoagulação. [Fontes: R15]

A — Incorreta: II isoladamente é falso por não impor anticoagulação.

B — Incorreta: II exige trombose/SAF diagnosticada e não só anticorpo.

C — Incorreta: III é falso: complemento cai na atividade.

D — Correta: I e IV são verdadeiros no contexto adequado.

QUESTÃO 145 — RESPOSTA: A

Fundamento: Sjögren costuma gerar artrite não erosiva; AR, gota e artrite psoriásica podem causar erosões. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Artrite associada a Sjögren é habitualmente não erosiva.

B — Incorreta: AR é causa clássica de erosões.

C — Incorreta: Gota crônica pode produzir erosões.

D — Incorreta: Psoriásica pode gerar erosões com neoformação óssea.

QUESTÃO 146 — RESPOSTA: B

Fundamento: Metotrexato não é recomendado para osteoartrite; exercício, Tai chi, órteses e AINE tópico podem ser recomendados conforme sítio. [Fontes: R3]

A — Incorreta: Órteses da primeira CMC são recomendadas para artrose de mãos.

B — Correta: Metotrexato não é recomendado para osteoartrite.

C — Incorreta: Tai chi é recomendado para quadril/joelho.

D — Incorreta: AINE tópico é recomendado para joelhos.

QUESTÃO 147 — RESPOSTA: D

Fundamento: Jobe (empty can) testa o tendão supraespinhal; Gerber é subescapular, Patte infraespinhal/rotadores externos. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Yocum provoca impacto subacromial, não testa especificamente supraespinal.

B — Incorreta: Gerber testa subescapular.

C — Incorreta: Patte avalia infraespinhal e rotadores externos.

D — Correta: Jobe é teste funcional do supraespinhal.

QUESTÃO 148 — RESPOSTA: B

Fundamento: Pregabalina pode aliviar sintomas de fibromialgia; investigação invasiva e imunossupressão não se justificam pelo quadro. [Fontes: R11]

A — Incorreta: Polissonografia, líquor e ENMG não são exames de rotina para FM.

B — Correta: Pregabalina é opção de manejo sintomático.

C — Incorreta: Ausência de sinovite e exames normais não sugere LES.

D — Incorreta: Imunossupressão sem doença autoimune não é adequada.

QUESTÃO 149 — RESPOSTA: D

Fundamento: Ibandronato é bisfosfonato; denosumabe é anti-RANKL, abaloparatida anabólico e romosozumabe anti-esclerostina. [Fontes: R14]

A — Incorreta: Abaloparatida é análogo PTHrP, anabólico.

B — Incorreta: Romosozumabe é anti-esclerostina.

C — Incorreta: Denosumabe é anticorpo anti-RANKL.

D — Correta: Ibandronato é bisfosfonato antirreabsortivo.

QUESTÃO 150 — RESPOSTA: C

Fundamento: Etoricoxibe é COX-2 preferencial/seletivo com menor risco de úlcera que AINE não seletivo, sem eliminar risco GI/CV/renal. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Nimesulida tem risco GI e hepatotoxicidade.

B — Incorreta: Piroxicam aumenta risco de úlcera e sangramento.

C — Correta: Etoricoxibe tem seletividade COX-2 com ressalvas CV/renal.

D — Incorreta: Diclofenaco é menos apropriado em antecedente ulceroso.

QUESTÃO 151 — RESPOSTA: C

Fundamento: Exercício global com sustentação de peso e resistência contribui para prevenção de perda óssea, com avaliação de segurança. [Fontes: R14]

A — Incorreta: Hidroterapia tem menor estímulo osteogênico pela flutuação.

B — Incorreta: Alongamento não estimula especialmente densidade óssea.

C — Correta: Exercício resistido/impacto supervisionado melhora estímulo osteogênico.

D — Incorreta: Localizado sem carga oferece benefício osteogênico menor.

QUESTÃO 152 — RESPOSTA: A

Fundamento: Sinais de intoxicação por MTX requerem suspensão e resgate com leucovorina; investigar mielossupressão, mucosite e toxicidade orgânica. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Leucovorina reverte antagonismo do folato em intoxicação.

B — Incorreta: Ácido fólico não basta para intoxicação grave.

C — Incorreta: Vitamina E não neutraliza MTX.

D — Incorreta: Manter MTX perpetua toxicidade.

QUESTÃO 153 — RESPOSTA: D

Fundamento: Crise de gota em pessoa com DRC e doença coronariana favorece corticoterapia em vez de AINE; ajustar conforme infecção e comorbidades. [Fontes: R2]

A — Incorreta: AR não costuma iniciar por podagra.

B — Incorreta: Allopurinol não é analgesia específica aguda.

C — Incorreta: AINES têm contraindicações relevantes em DRC/coronariopatia.

D — Correta: Corticoides podem tratar crise, com monitorização.

QUESTÃO 154 — SEM ALTERNATIVA INEQUIVOCAMENTE CORRETA

Fundamento: O item II não é recomendação universal na AR com baixa atividade; o item III está errado e o IV descreve opção possível, não indicação absoluta; gabarito sem combinação adequada. [Fontes: R1]

A — Em análise: II não é regra para AR com baixa atividade.

B — Em análise: III é falso: biológico não é primeira linha isolada.

C — Em análise: II problemática e IV é opção após avaliação, não regra obrigatória.

D — Em análise: III falso exclui todas verdadeiras.

QUESTÃO 155 — RESPOSTA: B

Fundamento: Metotrexato é âncora; leflunomida sofre eliminação acelerada com colestiramina; ciclosporina modula linfócitos T; JAK inibidores são fármacos orais, não anticorpos. [Fontes: R1]

A — Incorreta: I e II são verdadeiras.

B — Correta: Ciclosporina atua sobre linfócitos T; I a III defensáveis.

C — Incorreta: IV é falso pois tofacitinibe/baricitinibe não são anticorpos.

D — Incorreta: O item IV impede 'todas verdadeiras'.

QUESTÃO 156 — RESPOSTA: B

Fundamento: Osteossarcoma é neoplasia maligna óssea clássica da adolescência, mais frequente nessa faixa que os outros tumores listados. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Células gigantes são mais típicas após maturidade esquelética.

B — Correta: Osteossarcoma é câncer ósseo maligno clássico em adolescentes.

C — Incorreta: Condroblastoma pode ocorrer nessa faixa, mas é menos comum.

D — Incorreta: Condrossarcoma geralmente é de adultos maduros.

QUESTÃO 157 — RESPOSTA: A

Fundamento: Sarcomas de partes moles geralmente disseminam pelo sangue, não por via linfática. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Disseminação via sangue é a mais comum, não linfática.

B — Incorreta: RM não define histologia com precisão suficiente.

C — Incorreta: Sarcomas de partes moles são mais comuns com envelhecimento.

D — Incorreta: Retroperitônio geralmente piora prognóstico.

QUESTÃO 158 — SEM ALTERNATIVA INEQUIVOCAMENTE CORRETA

Fundamento: A lesão epifisária rica em células gigantes não estabelece distinção entre quatro sarcomas alternativos pouco típicos; requer histopatologia, sem resposta única. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Em análise: Sarcoma fibromixoide raro/atípico para o quadro.

B — Em análise: Mieloma é raro aos 25 anos e não se define por células gigantes.

C — Em análise: Rabdomiossarcoma não costuma lesão epifisária assim.

D — Em análise: Ewing é tipicamente diafisário e não histologicamente gigante: várias igualmente improváveis.

QUESTÃO 159 — RESPOSTA: C

Fundamento: Quadril instável pode estar reduzido e luxar à adução com pressão posterior (Barlow); quadril luxado fixo não é sinônimo. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Abdução geralmente estabiliza/reduz o quadril.

B — Incorreta: Cobertura de 50% não define prova clínica de instabilidade.

C — Correta: Adução/pressão posterior pode deslocar quadril reduzido instável.

D — Incorreta: Incongruência persistente representa displasia/luxação, não teste de instabilidade.

QUESTÃO 160 — RESPOSTA: A

Fundamento: Aut enxerto apresenta boa integração e tolerância; implica sítio doador e disponibilidade limitada. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Autoenxerto tem boa integração e histocompatibilidade.

B — Incorreta: Exige área doadora e pode causar morbidade.

C — Incorreta: A quantidade é limitada pelo sítio doador.

D — Incorreta: Não elimina morbidade inicial cirúrgica.

QUESTÃO 161 — RESPOSTA: D

Fundamento: Tubérculo maior do úmero costuma desviar superoposteriormente por ação do supra/infraespinal. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Tubérculo maior não é deslocado anteroinferiormente.

B — Incorreta: Inserção do supraespinal puxa para cima, não baixo.

C — Incorreta: Rotadores externos também puxam posterior, não anterior.

D — Correta: Tração do manguito desloca superoposteriormente.

QUESTÃO 162 — RESPOSTA: D

Fundamento: Na assistência inicial de fratura fechada desviada, imobilizar incluindo articulações adjacentes e reavaliar perfusão; redução é feita por profissional capacitado quando indicada. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Não imobilizar fratura desviada causa lesão adicional.

B — Incorreta: Redução pode ser necessária mas não deve ser feita indiscriminadamente no primeiro atendimento.

C — Incorreta: Gelo e compressão não substituem estabilização adequada.

D — Correta: Imobilizar articulações adjacentes e verificar perfusão é orientação segura.

QUESTÃO 163 — RESPOSTA: D

Fundamento: Objetivos de reabilitação mudam conforme progresso e participação do paciente; equipe deve reavaliar metas funcionais. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Houve progressos funcionais objetivos.

B — Incorreta: Autocuidado não é único objetivo de reabilitação.

C — Incorreta: Hemiplegia não elimina toda capacidade de tarefas bimanuais.

D — Correta: Metas devem refletir projeto de vida e evolução funcional.

QUESTÃO 164 — RESPOSTA: B

Fundamento: Ausência de pulso distal após fratura é sinal de alarme para lesão arterial; palidez e frialdade também importam. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Parestesia pode apontar lesão nervosa, não define perfusão arterial.

B — Correta: Pulso ausente é sinal objetivo de lesão vascular importante.

C — Incorreta: Palidez sugere isquemia mas pode ser mais tardia/inespecífica.

D — Incorreta: Frialdade distal reforça comprometimento, não mais específico que pulso ausente.

QUESTÃO 165 — MÚLTIPLAS ALTERNATIVAS DEFENSÁVEIS: B/C

Fundamento: Maioria das lombalgias é inespecífica e muitos episódios são agudos; hérnia L4-L5 posterolateral comprime raiz L5, logo B e C são corretas. [Fontes: R13]

A — Incorreta: A maioria é inespecífica, não compressiva identificável.

B — Defensável: A maioria dos episódios é aguda, descrição verdadeira.

C — Defensável: Hérnia póstero-lateral L4-L5 comprime frequentemente raiz L5: verdadeiro.

D — Incorreta: RM com compressão sem déficit progressivo não impõe cirurgia inicial.

QUESTÃO 166 — RESPOSTA: B

Fundamento: Sem déficit ou sinais sistêmicos, lombalgia mecânica deve receber reabilitação e educação antes de RM rotineira. [Fontes: R13]

A — Incorreta: Ausência de alertas dispensa RM de rotina.

B — Correta: Mobilidade, fortalecimento e orientações são adequados.

C — Incorreta: AINE/miorrelaxante por seis semanas contínuas é excessivo.

D — Incorreta: Sintomas não caracterizam hérnia compressiva.

QUESTÃO 167 — RESPOSTA: A

Fundamento: Classificação histórica de Edberg descreve progressão de hiperemia, isquemia, necrose e ulceração, mas não substitui estágios NPIAP. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Sequência histórica hiperemia-isquemia-necrose-ulceração.

B — Incorreta: Começar por necrose inverte evolução.

C — Incorreta: Hiperemia costuma preceder isquemia irreversível no esquema citado.

D — Incorreta: Começar pela ulceração inverte progressão.

QUESTÃO 168 — RESPOSTA: A

Fundamento: Escoliose idiopática do adolescente é mais comum entre meninas durante crescimento puberal. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Predominam meninas em idade puberal.

B — Incorreta: Sexo masculino é menos afetado em curvas progressivas.

C — Incorreta: Até 25 anos ultrapassa adolescência típica.

D — Incorreta: Sexo e faixa não refletem epidemiologia usual.

QUESTÃO 169 — RESPOSTA: D

Fundamento: SPIKES orienta preparação, percepção, convite, conhecimento, emoções e estratégia; não impõe informação completa sobre terminalidade. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Preparar ambiente integra 'Setting'.

B — Incorreta: Empatia e comunicação integram 'Emotions'/'Knowledge'.

C — Incorreta: Avalia percepção e convite à informação.

D — Correta: SPIKES não obriga informar toda terminalidade sem respeitar preferência.

QUESTÃO 170 — RESPOSTA: C

Fundamento: Fraqueza muscular por preensão reduzida é um dos cinco critérios de Fried; quedas e perímetro da panturrilha não são critérios originais. [Fontes: R5]

A — Incorreta: Circunferência da panturrilha não é critério Fried original.

B — Incorreta: Histórico de quedas não é item original.

C — Correta: Força de preensão diminuída está no fenótipo Fried.

D — Incorreta: IMC absoluto não é um dos critérios originais.

QUESTÃO 171 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: B

Fundamento: Há múltiplas condições crônicas e vários princípios ativos; peso de 52 kg/1,64 m resulta IMC cerca de 19,3, compatível com baixo peso para idoso. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: IMC atual é baixo, não obesidade.

B — Defensável: Doenças múltiplas, polifarmácia e IMC ~19 sustentam opção.

C — Incorreta: Há polifarmácia por seis substâncias.

D — Incorreta: Peso normal não corresponde a IMC 19,3 em idoso.

QUESTÃO 172 — RESPOSTA: A

Fundamento: Força 23 kg, massa apendicular/altura² 6,3 kg/m² e marcha 0,6 m/s indicam sarcopenia grave conforme EWGSOP2. [Fontes: R5]

A — Correta: Baixa massa, força e desempenho indicam forma grave.

B — Incorreta: Há também alteração de desempenho, portanto não somente moderada.

C — Incorreta: Há massa baixa confirmada; não é apenas provável.

D — Incorreta: Força 23 kg está abaixo do corte masculino.

QUESTÃO 173 — RESPOSTA: B

Fundamento: 78 g/dia = 1,5 g/kg/dia para 52 kg, oferta proteica plausível em reabilitação com função renal preservada. [Fontes: R5]

A — Incorreta: 1 g/kg/dia é inferior à meta proposta e dose única é desnecessária.

B — Correta: 1,5 g/kg/dia corresponde a 78 g divididos durante o dia.

C — Incorreta: 3 g/kg/dia pode ser excessivo sem indicação.

D — Incorreta: Proteína não deve ser concentrada exclusivamente em dose de 90 g.

QUESTÃO 174 — RESPOSTA: A

Fundamento: Desprescrição prioriza medicamentos potencialmente inapropriados, sem indicação atual ou cuja razão risco-benefício seja desfavorável. [Fontes: R6]

A — Correta: Medicamentos potencialmente inapropriados merecem revisão prioritária.

B — Incorreta: Duas drogas podem ser justificadas por indicação clínica.

C — Incorreta: Idosos merecem titulação adequada, mas dose de jovem isolada não define desprescrição.

QUESTÃO 175 — RESPOSTA: D

Fundamento: Desinibição, comportamentos inadequados, apatia e prejuízo executivo com memória relativamente mantida sugerem demência frontotemporal comportamental. [Fontes: R7]

A — Incorreta: Predominam sintomas comportamentais/executivos, não amnésticos de Alzheimer.

B — Incorreta: A variante de linguagem cursa afasia progressiva predominante.

C — Incorreta: Alzheimer típico começa com amnésia, sem desinibição inicial tão marcante.

D — Correta: FTD comportamental é hipótese principal, apesar de RM inespecífica.

QUESTÃO 176 — RESPOSTA: B

Fundamento: SPECT perfusional pode revelar hipoperfusão frontotemporal quando RM é pouco expressiva; FDG-PET pode ser mais informativo onde disponível. [Fontes: R7]

A — Incorreta: Biomarcadores de Alzheimer não confirmam FTD comportamental.

B — Correta: SPECT pode demonstrar alterações funcionais frontotemporais.

C — Incorreta: EEG não costuma confirmar esse diagnóstico.

D — Incorreta: Polissonografia avalia sono, não FTD.

QUESTÃO 177 — RESPOSTA: C

Fundamento: Múltiplas contraturas integram critérios maiores e afasia critério menor na classificação tradicional de síndrome da imobilidade. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Déficit cognitivo e contraturas são ambos critérios maiores.

B — Incorreta: Disfagia e dupla incontinência são critérios menores.

C — Correta: Contraturas são maiores e afasia menor.

D — Incorreta: Lesão por pressão/disfagia são ambos menores na classificação.

QUESTÃO 178 — RESPOSTA: C

Fundamento: ESAS admite acréscimo de sintomas; cada domínio básico é quantificado numericamente de 0 a 10. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: ESAS usa graduação numérica, não só qualitativa.

B — Incorreta: A escala não contém obrigatoriamente 20 sintomas.

C — Correta: Permite acrescentar outros sintomas à avaliação.

QUESTÃO 179 — RESPOSTA: B

Fundamento: Multimorbidade é presença de duas ou mais doenças crônicas ao mesmo tempo, independentemente de infecção/complicações agudas. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Pneumonia pode ser complicação, mas não define multimorbidade.

B — Correta: Doenças crônicas simultâneas estabelecem multimorbidade.

C — Incorreta: Quadro agudo concomitante não é a definição.

D — Incorreta: Sepse e IRA são complicações agudas, não conceito de multimorbidade.

QUESTÃO 180 — RESPOSTA: A

Fundamento: Entre grupos etários agregados, a população 80+ deve apresentar maior crescimento percentual por envelhecimento demográfico. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: 80+ apresenta crescimento proporcional expressivo.

B — Incorreta: Grupo adulto 15-59 cresce mais lentamente.

C — Incorreta: 60+ cresce, mas subgrupo 80+ tem maior crescimento percentual.

D — Incorreta: 0-14 tende menor participação proporcional.

QUESTÃO 181 — RESPOSTA: D

Fundamento: Síndromes geriátricas são multifatoriais e compartilham fatores de risco, diferenciando-se de processos etiológicos únicos. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Algumas síndromes afetam ABVD, outras não.

B — Incorreta: Síndrome geriátrica não exige idade >60 em toda definição.

C — Incorreta: Prognóstico adverso é consequência possível, não aspecto definidor único.

D — Correta: Multifatorialidade e interação entre síndromes são centrais.

QUESTÃO 182 — RESPOSTA: C

Fundamento: Alucinações visuais detalhadas precoces são sugestivas de demência por corpos de Lewy. [Fontes: R7]

A — Incorreta: Dementia vascular tipicamente envolve lesões vasculares.

B — Incorreta: FTD não caracteriza alucinações precoces bem formadas.

C — Correta: Alucinações visuais precoces sugerem Lewy.

D — Incorreta: Alzheimer pode ter psicose tardiamente, menos precocemente.

QUESTÃO 183 — RESPOSTA: B

Fundamento: Delirium é de instalação aguda/subaguda e oscilante, não gradual por meses/anos. [Fontes: R7]

A — Incorreta: Confusão aguda é achado comum.

B — Correta: Delirium não é de início gradual crônico.

C — Incorreta: Desorientação é comum.

D — Incorreta: Déficit de atenção é achado central.

QUESTÃO 184 — RESPOSTA: B

Fundamento: Alteração significativa do nível de consciência é típica de delirium e não de demência leve/moderada isolada. [Fontes: R7]

A — Incorreta: Linguagem pode ser afetada em ambas condições.

B — Correta: Rebaixamento de consciência não é típico de demência leve/moderada.

C — Incorreta: Comprometimento cognitivo ocorre em ambas.

D — Incorreta: Sintomas psicóticos podem ocorrer em ambas, embora padrões difiram.

QUESTÃO 185 — RESPOSTA: A

Fundamento: Transtorno neurocognitivo maior envolve declínio cognitivo que interfere na independência em atividades cotidianas. [Fontes: R7]

A — Correta: Prejuízo de independência nas atividades diferencia demência de CCL.

B — Incorreta: Dirigir pode ser afetado, mas não é obrigatório.

C — Incorreta: Atividade física não define gravidade cognitiva.

D — Incorreta: Incontinência não é critério universal de demência.

QUESTÃO 186 — RESPOSTA: C

Fundamento: Há mais de cinco princípios ativos apesar das associações comerciais e vias de administração: polifarmácia. [Fontes: R6]

A — Incorreta: Apresentações combinadas e inaladores também entram no cálculo.

B — Incorreta: Número de comprimidos não é critério; contam princípios ativos.

C — Correta: Diversos princípios ativos configuram polifarmácia.

D — Incorreta: Não se contam apenas drogas por doença individual.

QUESTÃO 187 — RESPOSTA: A

Fundamento: Em demência avançada, estatina preventiva pode trazer benefício tardio insuficiente e ônus desproporcional; rever conforme prognóstico. [Fontes: R6]

A — Correta: Prevenção primária/secundária pode perder benefício líquido em fim de vida.

B — Incorreta: Antieméticos podem ter indicação de conforto.

C — Incorreta: Analgésicos frequentemente são apropriados para conforto.

D — Incorreta: Antiepilépticos podem ser necessários para controlar convulsões.

QUESTÃO 188 — RESPOSTA: D

Fundamento: TGUG 24 s indica mobilidade lenta e alto risco de queda, embora depressão e AIVD também contribuam. [Fontes: R12]

A — Incorreta: Osteoporose aumenta gravidade das fraturas mais que prever queda.

B — Incorreta: Depressão pode contribuir, mas TGUG 24 s é marcador motor objetivo.

C — Incorreta: AIVD prejudicadas importam, mas teste de mobilidade é mais diretamente preditivo.

D — Correta: TGUG muito alterado sinaliza risco de novas quedas.

QUESTÃO 189 — RESPOSTA: C

Fundamento: Mecanismo principal da hiperuricemia na gota primária é hipoexcreção renal de urato. [Fontes: R2]

A — Incorreta: Dieta rica em purinas pode agravar, não explica maioria da hiperuricemia.

B — Incorreta: Renovação celular elevada é mecanismo de hiperprodução secundária.

C — Correta: Subexcreção renal é mecanismo predominante.

D — Incorreta: Deficiência total de HGPRT é doença rara (Lesch-Nyhan).

QUESTÃO 190 — RESPOSTA: C

Fundamento: Tronzo I e II são fraturas transtrocanterianas mais estáveis; necrose da cabeça é mais típica do colo femoral intracapsular. [Fontes: R9]

A — Incorreta: Pseudoartrose é menos típica que em fratura do colo.

B — Incorreta: O tratamento costuma ser osteossíntese, artroplastia não é rotina.

C — Correta: Tronzo I/II correspondem a padrões estáveis.

D — Incorreta: Necrose da cabeça não é complicação principal transtrocanteriana.

QUESTÃO 191 — RESPOSTA: C

Fundamento: Luxação fechada recente do cotovelo exige redução urgente sob analgesia/sedação, reexame neurovascular e imobilização temporária. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Redução na sala é possível com analgesia/sedação e equipe; sem preparação especificada, C é mais segura.

B — Incorreta: Redução aberta não é rotina na luxação simples fechada.

C — Correta: Redução incruenta urgente sob anestesia/sedação é adequada.

D — Incorreta: Não se deve adiar redução até o dia seguinte.

QUESTÃO 192 — RESPOSTA: D

Fundamento: Heliotropo palpebral, pápulas de Gottron e fraqueza proximal definem suspeita de dermatomiosite. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Lúpus não caracteriza heliotropo e Gottron associados à fraqueza.

B — Incorreta: Vasculite urticariforme não é padrão de miosite.

C — Incorreta: Hipersensibilidade não explica sinais dermatológicos característicos.

D — Correta: Dermatomiosite une lesões cutâneas típicas e miosite.

QUESTÃO 193 — RESPOSTA: C

Fundamento: Obesidade, início puberal e quadril doloroso com rotação externa sugerem epifisiólise femoral proximal. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Perthes costuma início 4-8 anos e não exige obesidade típica.

B — Incorreta: Artrite idiopática juvenil tem artrite inflamatória crônica.

C — Correta: Epifisiólise associa obesidade e rotação externa.

D — Incorreta: Sinovite transitória costuma ser aguda em crianças menores.

QUESTÃO 194 — RESPOSTA: B

Fundamento: Classificação de Winters-Gage-Hicks: tipo III de hemiplegia espástica envolve deformidades de pé e joelho. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Tipo I envolveria principalmente o pé.

B — Correta: Tipo III envolve tornozelo/pé e joelho.

C — Incorreta: Tipo IV pode abranger quadril associado.

D — Incorreta: Não define tipo III apenas joelho e quadril.

QUESTÃO 195 — RESPOSTA: B

Fundamento: Fratura espiral apresenta maior área de contato entre fragmentos que fratura cominutiva, favorecendo consolidação quando estável. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Cominuição dificulta estabilidade e contato ósseo.

B — Correta: Traço espiral proporciona maior área de contato quando estável.

C — Incorreta: Valgo é alinhamento/desvio, não configuração facilitadora geral.

D — Incorreta: Varo também não facilita universalmente a consolidação.

QUESTÃO 196 — RESPOSTA: D

Fundamento: Anticoagulante lúpico pode estar presente em SAF secundária ao LES, mas diagnóstico exige persistência e manifestação clínica. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Anti-Sm é altamente específico para LES, não usualmente AR.

B — Incorreta: Anti-RNP pode ocorrer em várias conectivopatias, mas não é marcador clássico isolado de Sjögren.

C — Incorreta: Anti-Ro/La se relacionam sobretudo a Sjögren/LES, não assinatura de esclerodermia.

D — Correta: Anticoagulante lúpico pode sustentar SAF secundária com clínica apropriada.

QUESTÃO 197 — RESPOSTA: D

Fundamento: Fator reumatoide pode ocorrer em AR, Sjögren e infecção crônica por hepatite C. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Inclui Sjögren e hepatite C, mas omite AR.

B — Incorreta: Inclui HCV e AR, mas omite Sjögren.

C — Incorreta: FR não é exclusivo de AR.

D — Correta: As três condições podem cursar com FR positivo.

QUESTÃO 198 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: C

Fundamento: Acidentes de trânsito são importante mecanismo de trauma raquimedular, mas proporção superior a 50% varia por país/período e não deve ser universalizada. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Ferimentos por arma de fogo são causa importante em algumas regiões, não principal universal.

B — Incorreta: Lombar não é segmento isoladamente mais exposto em geral.

C — Defensável: Trauma automobilístico é causa importante, proporção varia.

D — Incorreta: Segmento torácico não é o único ou mais frequente globalmente.

QUESTÃO 199 — RESPOSTA: D

Fundamento: Densitometria é recomendada a todas mulheres a partir de 65 anos e mais cedo com fatores de risco, não indiscriminadamente aos 40. [Fontes: R14]

A — Incorreta: Não se rastreia indiscriminadamente homem de 40 anos.

B — Incorreta: Não se rastreia indiscriminadamente mulher de 40 anos.

C — Incorreta: Pós-menopausa isolada não impõe DXA no primeiro ano.

D — Correta: Mulheres com >=65 anos têm indicação etária de rastreio.

QUESTÃO 200 — RESPOSTA: D

Fundamento: Fratura intra-articular desviada busca redução anatômica para restaurar congruência e reduzir artrose pós-traumática; há exceções individualizadas. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Desvio não acelera consolidação por regra.

B — Incorreta: Consolidação clínica costuma preceder radiográfica completa.

C — Incorreta: Nem toda fratura desviada exige cirurgia.

D — Correta: Fratura articular com desvio busca restauração anatômica.

QUESTÃO 201 — RESPOSTA: B

Fundamento: Heparina não fracionada em uso prolongado aumenta reabsorção óssea/risco de osteoporose. [Fontes: R4, R14]

A — Incorreta: Tiazídicos não são causa clássica de osteoporose.

B — Correta: Heparina prolongada pode reduzir massa óssea.

C — Incorreta: Loratadina não se associa tipicamente à perda óssea.

D — Incorreta: Carvedilol não é causa usual.

QUESTÃO 202 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: C

Fundamento: Deformidade em varo descreve ápice lateral (C), mas o caso original está truncado e a pergunta não explicita sua solicitação. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Plano anterior não corresponde a varo.

B — Incorreta: Vértice em varo fica lateral, não medial.

C — Defensável: O ápice lateral é compatível com angulação em varo.

D — Incorreta: Plano posterior não corresponde a varo.

QUESTÃO 203 — RESPOSTA: B

Fundamento: FABER/Patrick pode reproduzir dor sacroilíaca; Tinel e Phalen investigam neuropatias. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Tinel é teste de percussão nervosa.

B — Correta: FABER pode provocar dor sacroilíaca.

C — Incorreta: Phalen testa túnel do carpo.

D — Incorreta: Thompson avalia tendão calcâneo.

QUESTÃO 204 — RESPOSTA: C

Fundamento: VHS depende predominantemente das proteínas de fase aguda, sobretudo fibrinogênio, que aumentam agregação eritrocitária. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Haptoglobina é proteína inflamatória, não determinante principal da VHS.

B — Incorreta: Amiloide A é reagente de fase aguda, sem determinar diretamente sedimentação.

C — Correta: Fibrinogênio promove empilhamento/rouleaux de hemácias.

D — Incorreta: Albumina reduz em inflamação e não aumenta VHS por si.

QUESTÃO 205 — RESPOSTA: C

Fundamento: Nefrite lúpica proliferativa difusa (classe IV) é comum em séries biopsiadas e clinicamente grave; biópsia frequentemente é indicada. [Fontes: R15]

A — Incorreta: Anticoagulante lúpico não é necessário para nefrite ativa.

B — Incorreta: Nefrite lúpica é manifestação frequente/clinicamente relevante.

C — Correta: Classe IV proliferativa é frequente em amostras biopsiadas.

D — Incorreta: Proteinúria relevante é indicação de biópsia, não contraindicação geral.

QUESTÃO 206 — RESPOSTA: A

Fundamento: Entesite calcânea/plantar é manifestação típica de espondiloartrites. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Entesopatia de calcâneo é clássica de espondiloartrites.

B — Incorreta: Poliartrite simétrica pequena lembra AR.

C — Incorreta: Uveíte anterior, não coriorretinite, é a manifestação ocular típica.

D — Incorreta: Comprometimento periférico costuma predominar em grandes articulações dos membros inferiores.

QUESTÃO 207 — RESPOSTA: C

Fundamento: Uveíte anterior aguda unilateral e recorrente é manifestação extra-articular clássica de espondiloartrite. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Instabilidade atlantoaxial é mais ligada à AR.

B — Incorreta: HLA-B27, não anti-CCP, é associação genética típica.

C — Correta: Uveíte anterior unilateral recorrente é clássica.

D — Incorreta: Oligoartrite assimétrica de MMII, não MMSS, é típica.

QUESTÃO 208 — RESPOSTA: D

Fundamento: Herring C indica colapso superior a metade da altura do pilar lateral na doença de Perthes. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Tipo A preserva altura do pilar.

B — Incorreta: Tipo B preserva pelo menos 50% de altura, não achatamento fixo de 70%.

C — Incorreta: Tipo B não é definido como perda fixada em 60%.

D — Correta: Tipo C tem colapso superior a 50%.

QUESTÃO 209 — RESPOSTA: D

Fundamento: Glicocorticoides tópicos e inalatórios podem causar efeitos sistêmicos quando em doses altas/prolongados, embora risco costume ser menor que por VO. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Meloxicam e nimesulida possuem preferência relativa por COX-2, não mesma não seletividade universal.

B — Incorreta: AINE COX-2 pode causar injúria renal e exige monitorização contextual.

C — Incorreta: Baixas doses sistêmicas crônicas também causam osteoporose.

D — Correta: Absorção sistêmica de tópico/inalatório pode causar eventos adversos, embora menor.

QUESTÃO 210 — RESPOSTA: C

Fundamento: Fratura exposta exige precocemente antibióticos e desbridamento; classificação Gustilo também avalia contaminação e dano de partes moles. [Fontes: R8, R16]

A — Incorreta: Gustilo avalia tamanho e, crucialmente, dano/contaminação de tecidos.

B — Incorreta: Pulso ausente sugere lesão vascular e pode implicar tipo IIIC.

C — Correta: Infecção é complicação importante, prevenível por cuidado precoce.

D — Incorreta: Tempo decorrido não indica conduta conservadora padrão.

QUESTÃO 211 — RESPOSTA: B

Fundamento: Fotossensibilidade, rash malar, citopenias e proteinúria sugerem LES; ANA nuclear homogêneo é padrão compatível, não específico. [Fontes: R15]

A — Incorreta: Pontilhado fino é inespecífico e pode ocorrer em outras doenças.

B — Correta: Padrão homogêneo é compatível com anti-DNA/anti-histonas no LES.

C — Incorreta: Pontilhado fino denso isolado é pouco sugestivo de LES.

D — Incorreta: Centromérico é associado a esclerose sistêmica limitada.

QUESTÃO 212 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: A

Fundamento: Apesar de IMC informado como 23 (sem obesidade), bengala pode aliviar carga e dor nos joelhos; a alternativa sobre controle do peso afirma obesidade inexistente. [Fontes: R3]

A — Defensável: Bengala pode reduzir sobrecarga e facilitar marcha.

B — Incorreta: Artroplastia bilateral imediata não é primeira conduta.

C — Incorreta: A paciente tem IMC 23, portanto não se pode afirmar obesidade.

D — Incorreta: Corticoide sistêmico não trata adequadamente artrose crônica.

QUESTÃO 213 — RESPOSTA: C

Fundamento: Radiografias AP e perfil são incidências iniciais padrão para fratura dos ossos da perna, incluindo articulações próximas conforme necessidade. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Oblíquas não são obrigatórias na rotina inicial.

B — Incorreta: Axial do tornozelo é exame específico, não rotina da perna toda.

C — Correta: AP e perfil são incidências iniciais apropriadas.

D — Incorreta: Axial de patela não é para tíbia/fíbula em geral.

QUESTÃO 214 — RESPOSTA: D

Fundamento: Musculação (resistência progressiva) auxilia densidade óssea, força e prevenção de quedas. [Fontes: R14]

A — Incorreta: Hidroginástica melhora função mas menor carga axial.

B — Incorreta: Natação não é exercício de sustentação de peso.

C — Incorreta: Alongamento é importante mas não maior estímulo ósseo.

D — Correta: Treinamento resistido progressivo favorece osso e músculo.

QUESTÃO 215 — RESPOSTA: A

Fundamento: Sacral, trocantérica e isquiática são regiões de proeminência óssea comuns para lesões por pressão. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Sacro, trocânter e ísquio são áreas clássicas.

B — Incorreta: Joelhos não são entre os principais locais na maioria dos acamados.

C — Incorreta: Nuca pode sofrer pressão mas menos que sacro/ísquio.

D — Incorreta: Face e ombro não são topografias principais habituais.

QUESTÃO 216 — RESPOSTA PROVÁVEL, COM RESSALVA: C

Fundamento: Fixação com placa e parafusos é uma opção técnica para fratura diafisária tibial; enunciado contém lacunas que impedem certeza sobre o pretendido. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Tíbia fratura com frequência em ambos sexos, dados ausentes.

B — Incorreta: Tratamento conservador existe em casos selecionados.

C — Defensável: Placa/parafusos são opção reconhecida.

D — Incorreta: Lesões ligamentares do joelho podem acompanhar trauma de tíbia.

QUESTÃO 217 — RESPOSTA: B

Fundamento: Paralisia cerebral resulta de lesão/distúrbio não progressivo do cérebro em desenvolvimento; manifestações motoras podem mudar com o crescimento. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Lesão de PC não é evolutiva por degeneração progressiva.

B — Correta: Cérebro imaturo com lesão não progressiva é definição.

C — Incorreta: Não é necessariamente processo piramidal progressivo.

D — Incorreta: Comprometimento intelectual não ocorre obrigatoriamente em 85%.

QUESTÃO 218 — RESPOSTA: D

Fundamento: Fraturas do colo femoral mesmo estáveis em geral requerem avaliação e frequentemente fixação; conservador não tem bons resultados universais. [Fontes: R9]

A — Incorreta: Fixação em jovens e artroplastia em idosos selecionados é conduta geral.

B — Incorreta: Risco de necrose e pseudoartrose do colo é elevado.

C — Incorreta: Garden I/II menos desviadas, III/IV desviadas.

D — Correta: Mesmo estáveis, muitas fraturas do colo são fixadas cirurgicamente.

QUESTÃO 219 — RESPOSTA: A

Fundamento: Mediano fornece sensibilidade palmar a polegar, indicador, médio e metade radial do anelar. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Polegar, indicador, médio e metade radial do anelar correspondem ao mediano.

B — Incorreta: Inclui todo anelar e exclui polegar, incorreto.

C — Incorreta: Polegar não é poupado na síndrome do túnel do carpo.

D — Incorreta: Quinto dedo é território predominantemente ulnar.

QUESTÃO 220 — RESPOSTA: C

Fundamento: A maioria dos casos de gota tem hipoexcreção renal de urato. [Fontes: R2]

A — Incorreta: Excesso alimentar contribui, mas hipoexcreção predomina.

B — Incorreta: Hiperprodução por turnover celular não é causa mais comum da gota primária.

C — Correta: Hipoexcreção renal é principal mecanismo.

D — Incorreta: Ausência HGPRT produz condição genética rara.

QUESTÃO 221 — RESPOSTA: A

Fundamento: Síndrome do túnel do carpo envolve os três primeiros dedos e metade radial do quarto dedo. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Correta: Distribuição sensitiva clássica do mediano.

B — Incorreta: Quarto dedo íntegro não pertence integralmente ao mediano.

C — Incorreta: O polegar é afetado, não poupado.

D — Incorreta: Quinto dedo não é território predominante do mediano.

QUESTÃO 222 — RESPOSTA: C

Fundamento: Dor mecânica no joelho, rigidez curta e crepitação favorecem osteoartrite. [Fontes: R3]

A — Incorreta: AR cursa rigidez prolongada e sinovite inflamatória.

B — Incorreta: CPPD pode imitar artrose, porém não é hipótese principal sem cristais/calcificações.

C — Correta: Dor mecânica, crepitação e rigidez curta sugerem artrose.

D — Incorreta: Condromalácia patelar é mais focal e anterior.

QUESTÃO 223 — RESPOSTA: D

Fundamento: AR afeta articulações pequenas, pode ter FR/VHS elevados; coluna lombar não é manifestação articular usual (ao contrário da cervical). [Fontes: R1]

A — Incorreta: Erosões podem ocorrer em AR, geralmente marginais/justarticulares.

B — Incorreta: FR positivo é esperado, embora não obrigatório.

C — Incorreta: VHS pode elevar em AR ativa.

D — Correta: Coluna lombar não é sítio habitual da AR.

QUESTÃO 224 — RESPOSTA: B

Fundamento: Citopenias múltiplas, úlceras orais e proteinúria com sintomas sistêmicos sugerem LES; pesquisar ANA e anti-dsDNA. [Fontes: R15]

A — Incorreta: AR isolada não explica bem citopenias e proteinúria.

B — Correta: LES pode explicar úlceras, pancitopenia e rim.

C — Incorreta: Sjögren não é hipótese principal com citopenias importantes.

D — Incorreta: Hepatites/crioglobulinemia são diferenciais, mas LES reúne melhor quadro.

QUESTÃO 225 — RESPOSTA: A

Fundamento: Catabolismo condrocitário na osteoartrite reduz proteoglicanos e aumenta degradação por metaloproteinases. [Fontes: R3]

A — Correta: Catabolismo diminui produção/depósito de proteoglicanos.

B — Incorreta: Metaloproteinases aumentam na degradação, não diminuem.

C — Incorreta: Inibição do plasminogênio não é alteração principal escolhida.

D — Incorreta: Síntese de colágeno normal não cresce de modo protetor nessa fase.

QUESTÃO 226 — RESPOSTA: C

Fundamento: Testes de Jobe e Patte avaliam respectivamente supraespinhal e infraespinhal; Neer/Hawkins avaliam impacto. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Neer e Hawkins avaliam impacto, não integridade tendínea específica.

B — Incorreta: Palm-up/Yergason avaliam tendão bicipital.

C — Correta: Jobe e Patte testam funções de tendões do manguito.

D — Incorreta: Gerber testa subescapular, mas Yocum avalia impacto.

QUESTÃO 227 — RESPOSTA: C

Fundamento: Finkelstein provoca dor do primeiro compartimento extensor, compatível com tenossinovite de De Quervain. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Thompson é ruptura do tendão de Aquiles.

B — Incorreta: Tinel é percussão de nervo periférico.

C — Correta: Finkelstein provoca dor no primeiro compartimento extensor.

D — Incorreta: Cozen é para epicondilite lateral.

QUESTÃO 228 — RESPOSTA: A

Fundamento: Anti-dsDNA e anti-Sm têm especificidade importante para LES, sobretudo anti-Sm; outros diagnósticos não correspondem. [Fontes: R15]

A — Correta: Anti-dsDNA/anti-Sm são relacionados ao LES.

B — Incorreta: Behçet não possui essa assinatura autoanticorpo.

C — Incorreta: Doença mista associa anti-U1-RNP.

D — Incorreta: Dermatomiosite tem anti-Mi2, MDA5 etc., não anti-Sm típico.

QUESTÃO 229 — RESPOSTA: D

Fundamento: Expansão tecidual pode causar adelgaçamento dérmico, hiperplasia epidérmica e cápsula fibrosa ao redor do expansor. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Expansão pode reduzir espessura dérmica.

B — Incorreta: Epiderme pode espessar com estímulo expansivo.

C — Incorreta: Cápsula fibrosa peri-expansor é resposta comum.

D — Correta: Três fenômenos podem coexistir.

QUESTÃO 230 — RESPOSTA: C

Fundamento: Expansão de couro cabeludo recruta pele com folículos para reconstrução da alopecia. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Expansão exige procedimentos cirúrgicos e preenchimentos.

B — Incorreta: São necessárias consultas repetidas para insuflação.

C — Correta: A pele expandida adjacente contém folículos pilosos.

D — Incorreta: Técnica não é imediata, exige semanas.

QUESTÃO 231 — RESPOSTA: C

Fundamento: Déficit neurológico em fratura explosão sugere dano neural e potencial instabilidade; avaliar complexo ligamentar posterior e morfologia por imagem. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Cifose >10° isolada não é critério definitivo de instabilidade.

B — Incorreta: Acunhamento significativo e eixo precisam contexto ligamentar.

C — Correta: Déficit neurológico sugere gravidade e potencial instabilidade.

D — Incorreta: Coluna média está comprometida na fratura explosão, mas isoladamente não determina classificação contemporânea.

QUESTÃO 232 — RESPOSTA: C

Fundamento: PRICE significa Protection, Rest, Ice, Compression e Elevation; I representa gelo, não imobilização. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: P é proteção.

B — Incorreta: R é repouso relativo.

C — Correta: I é ice (gelo), não imobilização.

D — Incorreta: C é compressão.

QUESTÃO 233 — SEM ALTERNATIVA INEQUIVOCAMENTE CORRETA

Fundamento: Controle atual de sangramento grave usa pressão direta e torniquete precoce se necessário; pinçamento cego de cotos e compressão arterial proximal em sequência obrigatória são inadequados. [Fontes: R8]

A — Em análise: Pinçamento de cotos antes do torniquete não é rotina segura.

B — Em análise: Elevação/pressão proximal não devem atrasar compressão ou torniquete.

C — Em análise: Pinçamento cego e elevação ao fim são inadequados.

D — Em análise: Ainda usa sequência ultrapassada; torniquete pode ser aplicado precocemente no sangramento ameaçador.

QUESTÃO 234 — RESPOSTA: C

Fundamento: Cicatriz hipertrófica fica elevada e eritematosa dentro dos limites da incisão; queloide ultrapassa as bordas. [Fontes: Referências gerais ao final]

A — Incorreta: Queloide ultrapassa as bordas da ferida.

B — Incorreta: Tumor desmoide não aparece como cicatriz limitada usual.

C — Correta: Cicatriz hipertrófica fica limitada à incisão.

D — Incorreta: Carcinoma basocelular não condiz com cicatriz pós-operatória de 90 dias.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

As referências abaixo sustentam os princípios clínicos relevantes. São diretrizes e fontes gerais, não equivalendo à validação de cada caso individual. Algumas classificações históricas da prova possuem atualizações posteriores.

R1. ACR. Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis (2021).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9273041/

R2. ACR. Guideline for the Management of Gout (2020).
https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.41247

R3. ACR/Arthritis Foundation. Osteoarthritis Guideline (2019).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11488261/

R4. ACR. Glucocorticoid-Induced Osteoporosis Guideline (2022).
https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acr.25240

R5. EWGSOP2. Sarcopenia: revised European consensus (2019).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6322506/

R6. American Geriatrics Society. Beers Criteria (2023).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12478568/

R7. NICE NG97. Dementia: assessment, management and support.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng97/chapter/recommendations

R8. AO Surgery Reference. Principles of management of open fractures.
https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/adult-trauma/further-reading/principles-of-management-of-open-fractures

R9. AAOS. Management of Hip Fractures in Older Adults.
https://www.aaos.org/hipfxcpg

R10. NICE NG12. Suspected Cancer: soft tissue sarcoma referral.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/chapter/recommendations-organised-by-site-of-cancer

R11. Wolfe et al. Fibromyalgia criteria 2016 (Endotext/NCBI).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279092/table/fibromyalgia.T.2016_revisions_to_the_201/

R12. CDC STEADI. Coordinated Care Plan to Prevent Older Adult Falls.
https://cdc.gov/steadi/pdf/Steadi-Coordinated-Care-Plan.pdf

R13. NICE NG59. Low back pain and sciatica: assessment and management.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng59/chapter/recommendations

R14. International Osteoporosis Foundation. Diagnosis and DXA T-scores.
https://www.osteoporosis.foundation/patients/diagnosis

R15. EULAR. 2023 recommendations for management of SLE.
https://ard.bmj.com/content/early/2023/10/11/ard-2023-224762?versioned=true

R16. Gustilo-Anderson Classification, review (PMC).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3462875/